

序

为了系统介绍中西医结合防病治病的新方药、新经验，以适应广大城乡基层医务人员提高医疗技术及医学业余爱好者学习卫生保健知识的需要，我所贾河先医师继编写《百病良方》第一、二集之后，又编写了《百病良方》第三集。

《百病良方》第一、二集问世后，以其内容翔实、观点新颖、文笔流畅、实用性强等而得到广大读者的好评，初版告罄，又重印发行，并参加了1985年香港“中国书展”，受到了海内外读者的信任和鼓励。

《百病良方》第三集仍按分科分病症列题，辨病与辨证结合，以介绍现代有效的中医治疗方法的体例方式进行编写，简明扼要地阐明一百种病症的定义、发病机制、病理变化、临床表现和诊断要点，以及中医相应的病证名称、病因病机认识、治疗原则和治疗方法。保持了第一、二集的优点和特色。同时，加重了中医部分的比例，特别是充实了治疗方法的内容。一个病症列举了多个治疗方剂；对每个方剂，指出了适应症、应用要点、注意事项和药物随证加减方法，有的方药还介绍了药理作用和疗效机制，以适应同病异证的不同病情，便于读者掌握、选择应用。本集增添了针灸、推拿、火罐、食物疗法和生活调摄等内容，把治病之“方”从狭义的方剂扩大到包括方剂在内的多种治疗“方法”，发挥了中医综合治疗的传统优势，有利于提高临床疗效，其可读性、实用性也因之增强。

中华全国中医学会重庆分会副会长
重庆市中医研究所所长 郭铭信

1986年2月20日

目 录

内 科

1. 胆汁返流性胃炎… (1)
2. 胃扭转…………… (3)
3. 神经性呕吐………… (4)
4. 食管贲门失弛缓
 症(贲门痉挛)… (6)
5. 肝脓疡…………… (8)
6. 急性胰腺炎………… (10)
7. 慢性胰腺炎… …… (12)
8. 功能性腹泻………… (13)
9. 霉菌性肠炎………… (15)
10. 滴虫性肠炎………… (16)
11. 肠粘连…………… (17)
12. 肾病综合征………… (19)
13. 紫癜性肾炎………… (23)
14. 肾绞痛…………… (25)
15. 射精不能症… …… (27)
16. 精液不液化症… …… (29)
17. 缺无精子症… …… (30)
18. 精囊炎(血精)… …… (23)
19. 真性红细胞增多症
 …………… (33)
20. 原发性血小板增多
 症…………… (36)
21. 病毒性心肌炎…… (37)
22. 慢性房室传导阻滞
 …………… (40)
23. 冠状动脉痉挛心绞
 痛…………… (42)
24. 急性心肌梗塞…… (44)
25. 慢性心力衰竭…… (47)
26. 病态窦房结综合征
 …………… (49)
27. 无脉症…………… (52)
28. 心脏神经官能症… (54)
29. 心房纤颤…………… (57)
30. 短暂性脑缺血发作
 …………… (58)
31. 颈椎病…………… (60)
32. 植物神经功能紊乱
 …………… (66)
33. 腓肠肌痉挛………… (69)
34. 周期性精神病…… (70)
35. 肋间神经痛………… (71)
36. 不宁腿综合征…… (72)

37. 麻痹性斜视 (眼肌
麻痹) (74)
38. 周围性面神经麻痹
..... (77)
39. 面肌痉挛 (81)
40. 震颤麻痹 (83)
41. 周期性麻痹 (低血
钾型) (84)
42. 血卟啉病 (血紫质
病) (86)
43. 痛风 (88)

44. 男性乳房增大症... (90)
45. 男性更年期综合征 (92)
46. 变态反应性亚败血
症 (94)
47. 自发性气胸 (96)
48. 单纯性甲状腺肿... (97)
49. 链霉素毒副反应... (98)
50. 慢性苯中毒 (99)
51. 矽肺 (100)
52. 放射性直肠炎 (101)

妇 产 科

53. 放环后月经失调... (103)
54. 蜕膜样痛经 (104)
55. 输卵管阻塞 (105)
56. 多囊卵巢综合征... (106)
57. 盆腔淤血症 (108)
58. 女性生殖道结核... (110)
59. 子宫肌瘤 (111)
60. 乳房纤维瘤 (113)
61. 奶痂 (113)

儿 科

62. 进行性肌营养不良
症 (115)
63. 儿童多动症 (117)
64. 小儿秋季腹泻 (118)
65. 新生儿硬肿症 (119)

外科、皮肤科

- | | |
|----------------------------|--------------------|
| 66. 腱鞘囊肿……………(121) | 78. 尖锐湿疣……………(138) |
| 67. 非化脓性肋软骨炎
……………(122) | 79. 玫瑰糠疹……………(139) |
| 68. 落枕……………(124) | 80. 生漆过敏性皮炎…(140) |
| 69. 直肠息肉……………(125) | 81. 雀斑……………(141) |
| 70. 睾丸鞘膜积液……(127) | 82. 寒冷性多形红斑…(142) |
| 71. 网球肘……………(128) | 83. 面部黄褐斑…………(144) |
| 72. 足跟痛……………(129) | 84. 鱼鳞病……………(146) |
| 73. 关节腔积液…………(131) | 85. 皮肤划痕症…………(148) |
| 74. 膝关节结核…………(133) | 86. 剥脱性皮炎…………(148) |
| 75. 褥疮……………(135) | 87. 剥脱性唇炎…………(151) |
| 76. 乳头皲裂……………(136) | 88. 植物日光性皮炎…(152) |
| 77. 疥疮……………(137) | 89. 隐翅虫皮炎…………(153) |
| | 90. 稻田皮炎……………(154) |

五官科

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| 91. 急性会厌炎…………(157) | 97. 下颌关节功能紊乱
症……………(164) |
| 92. 声带息肉……………(158) | 98. 口腔扁平苔癣……(166) |
| 93. 声带结节……………(159) | 99. 干槽症……………(167) |
| 94. 鼻出血……………(160) | 100. 复发性口腔溃疡
……………(168) |
| 95. 鼻息肉……………(161) | |
| 96. 牙周病……………(162) | |

1. 胆汁返流性胃炎

胆汁返流性胃炎，系幽门功能不全或胃切除术后胆汁返流入胃，胆酸破坏了胃粘膜屏障，导致胃粘膜充血、水肿、发炎、糜烂、甚至溃疡的一种浅表性炎症。

胆汁返流性胃炎的临床症状有：胃脘部堵闷，暖气，恶心呕吐，口苦，上腹部轻度压痛，有的伴有泛酸、胃脘部灼热等症。

胆汁返流性胃炎须通过胃镜检查等确诊。

胆汁返流性胃炎属祖国医学“胃反”、“呕吐”、“胃脘痛”、“胆倒”等范畴。

祖国医学虽无“胆汁返流性胃炎”的病名，但对于胆汁可以上犯于胃引起胃脘部疼痛的病机却早有认识。《内经》云：“邪在胆，逆在胃，胆液泄则口苦，胃气逆则呕吐。”《金匱要略》云：“胃反呕吐者，大半夏汤主之”。《医学衷中参西录》云：“有因‘胆倒’而呕吐不止者，呕吐苦水，服用温胆汤加枣仁、代赭石，以正其胆腑，一服即止”。中医认为，胆为六腑之一，宜通宜降，其通全借肝气之疏泄。其降有赖胃气之下行，胆汁才顺势下降。中医还认为“胆位于胁，随胃气下行，胃气上逆，胆无下行之路”，湿旺胃气更逆，愈阻胆经降路，胆邪上犯于胃，引起胃脘堵闷疼痛。治宜降逆导滞，疏利三焦。

方一：苏梗10克，香附12克，陈皮10克，大腹皮10克，槟榔10克，莱菔子10克，山楂10克，神曲10克，麦芽10克，连翘10克，黄连3克。水煎服。每日一剂，连服一个月为一疗程。

加減：濕重加半夏；熱重加半枝蓮；痰重加全瓜蒌；便結加酒軍；泛酸加左金丸（吳萸、黃連）；兼淤加失笑散（生蒲黃、五靈脂）。

本方適用於肝胃氣滯型胆汁返流性胃炎患者，症狀有口苦、胸痛、噯氣、脘悶等。

方二：黨參30克，白朮12克，干姜10克，茯苓15克，陳皮12克，法半夏12克，吳萸10克，蘇梗10克，補骨脂10克，代赭石30克，藿香12克。水煎服。

本方適用於脾胃虛寒型的胆汁返流性胃炎患者。症狀有：嘔吐苦水，胃脘冷痛，脘腹脹悶，喜按喜熱等。

方三：沙參30克，麥冬30克，石斛10克，白芍30克，旋覆花10克，代赭石30克，竹茹12克，蒲公英20克，法半夏12克，枳殼10克。水煎服。

本方適用於胃陰不足型胆汁返流性胃炎患者。症狀有：嘔吐苦水，胃脘灼痛，腹脹，口干，大便秘結等。

方四：黨參30克，白朮12克，茯苓12克，陳皮12克，法半夏12克，白蔻仁10克，蒲公英30克，旋覆花10克，代赭石30克，炮姜6克。水煎服。

本方適用於膽邪犯胃型胆汁返流性胃炎，症狀有：泛酸，噯氣，惡心嘔吐，脘悶等。

方五：黃芪30克，白芍30克，黨參20克，香附12克，郁金20克，茯苓15克，柴胡12克，枳殼15克，半夏15克，良姜10克，莪朮10克，玄胡10克，吳萸6克，甘草6克。水煎服。

加減：潰瘍加海螵蛸、兒茶、大貝母；伴食道炎加黃芩；伴出血加白芨、三七粉。

本方適用於氣滯夾虛型胆汁返流性胃炎。症狀有：乏力，脘悶，腹脹痛，口苦等。

2. 胃 扭 转

胃扭转常见为器官轴型胃扭转，以贲门与幽门为二个固定点，连成纵轴，由于胃韧带松弛，胃体沿此轴转动，活动过甚时，则发生扭转。临床表现以呕吐为主，食后呕吐，胃脘胀满，疼痛，甚则绞痛，或频繁干呕，或呕吐清水痰涎，呃逆，暖气，常叹息，食欲不振，咽喉不利。作X线钡餐检查可以确诊。

胃扭转属祖国医学“胃挛急”、“拘急”、“拘挛”等范畴。

多由情志不遂，肝郁化火，耗伤阴血，导致筋脉失养。或由于脾虚中满，寒湿阻滞，升降失调所致。治宜养阴和营，缓急止痛，补气健脾，理气降逆。

方一：白芍60克，炙甘草20克。加水浓煎，频服，每日一剂。

注：方中白芍、甘草均须重用，否则无效。

方二：党参30克，白术12克，茯苓15克，法夏半12克，陈皮12克，厚朴12克，枳壳12克，台乌10克，木香10克，砂仁10克，丁香10克。水煎服。

方三：黄芪30克，柴胡10克，升麻10克，桔梗10克，枳壳10克，木香10克，白术12克，神曲12克，炒麦芽12克，炙甘草6克。水煎服。

方四：黄芪60克，白芍60克，甘草15克，党参15克，半夏15克，防风10克，羌活10克，独活10克，茯苓6克，白术6克，柴胡6克，泽泻6克，黄连3克。水煎服。

方五：谷芽30克，麦芽30克，大枣30克，生姜10克，饴糖15克，柴胡12克，升麻10克，桂枝12克，党参30克，黄芪

30克，白术10克，枳壳12克，白芍15克。水煎服。

方六：冠心苏合丸(成药)，每次服6克，每日服3次。

按：冠心苏合丸为治疗心肌梗塞、心绞痛的验方。方中苏合香具有解郁开窍、豁痰辟秽之功。檀香、青木香、乳香辛温理气，和血止痛。因其集诸香于一方之内，辛香温散，开寒痰，散淤结，效峻力宏。且丸者意缓以制峻，不致太过，恰与胃扭转病机相合，疏气令调，故能获效。

除了以上药物治疗的方法之外，还应做到少吃多餐，睡右侧卧位，以助胃体自转复位。每次饭后患者体位向右下方倾斜震颤、爬行，轻轻敲打背腹部，并采取推拿（天枢、中脘、足三里、胃俞等穴位）、拔火罐（中脘穴），针灸等综合治疗措施。

针灸疗法

主穴：足三里。配穴：内庭、膈俞、内关、中脘、脾俞、胃俞。

针灸时穴位必须先作常规消毒，然后快速进针，均行泻法，得气后持续捻针20—30分钟，然后减慢捻针幅度，边捻边退于皮下，快速出针。每天针一次。

针刺前须静脉注射50%葡萄糖液60毫升。在针刺中或针刺后有出汗、恶心呕吐、畏寒等症状发生时，也可静脉注射葡萄糖液。

3. 神经性呕吐

神经性呕吐属于胃神经官能症的一种症状，是神经功能紊乱在胃肠道的表现。多有精神因素为背景，没有器质性病变。除了胃肠道症状外，常伴有头痛、失眠、健忘、焦

虑、注意力不集中、神经过敏等其他官能性症状。

神经性呕吐往往在饮食后，突然发生呕吐，一吐即出，不费力，呕吐量不多，呕吐后还可以再吃东西。不呕吐的时候一如常人，当受到一些暗示，也可突然发生呕吐，当看到某种印象不好的食物或药物，也可突然发生呕吐，有的病人甚至看到类似蛇样的草绳，也能引起呕吐。因此，神经性呕吐也叫癔病性呕吐。

神经性呕吐，虽无器质性病变，但时愈时患，以多种刺激为诱因，反复发作，往往经久不愈，影响健康和工作，给病人造成莫大苦恼。

祖国医学认为，有声有物谓之呕，有物无声谓之吐，呕与吐常同时并见。胃以和为安，以降为顺，喜润恶燥厌秽浊。内伤外感均可引起胃气上逆，导致呕吐。若情志抑郁，肝失条达，也易引起呕吐。《内经》说：“怒则气逆，甚者呕吐，……”因此，中医认为七情内伤是引起神经性呕吐的重要因素。治宜温肝暖胃，降逆止呕。

方一：吴茱萸10克，党参15克，生姜10克，大枣12克，法半夏15克，茯苓15克。水煎服。

加减：头痛加川芎、白芷；苔厚腻加藿香、佩兰；生气发怒胁胀，加香附；口干加沙参、麦冬。

方二：代赭石30克，法半夏12克，陈皮10克，当归10克，茯苓15克，朱砂1克（冲服），白芥子10克，黑白丑各3克，琥珀粉3克。水煎服。

加减：腹胀纳差加莱菔子、生麦芽；腹痛加乳香、没药；乏力减黑白丑，重用党参。

注：方二以病好即止，不可久服。

针灸疗法

取穴：内关(双)，中等刺激，留针20分钟。

针灸治疗神经性呕吐有很好的疗效，但必须在刚进食后立即针刺内关，掌握这个时机非常重要，否则疗效不佳。

推拿疗法

方法1. 病人俯卧，医生用双手的四个手指并置于胸骨上璇玑穴处，逐步向下点按至中庭穴止。反复操作2—3分钟。点按时，应伴随患者呼吸，呼气时用力点按。操作时应用力均匀、缓慢而着力，使患者胸部有一紧一松的压迫感。治疗过程中应避免谈笑。

此疗法有宽胸利膈，和胃止呕的作用。

方法2. 病人俯卧，医生站在病人头部前方，以两手拇指分置脊椎两侧大杼穴平高处，其余两手的四指分别固定于两腋下，由上向下呈直线挤推脊椎两侧之骶棘肌至膈俞穴平高处止。反复操作3—5分钟。挤推时，应将两侧肌肉由外向内挤起，缓慢向前推动。挤推后，可在背部作轻柔的抚摩，以消除挤推的不适感。

此法健脾胃，止呕吐，补虚损。

4. 食管贲门失弛缓症(贲门痉挛)

食管贲门失弛缓症，又称贲门痉挛，是血管神经肌肉功能障碍所致的一种疾病。其主要特征是吞咽食物时食管下端括约肌不能正常松弛，以致食物不能顺利通过。

本病症状：胸骨下梗塞疼痛(闷痛、灼痛、针刺痛、锥刺痛)，进热饮或舌下含硝基甘油片，疼痛可以缓解，进干食时吞咽不畅，甚至发生食物反流。由于吞咽困难，影响食

物的摄取，时间一久(病程有长达数十年的)，可引起体重减轻。有的患者可有贫血、干咳、气急、紫绀、呃逆、声音嘶哑等症状。

本病可通过X线检查确诊。

贲门失弛缓症属祖国医学“噎膈”范畴。中医认为系气郁日久，耗伤阴津，胃失滋润顺降所致。治宜养阴润燥，柔肝解郁，益胃降逆。

方一：北沙参15克，丹参15克，玄参15克，川贝母10克，白芍10克，佛手片10克，全瓜蒌10克，郁金10克，荷蒂10克，甘草10克，代赭石30克。水煎服。

方二：黄芪30克，猪食管两根，共放砂锅内，加水2000毫升，文火烧煮一小时，取汤分早、中、晚三次温服。服药期间只进半流质饮食，忌食辛辣，忌饮酒。

方二可作为贲门失弛缓症的辅助治疗。

本病患者应少吃多餐，细嚼慢咽，不吃过冷过热的饮食，进食时多饮汤水(将食物冲下)。进食后伸直胸背部，用力深呼吸或擤气等，以协助咽下食物。

推拿疗法

方法1. 病人仰卧，医生站在病人头部前方，用右手手掌沿食管上下抚摩5—7分钟。操作应轻柔缓慢，用力均匀，患者要自由呼吸，不要紧张。

方法2. 病人直坐，医生站在病人侧边，医生用一只手的手掌心放在病人胸部，另一只手的手掌心放在病人的背部，沿食管上下抚摩，胸前背后同时抚摩5—7分钟。操作时应用力均匀而有节律。治疗后胸、背部有舒适感。

方法3. 病人直坐，医生站在病人后方，医生用双手提捏病人的肩部肌肉(用力捏着向上提)，用力大小以病人能耐受

为度。拿提后，可用手掌轻轻地揉几下肩部肌肉，以消除拿提后的不适感。治疗时局部有沉重、酸胀感，治疗后，肩膀、颈项、背部、上肢有轻松舒适感。

方法4. 病人仰卧或直坐。仰卧时下肢伸直，医生坐在病人的侧边，医生用食指（第二个手指）按揉病人下肢的足三里穴位，双下肢交替按揉5—7分钟，按揉用力不可过大，以病人能耐受为度。按揉完毕后，医生用双手捏住小腿沿膝关节向下抚摩，反复操作3分钟。抚摩小腿时用力宜轻而缓，以消除用手指按揉足三里穴的不适感。

治疗时局部有酸胀感，治疗后下肢有微热，轻松感，腹部有舒适感觉。

方法5. 病人直坐，医生用大指拇掐住病人手腕附近的内关穴，其余四指捏住外关穴，对按5—7分钟。以病人有酸胀感并能耐受为度。

5. 肝 脓 疡

肝脓疡又称肝脓肿，是一种肝脏感染性疾病。肝脓疡多数由金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等细菌侵犯所致。细菌侵入肝脏的途径以胆道为主，亦可由门静脉或淋巴系统侵入。蛔虫成虫可经输胆管入肝，或以幼虫经门静脉入肝，均可继发细菌感染而引起肝脓疡。或因败血症由血行播散至肝脏，引起肝脓疡。溶组织阿米巴亦可引起肝脓疡。

不论何种原因引起的肝脓疡，临床上大都有弛张性高热，寒战，出汗，全身不适，咳嗽，呕吐，右上腹胀痛与压痛，肝肿大，肝区叩击疼痛明显，伴有腹泻、厌食等症状。也有的持续性无规律高热达1—4个月之久。偶见黄疸或腹水。

实验室检查可见白血球总数升高，中性细胞升高，尿胆元高。X线检查、B型超声波检查可帮助诊断，肝脏试验性穿刺抽到脓液可以确诊。

肝脓疡属祖国医学“肝痈”范畴。中医认为外邪、寒热、饮食不节、精神刺激等因素使肝的条达功能失常，从而引起肝郁气滞，肝胆郁结，里热壅盛，热腐成脓。治宜解毒排脓。

方一：半边莲10克，半枝莲15克，白花蛇舌草30克，益母草30克，茵陈30克，败酱草30克，两面针根10克。水煎服。

本方原为抗癌药，近来发现其对肝脓疡有卓效。

方二：柴胡20克，黄芩15克，大黄12克，枳实10克，赤芍15克，丹皮15克，蒲公英30克，蚤休20克，紫花地丁30克，连翘15克，花粉10克，炙鳖甲15克。水煎服，每日一剂，连服15—30剂。

方中柴胡、黄芩和解少阳，大黄、枳实泻下热结，赤芍、丹皮凉血散瘀，蒲公英、蚤休、紫花地丁、连翘解毒排脓，花粉清热生津、降火润燥、排脓消肿，鳖甲软坚。诸药合用，共奏解毒排脓、软坚消积之功。

方三：生苡仁30克，冬瓜子30克，败酱草30克，柴胡15克，连翘15克，紫草15克，青皮10克，郁金10克，皂刺10克，山栀10克。水煎服。

加减：痛甚加元胡10克，川楝子10克，大便干加大黄12克；热甚加银花15克，板蓝根30克，阿米巴肝脓疡者，加白头翁15克、秦皮10克、黄连10克。另：鸦胆子8粒去壳取仁装胶囊内吞服，每日二次，14天为一个疗程。

6. 急性胰腺炎

急性胰腺炎是常见的急腹症之一。症状有：突然上腹部剧烈疼痛，痛处拒按，局部有压痛和反跳痛，伴有恶心、呕吐、巩膜黄染、发热、便秘等，尿淀粉酶测定在128u以上，白细胞总数超过1万以上。本病是由于胰腺急性炎症并伴随产生的酶类从胰细胞逸出到周围组织所引起的炎症（胰腺水肿、坏死和出血）。胆道蛔虫、结石、感染、手术等在本病的发生上起着重要作用。其次，发病的诱因有饱食、饮酒、精神因素、妊娠、过敏反应等。

祖国医学虽无胰腺炎这一病名，但有类似的症状记载，如《金匱要略》：“按之心下满痛者，此为实，当下之，宜大柴胡汤”。《伤寒论》：“结胸热实，脉沉而紧，心下痛，按之硬者，大陷胸汤主之”。“舌上燥而渴，日晡所小有潮热，从心下至少腹硬满而痛不可近者，大陷胸汤主之”。这些论述颇似胰腺炎的症状和体征。据其主要表现为突然上腹部剧痛、发热、呕吐、便秘等症状，属于中医“阳明腑实”、“肝胃不和”、“胃脘痛”等范畴。其发病原因常有饮食不节、情志失和，或蛔虫窜扰，导致肝胆脾胃功能紊乱，气机升降失调，湿邪阻于中焦而发病。气血淤滞，不通则痛，故腹痛拒按；肝胃不和，胃气上逆，则恶心呕吐；湿热内蕴，阻遏中焦，则腹胀满闷；腑气不通，营化失司，则便秘。由于急性胰腺炎以腑实疼痛为主证，根据“六腑以通为用”，“不通则痛”，“痛随利减”等理论，故治宜攻里通下，活血化淤，理气止痛。

“肝胃不和”、“胃脘痛”等范畴。其发病原因常有饮食不节、情志失和，或蛔虫窜扰，导致肝胆脾胃功能紊乱，气机升降失调，湿邪阻于中焦而发病。气血淤滞，不通则痛，故腹痛拒按；肝胃不和，胃气上逆，则恶心呕吐；湿热内蕴，阻遏中焦，则腹胀满闷；腑气不通，营化失司，则便秘。由于急性胰腺炎以腑实疼痛为主证，根据“六腑以通为用”，“不通则痛”，“痛随利减”等理论，故治宜攻里通下，活血化淤，理气止痛。

方一：大黄15克，芒硝15克（冲服），枳实10克，厚朴

15克，黄芩15克，黄柏15克，柴胡20克，广木香12克，白芍15克。水煎服。

加减：热重加银花、连翘 黄疸加茵陈、栀子，合并胆道蛔虫者加苦楝皮、槟榔、细辛；伴结石者加金钱草30克、海金沙10克，剧痛者加川楝子、元胡索各10克。

方二：紫花地丁30克，蒲公英30克，黄芩30克，丹皮12克，青皮10克，赤芍15克，柴胡15克，大黄12克，玄明粉（冲）12克。水煎服。

胰腺炎通过导腑攻下，“痛随利减”，病情趋向稳定，可遵循“一服利则止后服”的原则，于大便畅利后，即撤去攻下药，但疏利气机即可，以免劫阴伤正。

对于急性出血坏死型的休克病人，症见四肢厥冷，自汗淋漓，皮肤有淤紫斑，尿少，血压下降，脉细数，甚则呼吸急促，昏厥，症属危重阶段，必须采取中西医结合的抢救措施。

以现代医学观点分析，尽管急性胰腺炎的病因很复杂，但就其病理过程来说，不外乎梗阻、感染和循环障碍。有关资料表明，理气开郁的中药能显著减少胃液分泌量及游离酸度，从而可能使胰腺分泌减少，有利于胰腺组织恢复；另一方面，理气开郁药有利胆作用，可使奥狄氏括约肌松弛、开放，有利于解除胰管梗阻并减低其压力。清热解毒药有明显的广谱抗菌作用及减毒作用，有利于炎症消退。通里攻下药能增强肠蠕动，改善胃肠功能和毛细血管通透性，从而消除肠麻痹和淤滞状态。中药治疗急性胰腺炎的药理作用是多方面的、综合性的，很可能还有协同作用。

急性胰腺炎还可配合用针刺疗法治疗：腹痛剧烈针足三里、阳陵泉、内关，强刺激，每日1—2次。

在治疗期间，可给予流质食物或半流质饮食，不宜禁食。否则导致营养不良，气血不足，减低抗病能力，不利于疾病的治疗。中医认为“谷不入半日则气衰，一日则气少矣”。

7. 慢性胰腺炎

慢性胰腺炎只有少数是急性胰腺炎转变而成，大多数慢性胰腺炎的病因是慢性（长期）酒精中毒和长期饮食缺乏蛋白质食物。其次，胰管系统阻塞性疾病，甲状旁腺机能亢进症，结核，梅毒，十二指肠溃疡等疾病，也可引起慢性胰腺炎。

慢性胰腺炎的临床表现有腹痛，腹内（胰腺部位）可扪到块状物，黄疸，脂肪泻，肉质下泄，糖尿病等。

慢性胰腺炎属于中医的肝郁脾虚范畴。中医认为本病的发生与情志刺激、平素内脏阳虚、饮食不节、嗜酒等有关。证分虚实，虚证为脏气虚寒，气血不能温养所致；实证则因湿热，食积、气滞血淤等导致腑气通降失常，气血运行受阻，从而出现一系列相应的临床症状。治宜舒肝理气，健脾益气，活血化淤。

方一：柴胡15克，白芍15克，白术12克，茯苓12克，蒲公英30克，败酱草30克，红藤30克，枳实10克，玄胡索10克，蒲黄10克，五灵脂10克。水煎服。

方二：大黄10克，芒硝10克，枳实10克，柴胡15克，甘草10克，白芍12克，苡仁30克，香附12克，三棱10克，莪术10克。水煎服。

此方适用于大便干结之慢性胰腺炎患者。服药后可泻下酱黑色物，诸症减轻，再用健脾理气法调理。

推拿疗法

方法1. 病人仰卧，医生坐在病人侧边。医生用两手拇指、食指（或者用中指、食指）分置两侧髌骨上缘维道穴处，自上向下摩动经髌骨内缘府舍至气冲穴处，反复操作5—10分钟。

方法2. 病人仰卧或直坐，医生先用食指按揉足三里穴3—5分钟，再以四手指置小腿外侧自阳陵泉穴处向下至悬钟穴处止，抚摩1—2分钟。按揉足三里穴时，用力不可过大，以病人能耐受为度。

方法3. 病人仰卧，医生以掌心置病人神阙穴（脐中）上，以脐为中心，先作顺时针方向旋转团摩5—10分钟，再作逆时针方向旋转团摩5—10分钟。团摩时，手法宜轻揉且缓慢，向每一方向旋转团摩均应以腹部微汗为度。操作最好在饭后1小时施行。

8. 功能性腹泻

功能性腹泻是指以肠道功能失调为主的全身功能失调性疾病，习惯称为“肠功能紊乱”。患者往往经年累月反复发作，大便塘薄，呈水样，有时夹粘液、泡沫或不消化食物。伴有腹痛，病程多在2个月以上，且不呈进行性加剧，大便镜检红细胞、白细胞未超过正常范围，或培养阴性。

功能性腹泻多因精神紧张、情绪激动、饮食不节等所引起，症状时轻时重，治疗较为棘手。

功能性腹泻属于祖国医学“泄泻”、“痛泻”等范畴。中医认为“泄泻之本，无不由于脾胃”，“……脾胃受伤，则水反为湿，谷反为滞，精华之气，不能输化，致合污下降而泻

利作矣”。脾胃之所以不能腐熟水谷，输布精微，除脾胃本身之病外，肝木克伐亦系常见之病因。另一方面，脾胃之腐熟运化，须依赖肾阳之温煦，故肾阳虚衰也是脾运不健的重要原因。泄泻一病，中医常从肝、脾、肾三脏进行辨证论治。

一、肝旺脾虚：泄泻每因情志怫郁而复发，肠鸣腹痛，腹痛即泻，泻后缓解，脘痞胸闷，舌淡红，苔薄白，脉细弦。

方法：炒白术15克，白芍10克，防风10克，陈皮10克，茯苓10克，猪苓10克，木香10克，枳壳10克，川楝子10克，甘草6克。水煎服。

二、寒热夹杂，肝脾不调：腹泻日久，便下粘腻，或夹泡沫，或便秘与腹泻交替出现，便前腹痛，腹胀，肠鸣，解便后症状缓解，但不久又反复发作。舌质红，苔白腻，脉弦或细。

方药：乌梅10克，细辛6克，党参30克，炒白术12克，川椒6克，制附片10克（先熬），炮姜炭10克，黄连6克，黄柏10克，茯苓12克，甘草6克。水煎服。

三、脾胃虚弱：大便稀溏，胃纳不香，腹痛隐隐，面黄少华，倦怠乏力，舌淡苔白，脉细缓。

方药：党参30克，山药30克，炒白术12克，茯苓12克，炒扁豆15克，陈皮10克，砂仁6克，苡仁30克，炙升麻6克，柴胡6克，甘草6克。水煎服。

四、脾肾两虚：便下清稀，完谷不化，腰膝酸软，四肢不温，便后腹痛不减，舌淡胖，苔白，脉沉细迟。

方药：制附片10—30克（先熬），炒白术12克，炮姜炭12克，淡吴萸10克，肉豆蔻12克，五味子15克，茯苓15克，

炙甘草10克。水煎服。

五、心脾两虚：腹泻常因精神紧张，情绪激动而诱发，日泻3—5次，心烦，失眠，肠鸣，舌淡，苔白，脉细数。

方药：赤石脂30克，禹余粮30克，浮小麦30克，大枣30克，甘草10克。水煎服。

加减：有虚寒症象，舌淡苔白者加吴茱萸；湿重苔厚而腻者加厚朴、苍术；腹胀肠鸣者加防风、羌活；大便中粘冻相杂加木香、黄连。

9. 霉菌性肠炎

霉菌性肠炎系慢性消化道疾病，易反复发作。临床症状有腹痛，尤以少腹痛为多见，便后腹痛减轻。大便稀溏，每日1—10次不等。多数病人大便中夹有白色粘液，少数患者有便秘或便秘与大便稀溏交替出现。伴有腹胀，食欲差。大便常规检查：白细胞+~++，红细胞+，霉菌++~+++，无巨噬细胞。大便培养均有白色念珠菌生长。

现代医学认为本病以白色念珠菌致病为最多见，常因慢性消耗性疾病以及滥用广谱抗菌素导致肠道内正常菌群生长失调所致。

霉菌性肠炎属于祖国医学“下痢”、“泄泻”范畴。发病原因以脾胃湿热内蕴和感受寒冷侵袭为多见。治宜清热燥湿，解毒杀虫。

方一：苦参粉2克，云南白药1克，共拌匀，为一次量，每日早晚各服1次，温开水送服。

方中苦参有清热燥湿，解毒杀虫的作用，中医常用于治疗肠蕴湿热及血痢热证。现代药理研究证明苦参有抗皮肤真

菌及滴虫等作用。本病常缠绵难愈，久则生淤，故配用云南白药祛淤止痛。

方二：苦参30克，白头翁12克，秦皮10克，千里光30克。水煎服。

方三：黄柏60克，青黛40克，肉桂10克，冰片2克。共研成极细粉末，加300毫升温开水再加热，使药粉溶于水，作保留灌肠20分钟。

10. 滴虫性肠炎

滴虫性肠炎，又称肠毛滴虫病，是常见的传染病。主要表现为腹痛（脐周压痛），反复发作的腹泻，大便黄色稀溏，或黄色水样便，或脓血粘液便，日泻4—10次，大便常规（连续几次）检查可见满视野肠滴虫，脓细胞、红细胞++~+++。本病常按肠炎治疗而忽视肠滴虫的存在，因此，进行实验室检查应引起临床医生的重视，以免延误治疗。

滴虫性肠炎属于祖国医学的“虫泻”范畴。系湿热毒邪侵滞肠腑。若滴虫感染日久，还可损伤脾肾之阳。治宜清热利湿解毒。

方一：鸦胆子6克（研粉吞服），葛根30克，黄芩12克，黄连10克，黄柏12克，枳实10克，白芍15克，莱菔子10克，薤白10克，甘草10克。水煎服。

方二：苦参30克，槟榔12克，苦楝皮10克，石榴皮10克，乌梅15克，百部10克。水煎服。

方三：仙鹤草45克，白头翁45克，广木香12克，辣蓼20克，凤尾草20克，铁苋菜20克，甘草10克。水煎服。

方四：仙鹤草45克，白术10克，草果仁10克，木香10克，

吴茱萸10克，补骨脂10克，法半夏10克。水煎服。

注：仙鹤草能杀肠道滴虫，故方3、方4均重用仙鹤草。

方五：雷丸12克，川楝根皮12克，槟榔12克，仙鹤草30克。用水1000毫升煎至300毫升，待降温至40℃后，作保留灌肠，每日一次，保留灌肠时间，可由2小时逐渐延长至10小时。

加减：肠胃湿热偏重，加苦参、白头翁各30克；湿浊偏重，加草果6克、厚朴12克；脾肾阳虚，加蛇床子30克。

方六：蛇床子30克，白术12克，苍术12克，黄柏10克，甘草3克，干姜10克，苦参15克。水煎服。

注：蛇床子性味苦温，能杀虫治癣，驱风燥湿，壮阳补肾，治疗滴虫性肠炎有效。

11. 肠 粘 连

肠粘连是一种较为常见的疾病，病变虽属良性，但往往反复发作，迁延不愈，造成患者很大痛苦。肠粘连大多由于腹膜炎、腹部手术或腹膜结核广泛粘连引起。症状有：腹痛腹胀，恶心、呕吐，腹部可触及痞块，腹泻与便秘交替，或有大便不畅感。

肠粘连属于祖国医学“瘕”、“聚”范畴。中医古书中所指的“症瘕积聚”、“痞块”、“腹中狭窄”，其性质和症状与肠粘连极为相似。中医认为情志抑郁，肝气不舒，或饮食不节，损伤脾胃；外邪入侵，感染浊邪，热毒内蕴，血淤肠络；腹部外伤或术后脾胃虚弱，运化无力，气滞血淤，均可引起肠道粘连积聚。

中医还认为，肠粘连发生的机理是病痛手术伤气，气伤

血损。众所周知，气、血是供养生命活动的根本，气血调和则人体各部分功能正常。若病痛手术损伤气血，致使肠腑运动功能失常，腑气通降失利，气机阻滞，形成腹痛，其本为气虚，标为气滞，虚为正气不足，滞为邪气有余。故对肠粘连的治疗，既要“补其不足”，又要“损其有余”，宜补气养血，健脾和胃，通络散结，攻补兼施。

方一：黄芪30克，党参30克，白术12克，白芍30克，甘草10克，木香10克，槟榔10克，丹参30克，炙鳖甲15克，石见穿30克，川椒6克。水煎服。连服7—30剂。

另以皂角刺30克，煎汤煮糯米粥分2次服，每日一剂，连服7—30剂。

皂角刺入肺、肠，活血通络，辛散温通，力锐善行，通达经脉血络，既有攻散之力，复兼开导之能。糯米性粘，能耐饥而厚肠胃，与皂角刺相伍，能使其在肠中保留药性。延缓其排泄，充分发挥其穿透之力。这现代医学的保留灌肠意义相似。

肠粘连由于腹膜结核引起者，在结核尚未控制的情况下，必须同时服抗痨药物，中西药并进，方能收到良效。

加减：湿热重者去黄芪、党参、甘草，加黄芩、黄连、连翘、苍术、茵陈；大便溏薄加炮姜炭、补骨脂、肉豆蔻；腹痛甚者，白芍可用至60克，并加用延胡索、川楝子、制乳香；阴虚加生地、阿胶、石斛；纳差加鸡内金、山楂、神曲、砂仁、麦芽。

方二：青皮10克，陈皮10克，香附10克，制半夏10克，白芍12克，炙甘草10克，黄芪30克，党参30克，茯苓10克，木香10克，台乌10克，枳壳10克，槟榔10克。水煎服。

加减：舌有淤斑淤点，加赤芍、桃仁；舌光红无苔，脉

细致，口干自汗等气阴两虚证候者，加北沙参30克，并重用白芍至30克；便秘者，另加服麻仁丸，药汁送服，至大便通调为止。

一般每日一剂，病情重者，亦可一昼夜服2剂。服药期间，忌食生冷粘腻以及辛辣等难消化、有刺激性的食物。

方三：（预防早期肠粘连方）厚朴10克，枳壳10克，木香10克，台乌10克，炒莱菔子10克，赤芍10克，桃仁10克，红花10克，黄芪30克，大黄10克。水煎服。或由胃管内灌入。

方四：红藤15克，马齿苋15克，太子参15克，当归10克，桃仁10克，瓜蒌10克，连翘10克，生姜6克，大枣10克，木香10克，甘草10克。水煎服。

方五：荔枝核15克，小茴香10克，沉香6克，公丁香克，香附12克，木香10克，陈皮10克，半夏10克，台乌10克。水煎服。

针灸疗法

取穴：脾俞、胃俞、大肠俞、中脘、天枢、章门、上巨虚、足三里、内关。

每次选5—7穴，每日针刺一次。便秘严重者，须加服中药，杏仁10克，郁李仁10克，桃仁10克，火麻仁10克，柏子仁10克，陈皮10克，苏子10克。水煎服。

12. 肾病综合征

肾病综合征是一组由多种原因引起的临床症群。其特征是浮肿、大量蛋白尿、高胆固醇血症及低蛋白血症，即所谓“三高一低”。尿中常有脂肪小体（也可有管型等）。患者突出

的临床表现为高度浮肿，颜面及四肢按之凹陷，有的可伴有胸水腹水，胸闷憋气，脘腹胀满，尿量明显减少，由于尿蛋白浓度高，易起泡沫。患者神疲力乏，头晕，心悸，身重，纳差，恶心呕吐，大便溏薄，短气懒言。

引起肾病综合征的原因甚多，主要可归纳为四种情况：①肾脏本身的疾病。②毒物、药物与过敏所致。④全身性疾病累及肾脏。③肾脏血液动力学障碍。

祖国医学无肾病综合征的病名，其临床表现属于脾肾气虚，湿浊潴留范畴。中医认为脾主运化，摄取水谷精微，输布水液；肾司开阖，作精气的藏蓄与湿浊的排泄。脾虚则运化无权，难以摄取精微，又难以输布水液；肾虚则开阖失常，未能固摄精气，又未能排泄湿浊。清不升而浊不降，渐致血清蛋白偏低，胆固醇反高，尿蛋白大量丧失。中医认为“诸湿肿满，皆属于脾”。“肾者，胃之关也，关门不利，故聚水而从其类也”。“今脾病不能为胃行其津液，四肢不得禀水谷气，气日以衰，脉道不利，筋骨肌肉，皆无气以生，故不用焉”。因此，浮肿乏力等证，确与脾肾同病，湿浊中困有关。治宜健脾肾，清湿热。

方一：黄芪30克，太子参30克，白术12克，茯苓12克，当归12克，生地15克，麦冬15克，白芍10克，柴胡10克，莲须10克，芡实15克，山药30克，苡仁根30克，石苇15克，大蓟根10克，泽泻15克。水煎服。

方二：黄芪15克，肉桂（后下）3克，车前草30克，玉米须30克，金钱草30克，扁蓄30克，淫羊藿10克，水煎服（本方适用于儿童肾病综合征）。

加减：伴有上呼吸道感染者加板蓝根、银花、连翘，野菊花；反复外感者加防风6克、白术10克；面色苍白，精神

萎靡，纳呆，恶心，脉微弱者，加鹿角粉3克（冲服）。

方三：仙茅10克，淫羊藿30克，补骨脂10克，复盆子10克，苁蓉10克，党参30克，黄芪30克，黑豆30克，当归12克，赤芍12克，桃仁12克，鹿含草30克，玉米须30克。水煎服。

方四：熟地20克，山萸肉10克，黄芪15克，玉米须30克，益母草30克，泽泻10克，山药30克，蝉衣3克，紫苏10克，丹皮12克，桃仁6克。水煎服。

加减：尿蛋白多者，黄芪可用至30克；尿少者加淮牛膝30克；周身浮肿，总蛋白偏低者，可用羊肉250克，黄芪30克，生姜皮2克（刀刮下），煎汤去滓（羊肉不要吃）饮汁，隔天一剂。

方五：黄芪30克，赤小豆30克，砂仁10克，生姜10克，鲤鱼或鳊鱼250克。此为一日量。先以适量水煎药30分钟后，将已去除内脏并洗净的鲤鱼或鳊鱼放入药锅内，鱼药同煎，不放盐，煎沸后用文火炖40分钟左右，吃鱼喝汤。初服时可以分次频服，之后可逐渐改为顿服。至少连服四天。

注意：尿毒症期的水肿不宜用本方治疗。

较长时间服用本方，可使水肿消退，尿蛋白逐渐减少，血浆白蛋白上升，胆固醇逐渐下降。

方六：益母草30克，茯苓30克，丹参20克，银花20克，赤芍15克，车前草30克，川芎10克，红花10克，桃仁10克，连翘10克，甘草6克。水煎服。每日一剂。疗程三个月。

《中医杂志》介绍的以下七种治疗肾病综合征的方法，很有实用价值。

①补益正气：增强抵抗力，预防外感，减少复发。慢性肾炎、肾病综合征病人常因抵抗力差，或由于应用西药免疫抑制剂，抑制了细胞免疫功能，致患者抵抗感染的能力减

弱，易招致反复感染，“卫外之气不固，外邪得而凑之”，使肾炎复发迁延。在这种情况下，用玉屏散（黄芪、防风、白术）加减治疗，疗效较好。

②调理脾胃之气，以增进食欲，改善营养，提高抵抗疾病的能力。调理脾胃在肾病综合征治疗中有两方面的作用，一是使用益气健脾药如党参、黄芪、白术、茯苓、山药、苡仁等使脾能健运，便溏、腹泻等症状得以控制，蛋白质在胃肠道丢失减少，同时使患者保持一定的食欲，提高蛋白质摄取、吸收、合成，使血浆蛋白的水平保持正常。二是病人在应用大剂量的克伐脾胃免疫抑制剂后，常致胃气不和，纳食减少，甚至呕吐恶心，可用陈皮、法半夏、茯苓、甘草、木香、砂仁、党参、白术等以减少西药（免疫抑制剂）对胃肠道的不良反应。

③填精补肾。对久治不愈、下元虚亏、水肿退而不尽，按之如泥，血清蛋白很低等难治性肾病综合征患者，宜在健脾开胃的基础上给予填精补肾的药物或食物，以提高抵抗力。常用的补肾药物有：仙茅、淫羊藿、巴戟天、锁阳、黄精、山萸肉、熟地、鹿角胶、龟板胶、核桃仁等。常用的补肾食物有：甲鱼、鲫鱼、牛奶、羊奶、羊肉等。这些补品最好与赤小豆等同煮，仅服其汁（喝汤），食欲好转后逐渐加量，以增加至不倒胃口为度。一旦血浆蛋白恢复正常后，即改为普通饮食，不要长期过度的摄入高蛋白。

④清利湿热和清热解毒。凡患者有皮肤疮疖、咽喉肿痛、五心烦热、夜不成寐、舌红脉数等热象重时，有浮肿者宜清利湿热，可用金钱草、车前草、苡仁、半枝莲、鹿含草等。浮肿已退者宜清热解毒，可用白花蛇舌草、蒲公英、七叶一枝花、银花、连翘等，每次选用其中4—5味，再配伍养阴

酒涩、活血化淤，健脾化湿药。

⑤活血化淤。凡患者面色黧黑，舌有淤点，皮肤色素沉着，或皮肤有淤斑淤点，或血液呈高凝状态者，在辨证运用上述诸法时，要加用活血化淤药，可用益母草、泽兰、丹参、红花、川芎等，能改善微循环，增加肾血流量。

⑥温肾利水。凡尿量少、高度浮肿的患者，应投予真武汤加减，以利水消肿，常用药有制附片、猪苓、茯苓、泽泻、车前草等。若有腹水者，可加用适量之黑白丑、带皮槟榔。至尿量增加，先减去制附片、黑白丑，其他药继续用，以巩固疗效。

⑦消食祛脂。对用激素后肥胖、心悸，而血脂很高或有明显的脂质尿的病人，宜在上述辨证论治方药中加用山楂、炒麦芽各30克，或玉竹15克、泽泻60克。此类药均有降脂作用。

13. 紫癜性肾炎

紫癜性肾炎是过敏性紫癜引起的肾脏损害。患者对河虾、西红柿、菠菜等食物及某些昆虫过敏，甚至对泥土及某些药物过敏。由于过敏而引起过敏性紫癜。皮肤紫癜是首发症状，可伴有关节痛、腹痛、血尿、便血、鼻衄、浮肿等症状。患者由于过敏性紫癜而继发肾炎，尿常规检查可有红血球、蛋白、管型。

紫癜性肾炎属于祖国医学“衄”、“溺血”、“水肿”，“斑毒”、“发斑”等范畴。其发病原因不外风、热、毒、虚，多因血热壅盛，兼感风邪，风热搏结于血分，聚毒迫血妄行，致血溢于肌肤而发斑。《医宗金鉴》云：“青紫斑点，其色反淡，久则

令人虚羸”。

紫癜性肾炎的急性期可分为“阳毒发斑”和“阴毒发斑”两类。阳毒发斑系血热妄行，迫血外溢肌肤，多为血热实证；阴毒发斑系气虚失摄，血不归经，多为虚证、寒证。慢性期于紫癜消退后，应根据水肿、溺血加以辨证治疗。

辨证分型治疗

一、血热型：热退后骤起皮肤紫癜，瘙痒，鼻衄，尿血。舌红苔薄黄，脉浮数或滑数。治宜凉血清热。

方药：犀角10克（或水牛角30克），生地30克，赤芍15克，丹皮12克，竹叶12克，小蓟12克，茅根30克，紫草30克。水煎服。

二、脾虚型：初起全身紫癜，继则身倦乏力，气短自汗，纳差腹胀，浮肿明显，舌淡苔白，脉沉细无力。治宜健脾益气。

方药：苡仁30克，冬瓜皮30克，黄芪30克，赤小豆30克，党参30克，山药30克，白术15克，茯苓12克，甘草10克，木香10克。水煎服。

三、脾肾阳虚型：紫癜消退后，面色㿔白，腰膝冷痛，四肢欠温，纳呆便溏，全身水肿，胸水腹水，舌淡胖，苔白，脉沉细迟。治宜温补脾肾。

方药：附片30克（先熬），白芍30克，干姜10克，茯苓12克，白术12克，鹿角胶10克，黄芪30克，杜仲12克，水煎服。

四、气阴两虚型：紫癜消退后，头晕耳鸣，气短乏力，自汗盗汗，手足心热，口干舌燥，心烦不安，舌红少苔，脉细数。治宜益气养阴。

方药：黄芪30克，党参30克，山萸肉12克，山药30克，

丹皮12克，泽泻12克，茯苓12克，淮牛膝30克，益母草30克。水煎服。

除上述分型治疗外，也可用下述基本方治疗：

方一：生地30克，大黄12克，生山楂30克，鹿含草12克，紫草15克，甘草10克，防风10克。水煎服。

加减：风热内盛兼咽痛重者，加蝉衣、玄参、山豆根；热伏营血，紫癜致密经久不消者，加丹皮、赤芍；血尿明显者加白茅根、旱莲草；腹痛兼便血者加白芍、焦大黄；气虚倦怠乏力者加太子参、黄芪；阴虚明显者加女贞子、旱莲草。热象明显者加白花蛇舌草、败酱草。

方二：益母草30克，茅根30克，荠菜花15克，银花10克，连翘10克，大蓟10克，小蓟10克，王不留行12克，三七粉2克。水煎服。

加减：血尿明显加琥珀屑3克（吞服）；气虚加黄芪；阴虚加生地、麦冬。

服用方二的同时，须加服昆明山海棠片，每次2片，日三次。

方中益母草有改善微循环及抗血小板聚集等作用，可改善肾血液循环和肾功能。昆明山海棠有活血化淤作用，临床应用副作用较轻。

14. 肾绞痛

肾绞痛多属于肾结石的并发症，在临床上较为常见。肾结石移动时，病人常有阵发性的剧烈疼痛和放射痛。疼痛先在腰部，然后沿输尿管向膀胱、外生殖器、大腿内侧等处放射，称为肾绞痛。绞痛时病人坐立不安，痛如刀绞，或如锥

刺，冷汗淋漓，面色苍白，恶心呕吐，每次发作几分钟到几小时不等，当结石停止移动或进入膀胱后，疼痛突然消失，结石有时可随尿排出。

肾绞痛可通过X线拍片证实有肾结石存在，并根据剧烈腰痛、放射痛等症状而确诊。

根据中医辨证，肾绞痛大致可分为寒凝血淤型和湿热型等类型。

寒凝血淤型：除具有上述肾绞痛的症状外，伴有恶寒蜷卧、手足厥冷、舌淡苔白等证候。治宜温经散寒。

方一：制附片40克（先熬），桂枝15克，白芍15克，炙甘草10克，生姜15克，大枣15克。水煎服。

湿热型：除具有上述肾绞痛的症状外，伴有小便涩滞，舌红苔黄厚腻等表现。治宜祛湿止痛。

方二：制附片40克（先熬），茯苓15克，猪苓12克，泽泻30克，桂枝15克，白术12克。水煎服。

此外，也可常备粉剂，遇肾绞痛病人就诊时立即与服。

方三：知母、黄柏、肉桂，等量，焙干研末过筛备用。每次用开水吞服一克，一般10分钟内可止痛，如疼痛不减，隔半小时再服药末1克，此后可3小时服药1克（一日四次），一般可在三天内控制绞痛。

方四：吴茱萸6克，苦楝子12克，青皮6克，枳壳12克，荔枝核15克，橘核15克，山楂12克，牛膝6克，炒栀子10克，白芍15克，玄胡15克，桃仁6克，三棱10克，甘草6克。水煎服。

针灸疗法

方法1. 先针患侧至阴、阴陵泉、外关。然后再针患侧耳穴：膀胱、输尿管、肾区的压痛点。体针直刺留针，按穴位所在部位的肌肉肥厚情况决定针刺的深浅程度，待得气后

留针15分钟。中途用捻转手法加强刺激一次。

方法2. 针刺三阴交、血海、行间、中极，强刺激，再用推拿手法点掐足三里、阴陵泉，掐后加揉。本法有助于肝脾协调，宣化和疏通膀胱气机，缓解肾绞痛。

15. 射精不能症

射精不能症是男性性功能障碍的一种表现，是指在性生活过程中，阴茎能很好地勃起，且持续时间较长，但不出现射精和情欲高潮，有时虽同房两小时余，但终不能射精，而房事毕入睡之后三小时却出现遗精现象。现代医学认为，本病系射精中枢功能紊乱引起，即射精中枢被过分抑制，使正常足够的刺激也不能引起射精中枢兴奋而射精。

射精不能症的原因：①长期手淫，使射精中枢习惯于手淫强烈刺激下才会兴奋，而正常的性生活和性刺激却不能引起射精中枢的兴奋，由于长期手淫的坏习惯，提高了射精中枢需要性刺激的阈值，于是不能射精。②房事过多也是引起不射精的原因之一。两次性生活相隔时间愈长，射精出现愈快；间隔时间愈短，射精出现愈慢，甚至不射精。过频的性生活使射精中枢既紧张又疲劳，最后发展到“消极怠工”（即射精中枢被抑制）。

祖国医学认为本病主要由于相火亢盛，精关不利，或兼有肝肾亏虚，肝经失调。肝肾两脏同居下焦，内寄龙雷相火。古有“肝肾同源”之说。《素问·六节藏象论》曰：“肾者，主蛰，封藏之本，精之处也”。肾开窍于二阴，而肝主疏泄，肝之经脉绕阴器，前阴为宗筋之会。因此，肾精的生成、储藏、排泄与肝肾两脏密切相关。肝为刚脏，内寄相火；体阴

而用阳。肝之用过盛或兼肾阴不足者，每易见阳亢之象。阳亢内扰则精窍疏泄不利。实证治宜泻相火，通精窍；虚证治宜补肝肾，填精髓。

方一：龙胆草10克，栀子10克，茵陈12克，木通10克，旱莲草30克，女贞子30克，川牛膝15克，滑石30克，甘草梢3克。水煎服。日一剂。治疗期间节制房事，忌食辛辣。本方适用于阳亢患者。

方二：山药30克，熟地20克，黄芪30克，菟丝子10克，杜仲10克，巴戟天10克，枸杞15克，山萸12克，补骨脂12克，台乌10克，香附12克，葛根30克。水煎服。同时用麝香虎骨膏或麝香止痛膏贴敷脐中。本方适宜于肾虚型患者服用。

方三：知柏地黄丸（成药）合五子衍宗丸（成药）加甲珠15克、通草10克（水煎服）。本方适用于肾阴阳俱虚患者。

方四：川芎6克，炒小茴6克，玄胡10克，没药10克，生蒲黄10克，五灵脂10克，川牛膝10克，当归12克，赤芍12克，琥珀末3克（冲服），熟地10克，红花10克。水煎服。本方适宜于有瘀血见证的患者（少腹痛，阴囊胀涩抽痛）服用。

方五：有梦遗者先服知柏地黄丸，继用菖蒲10克，远志10克（水煎服），并兑服麝香0.3克。如兼阳痿不射精者，先用苁蓉30克、淫羊藿30克，水煎服，并兑服肉桂末1克。继用菖蒲10克，远志10克（水煎服），并兑服麝香0.3克。本方适用于相火亢盛患者服用。

方六：女贞子30克，桑椹子30克，知母10克，炙鳖甲15克，补骨脂10克，车前子10克，五味子15克，菟丝子10克，枸杞子15克，复盆子10克。水煎服。本方适宜于肾阴虚患者服用。

方七：熟地20克，枸杞子20克，制附片10克（先熬），

巴戟10克，杜仲10克，肉桂3克，山药30克，苁蓉10克，山萸12克，锁阳10克，韭子10克，补骨脂10克，淫羊藿30克，复盆子10克。水煎服。同时加服人参蛤蚧酒。本方适用于肾阳虚患者。

方八：虎杖30克，冰片3克（冲服），血余炭10克，金钱草30克，白芍12克，车前子10克，土牛膝15克，皂角刺12克，五灵脂10克，白薇12克，地骨皮15克，丹皮12克，木通10克。水煎服。本方适宜于阳强不射精的患者服用。

方九：芒硝50克（研碎），同房时取碎芒硝一小把，握于两手掌心劳宫穴处。本方适宜于阳亢患者使用。

针灸疗法

取穴：曲骨（针），阴廉（针），大敦（灸）。身体衰弱，食欲不振，大便不畅者加刺足三里；失眠者加刺百会、内关；伴有阳痿者加刺次髎穴和增灸神阙穴。

治疗前令病人排尽小便。进针深度：曲骨穴以出现电击感并向尿道根部放射为止；阴廉穴以局部出现酸胀、重感为度。大敦穴用艾条灸治5分钟，火力要足，用雀啄法进行。

有些患者不射精的原因主要是缺乏性知识，性生活的方法错误。因此，有必要向病人作必要的宣传解释。

不射精的病人除了用药物治疗外，还应消除对性生活的神秘感、顾虑、恐惧等不正常心理，这对不射精的治疗是很有好处的。

16. 精液不液化症

精液不液化症系指精液排出体外，经实验室检查24小时不能正常液化，因而直接影响生育。患者一般无自觉症状，

或仅有口苦咽干，性情急躁等肝火旺、肾阴亏的轻微症状。

祖国医学认为，此症多为肾阳虚弱，气化失常，湿浊下注；或肝火偏旺，肾阴亏损；或湿热下注膀胱，以致精液粘稠，清浊不分而不能正常液化。治宜温肾化浊，清利湿热。

方一：萆薢15克，益智仁12克，石菖蒲12克，台乌12克，车前子(包)10克，龟板20克，枸杞15克，猪苓15克，茯苓15克，桑寄生30克，泽泻30克。水煎服。

方二：莲子心6克，黄芩10克，黄柏15克，丹参15克，白茅根30克，石菖蒲10克，萆薢25克。水煎服。

方三：小茴香6克，川芎10克，玄胡6克，五灵脂10克，干姜6克，肉桂3克(后下)，赤芍10克，蒲黄10克，当归12克，黄精30克。水煎服。本方适宜于元阳不足之精液不液化症患者服用。

加减：精液中有脓球者加萆薢15克、石菖蒲10克、石苇20克、车前子20克；精子活动力低者，加仙灵脾30克，黄芪30克；精子少者加服五子衍宗丸(成药)。

针灸疗法

取穴：①气海、水道、左行间、右三阴交。②中极、肾俞、阴陵泉、太溪。

两组交替行针，同一组针三次后对换，针7—10次后复查。

手法：腹部穴用平补平泻法，四肢部位用泻法，均留针15—20分钟。留针中再行针一次。

17. 缺无精子症

缺无精子症是男性不育症的一种。从患者的精液化验检

查中，高倍镜视野下仅见精子1—2个，伴有面色蜡黄、腰酸痛、头昏乏力、食欲不振等症状，但性生活正常。

缺无精子症属于祖国医学“肾精不足”、“虚劳”、“不育症”等范畴。中医认为本病多由命门不足，先天肾精亏损，后天脾气不健所致。先天之精封藏于肾，依赖后天之精不断滋生，才能生殖、繁衍后代，后天之精（营养物质）输布到各脏腑，成为各脏腑活动的物质基础，并不断充养先天之精，二者相互依存，相互促进。中医还认为，“命门为水火之府，为阴阳之宅，为精气之海，为死生之窦”，“此诚性命之大本”，“凡属气化之物，非火不足以生”。命门之火即是元阳，也是生物之火，有了生物之火，才能化生精液。精气的生成与活动，首赖阳气的充沛。然“水为造化之原，万物之生，其初皆水”，“生化之机，则阳先阴后，阳施阴受，先天因气以化形，阳生阴也；后天因形以化气，阴生阳也。形即精也，精即水也；神即气也，气即火也。阴阳二气最不宜偏，不偏则气和而生物，偏则气乖而杀物”。因此，治疗缺无精子症，既要温阳以化气，又要补虚以添精。也即是治疗当以补肾精为主，健脾气为辅。

方一：枸杞15克，菟丝子20克，杜仲12克，熟地30克，山药30克，鹿角胶10克，山萸肉10克，茯苓12克，丹皮10克，五味子15克，红花10克，肉桂3克。水煎服。每日或隔日一剂，需连服数十剂始能见效。

方二：菟丝子15克，桑椹子30克，五味子15克，枸杞15克，女贞子30克，金樱子15克，补骨脂12克，蛇床子12克，复盆子12克，党参30克，白术12克，茯苓12克，陈皮10克，首乌12克。水煎服。每日或隔日一剂，至少连服30剂，并禁房事。

方三：右归丸（成药）30克（吞服），红参6克（嚼服），鹿茸粉0.3克（吞服）。此为一日量。连服一个月。

方四：红花10克，肉桂3克（后下），女贞子30克，枸杞15克，杜仲12克，五味子15克，鹿角胶12克，菟丝子12克。水煎，吞服六味地黄丸15克（每次15克，一日三次，一日量为45克）。

18. 精囊炎（血精）

精囊炎的主要症状是血精。血精是精液里有血（包括性交时射出的精液和梦遗的精液里都有血）。平时乳白色的精液，突然变成粉红色，甚至鲜红色。精囊炎的特征就是血精。精囊与前列腺、泌尿道、直肠等器官相邻近，当这些部位有炎症时，细菌很容易蔓延到精囊里引起发炎，精囊壁肿胀、充血。由于男女性交，激素的作用，平滑肌和血管的收缩，以至精液里渗混大量的红细胞和脓细胞。患者或可出现下腹部隐痛，或腰痛，伴有血尿。取患者的精液作显微镜观察，红细胞多得惊人，还可见到脓细胞、白细胞等。

精囊炎（血精）属祖国医学的血淋范畴。多因性生活（房事）频繁或不寐遗精所致。中医认为，血精一症，责之于肾，肾精损伤而及阴血。《诸病源候论·虚劳精血出候》说：“此劳伤肾气也。肾藏精，精者血之所成也。虚劳则生七伤六极，气血俱损，肾家偏虚，不能藏精，故精血俱出焉”。《医学衷中参西录》云：“血淋之证，大抵出自精道也。其人或纵欲太过而失于调摄，则肾脏因虚生热，或欲盛强制而妄言采补，则相火动无所泄，亦能生热，以致血室（即精室）中血热妄动，与败精溷合化为腐浊之物”。治宜滋阴清热，化滞祛瘀理血。

方一：山药30克，生龙骨30克，生牡蛎30克，藕节15克，旱莲草15克，海螵蛸10克，茜草10克，阿胶10克，白头翁12克，白芍12克。水煎服，每日一剂。

加减：伴血尿者，加龙胆草，小蓟各10克；尿中见血块凝阻者，加三棱10克，莪术10克；腰腹串痛者加川楝子12克；阴虚火旺者加知母12克，黄柏12克。

方二：生地30克，熟地15克，山萸肉12克，丹皮10克，女贞子30克，旱莲草30克，知母10克，黄柏10克，淡竹叶12克，莲米10克，灵磁石30克。水煎服。

方三：黄芪30克，旱莲草30克，知母12克，黄柏12克，山药30克，丹皮12克，生地30克，地榆12克，金樱子30克，地锦草15克，藕节12克，牛角腮15克。水煎服。

方中黄芪内托解毒；地锦草清热解毒、利湿止血；牛角腮、地榆二味在《本草纲目》和《本草经疏》中均认为是入足少阴肾经血分之药。以上诸药合用，治疗血精疗效可靠。

19. 真性红细胞增多症

真性红细胞增多症是一种原因不明的慢性进行性造血疾病，属于骨髓增生性综合症。本病的临床特征是皮肤红紫，脾脏肿大以及血管性神经性症状，患者的骨髓造血功能亢进，血红蛋白及红细胞数与血总容量绝对增多，血粘度增加。血液中粒细胞与血小板也有相当的增加。

本病起病缓慢而隐匿，有的患者始终无感觉而在偶然血液检查时才被发现。

先天性心脏病、肝脏疾病、高原气候影响、脱水等均可引起红细胞增多症。这里仅介绍不明原因的原发性红细胞增

多症的中药治疗。

本病早期表现有头痛、头胀、眩晕、健忘和疲劳等类似神经官能症症状。随着病情发展，出现全身皮肤瘙痒，劳累后气促，骨骼疼痛，腹胀，暖气，便秘，全身皮肤和粘膜红紫，尤以颊、唇、耳、鼻尖、颈部为甚，四肢远端皮肤红紫甚至呈青紫色，眼结膜充血，皮肤淤斑，齿衄，鼻衄，脾肿大，肝肿大。半数患者有高血压。

由于充血和血流缓慢，加上血小板增多，血管内壁损害和合并动脉粥样硬化等因素，可产生血栓形成、梗塞、静脉炎等并发症。脑血管严重损害时可发生瘫痪、肌阵挛病、舞蹈病、癫痫样发作等症状。

真性红细胞增多症，根据中医辨证，以血淤气郁兼湿热伤阴者居多，同时兼见肝胃失调、肺胃失调等表现，故治宜活血化淤，养阴清热，理气和胃。

方一：丹参30克，当归12克，赤、白芍各10克，生地30克，丹皮12克，大黄10克，蒲公英30克，龙胆草10克，槐花12克，青、陈皮各12克，三七粉4.5克（冲服），甘草6克。水煎服，每日一剂。

本方适宜于真性红细胞增多症伴有出血倾向的患者服用。

方二：车前子10克，夏枯草15克，菊花15克，川牛膝15克，丹参30克，川芎15克，黄柏10克，知母10克，桑叶12克，泽泻30克。水煎服。

本方适宜于真性红细胞增多症伴颅压增高、血压高的患者服用。

方三：龙胆草15克，川芎15克，黄芩15克，泽泻15克，藕节30克，白茅根30克，鸡血藤30克，山梔10克，红花10

克，桃仁6克，三棱18克，莪术18克，银柴胡12克，丹皮10克，芦荟3克（冲服），青黛3克（冲服），银花藤15克。水煎服。

本方适用于真性红细胞增多症伴头痛持续不愈、头胀眩晕、面赤口干、耳鸣失眠、便秘尿黄、手足刺麻、齿衄鼻衄的患者服用。

方四：全蝎10克，僵蚕10克，土鳖虫10克，蜈蚣2条，共研细末，蒸鸡蛋（二个）服。每日一剂。

本方适宜于真性红细胞增多症伴头胀痛、眩晕等症状的患者服用。

方五：银花10克，连翘10克，当归20克，黄芪20克，熟地50克。水煎，加蜂蜜适量服用。

本方适宜于真性红细胞增多症伴皮肤红紫、眼结膜红紫等症状的患者服用。

方六：水蛭5克，土鳖虫10克，共研细末，蒸鸡蛋（一个）服。

本方适宜于真性红细胞增多症伴皮肤淤斑等症状的患者服用。

方七：水牛角片30克（吞服），生地30克，赤芍15克，丹皮12克，黄芩10克，柴胡10克。水煎服。

本方适宜于真性红细胞增多症伴鼻衄、齿衄的患者服用。

方八：牛黄解毒片（成药），每次5片，一日三次。

本方适宜于真性红细胞增多症伴头痛、头胀、骨骼疼痛、腹胀、便秘等症状的患者服用。

方九：龙胆草15克，栀子12克，黄芩15克，柴胡15克，生地15克，泽泻15克，木通10克，甘草10克，鸡血藤30克，青黛12克（后下），水煎服。

本方适宜于真性红细胞增多症伴高血压的患者服用。

加减：淤血明显者加桃仁、红花、川芎各12克；重度淤血者加三棱、莪术各12克；阴虚者加玄参、麦冬各12克，有出血倾向者加白茅根30克、藕节15克、丹皮15克；乏力者加党参、黄芪各30克；热盛烦躁口渴加银花、紫花地丁、蚤休各15克；大便干结者加大黄10克，或蕃泻叶10克泡茶饮。

治疗后血红蛋白、红细胞数下降而白细胞仍高者则重用蚤休、连翘、白花蛇舌草各15克。

方十：生地30克，水牛角50克，丹皮10克，丹参10克，黄芩10克，栀子10克，大黄10克，人中白10克，赤芍10克，知母10克，紫草10克，黄柏10克，大青叶10克，黄连5克。水煎服。

本方适宜于真性红细胞增多症伴便秘、腹胀患者服用。

本方通腑实，破积热，抑制骨髓增生过旺，能使血粘稠度下降，全身症状缓解，起到“釜底抽薪”的作用。

20. 原发性血小板增多症

原发性血小板增多症系骨髓增殖性疾病，病因尚未阐明。本病的特征是：血小板持续增多（血小板计数高达80万/立方毫米以上，多半在100万—300万/立方毫米），伴有自发出血倾向，血栓形成，脾脏肿大，白细胞增多（白细胞计数可达1—3万/立方毫米）。因这种病有反复出血倾向，所以又称之为出血性血小板增多症。某些疾病经化学药物治疗后，也可反常地出现血小板增多，可能系化学治疗干扰了骨髓增殖的调节控制系统的缘故。

本病起病缓慢，轻者头昏乏力，重者有鼻衄、齿衄等出血

及血栓形成（下肢跛行及下肢坏疽）等表现，患者有皮肤淤斑，脾脏剧痛，肝脾肿大。并有食欲欠佳，口干口苦，腰膝酸软，心悸心烦，多梦等症状。

本病属于祖国医学“阴虚火旺”“淤血症痕”等范畴。中医认为肾主骨，骨生髓，髓生血，本病是骨髓增殖性疾患，病变脏腑在于肾。肾为水火之脏，有阴有阳，阴虚则阳亢，出现骨髓增殖功能偏盛。淤血滞于经络，血液流行不畅，血不循经，故有鼻衄、齿衄等出血表现。

本病因淤血阻滞脉络，流行不畅，血不循经而见诸般出血，与气虚不能摄血、脾虚不能统血之血液外溢不同，治宜滋养肾阴，活血祛淤。忌用甘温补益，忌用炭类药物。

方一：生地30克，玄参30克，川芎15克，赤芍15克，红花15克，三棱10克，桃仁10克，水蛭6克。水煎服。

方二：丹皮12克，知母12克，生地18克，玄参18克，赤芍15克，黄柏12克，红花12克，丹参30克，益母草30克，紫草18克，桃仁10克，水蛭6克，水煎服。

方三：黄精30克，首乌30克，鳖甲12克，沙参60克，太子参60克，熟地45克，郁金12克，鸡血藤60克，大黄10克，羚羊角粉1克（或山羊角粉60克）。水煎服。

方四：羚羊角1克，首乌24克，蛭螭6克，鳖甲12克，黄精30克，合欢皮30克，鸡血藤100克，沙参60克，太子参60克，郁金20克，熟地30克。水煎服。

21. 病毒性心肌炎

病毒性心肌炎，多发生于青少年、青壮年。临床发现为发热、心动过速、心律不齐、心区刺痛、心悸、乏力、面色苍

白、多汗、头晕、关节痛及呼吸困难等症状，往往伴有心音改变和心电图异常。在心脏症状出现的同时或症状出现前二、三周见有呼吸道或消化道感染症状，如发热、咳嗽、咽痛、腹痛、腹泻等。或者在起病初期有类似病毒感染性疾患，如流行性腮腺炎、麻疹、水痘等

病毒性心肌炎病程较长，短者数月，长者几年，甚至十几年，常遗留不同程度的后遗症，如各种心律失常，心肌供血不全等。

中医认为，病毒性心肌炎若系急性感染起病者，可从“温病”论治；若合并心功能不全时，则属“心水”范畴；若以心律失常为主要表现，则属“怔忡”、“心悸”、“虚劳”范畴。

病毒性心肌炎的急性发作，一般都与六淫外邪有密切关系。中医认为邪毒多从口鼻而入，邪入必损营卫气血，循经络由表入里，先损心之“体”，继损心之“用”，由阴血之伤而渐致阳气虚损，反复感染，经久难愈。病之初，病位在于“心肺”，邪毒侵及心脉为主，邪滞不去，损及心气心血，淤阻脉络，气血失调，心律因而紊乱。阴阳气血的虚损导致诸脏气化失司，水湿内停，上犯心肺则为心力衰竭等症。有的甚至发生类似中医温病的后遗症。

病毒性心肌炎发病可急可缓，可轻可重，一般可分急性发作期与慢性期两个过程。

病毒性心肌炎急性期起病急，病情变化多，具有风热外感、热毒壅盛等上呼吸道感染的表现（发烧、咳嗽、咽痛、腹痛、腹泻等），并具有胸痛、心悸症状。这正是病毒性心肌炎在这一阶段的最基本的特征，也即是中医所说的“邪热犯心”。因此，在治疗上除了清热解毒透表之外，还必须加用宁心通络药物。

病毒性心肌炎的慢性阶段，病变相对稳定，主要以心脏扩大、心律失常及慢性心功能不全为基本特征，表现为心阴虚、心气虚、心阳虚、心气阴两虚等证候，治疗可按这些证候辨证施治。

辨证与分型治疗

一、邪热犯心：感冒后不久尚有发热、咽痛、咽干，并有心悸、烦躁、胸闷痛、心律不齐、舌红津少，脉细数，治宜清热泻火，育心阴。

方药：银花、连翘各15克，大青叶30克，丹参15克，生石膏30克，生地30克，赤芍10克，沙参12克，蒲公英15克，麦冬12克，葛根15克。水煎服（小儿剂量宜酌减）。

二、心阴虚：病毒性心肌炎的心阴虚，除有上呼吸道感染症状外，尚有心悸，健忘，失眠，多梦，眩晕，面色无华，五心烦热，盗汗，口干咽干，舌红少津，脉细弱。治宜养心育阴。

方药：北沙参15克，黄精10克，白芍10克，葛根30克，生地30克，麦冬15克，板蓝根13克，莲子心10克，蒲公英30克。水煎服（小儿剂量酌减）。

三、心气虚：心悸气短，活动后加重，面色晄白，神疲体倦，自汗，少气懒言，舌淡苔白，脉细弱或结代。

四、心阳虚：畏寒，肢冷不温，面色苍白，心胸憋闷或作痛，舌淡紫，脉微。

心气虚或心阳虚治宜补益脾肺，通脉养心。

方药：太子参30克，茯苓15克，桂枝10克，白芍12克，五味子12克，党参30克，远志12克，炙甘草10克，黄芪30克，板蓝根30克，柏子仁12克。水煎服（小儿剂量酌减）。

五、心气阴两虚：兼有心阴虚和心气虚的症状，治疗可

将心阴虚和心气虚的方药合用。

病毒性心肌炎的治疗应祛邪与扶正并重，早期尤当抓住六淫化热，而以清热解毒为要。患者每次感冒都对心肌有所损害，因此，应采用银花、连翘解表清热，抗御病毒，以间接保护心肌。由于病毒直犯心肌造成心肌细胞之损害，故用大青叶、板蓝根、蒲公英等，既可清热解毒，又有抗病毒的作用。茯苓，柏子仁、远志等，既能安神定志，且对保护心肌均有一定的作用。

22. 慢性房室传导阻滞

慢性房室传导阻滞可由心肌炎、急性心肌梗塞、冠心病、心肌病、心脏外科手术损伤、心脏先天性畸形、高血钾、缺氧等引起，通过心电图检查可以确诊。I度房室传导阻滞很少有症状，II度房室传导阻滞可有心脏停跳感或心悸感，心室率缓慢（40次/分），头昏，乏力，易疲倦，活动后气促，甚者短暂昏厥。III度房室传导阻滞时，除上述症状外，患者有时可突然出现面色苍白、晕厥、抽搐等症状（阿斯氏综合征），还可出现心、脑供血不足的表现，如智力减退、心力衰竭等。

慢性房室传导阻滞，属于祖国医学“心悸”、“怔忡”、“心气虚”“心阴虚”等范畴。房室传导系统概属于“心主血脉”范围，正常的房室传导功能，须赖心气之推动，心阳之振奋，心阴之滋养，心血之灌溉，心脉之畅通，心神之调节，彼此相互协调，始能维护其正常运行。临床上，凡心气虚弱，心阳不振，心阴耗损，心血亏虚，心脉淤阻，心神不宁，均可影响房室传导功能。治宜补益心气，振奋心阳，滋养心阴，养

心安神，活血通络。

方一：党参30克，白术12克，茯苓15克，莲子肉12克，肉桂3克，炙甘草10克，五味子15克。水煎服。每日一剂，连服30—40剂。

本方适用于心气不足，心阳不振，心电图提示房室传导阻滞之患者。证见心悸气短，胸闷自汗（劳累时加重），面色㿔白，头晕目眩，身倦乏力，食欲不振，四肢欠温，易感冒。

方二：党参30克，麦冬15克，五味子15克，莲子肉12克，茯苓15克，丹参15克，枣仁10克，白术10克，炙甘草6克，桂枝6克，龙齿30克，夜交藤30克。水煎服。每日一剂，连服10—40剂。

本方适用于气阴两虚，心神不宁，心电图提示房室传导阻滞之患者。证见心悸气短，胸闷痛（劳累或情绪变化时加重），面色苍白，自汗怕风，神倦乏力，五心烦热，易怒，失眠，下肢浮肿。

方三：生地30克，丹皮10克，龙眼肉12克，地骨皮12克，合欢皮30克，黄连6克，麦冬12克，玉竹12克，玄参12克，枣仁10克，夜交藤30克，珍珠母30克。水煎服。每日一剂，连服15—40剂。

本方适用于心阴不足、阴虚火旺、心神不宁、心电图提示房室传导阻滞之患者。证见心悸气短，胸闷痛，头晕目眩，烦躁易怒，五心烦热，失眠，健忘，多梦，盗汗。

方四：黄芪30克，当归12克，桂枝12克，地龙12克，红花10克，赤芍10克，川芎10克，桃仁10克，丹参15克。水煎服，每日一剂，连服15—50剂。

本方适用于气虚血淤，心脉淤阻，心电图提示房室传导

阻滞之患者。证见胸部憋闷，面色蜡黄，头目眩晕，唇舌紫黯。

23. 冠状动脉痉挛心绞痛

心绞痛不仅可发生于冠状动脉粥样硬化性心脏病（冠心病），也可由于冠状动脉痉挛而引起心绞痛发作。

冠心病心绞痛的特点是阵发性的前胸压榨感或疼痛感，主要位于胸骨后部，可放射至心前区与左上肢、肩、背、颈，甚至直达小指与无名指。疼痛多为压榨性、窒息性或闷胀性，有时伴有濒死的恐惧感觉。每次发作历时1—15分钟。休息后或用药后可缓解。发作时面色苍白，表情焦急，不愿活动，出冷汗。冠心病心绞痛根据患者疼痛的发作特点，结合心电图的运动试验、饱餐试验等，可以确诊。

冠状动脉痉挛也可引起心绞痛，其特点是：患者有心肌缺血史（心电图检查证实），心绞痛主要发生在休息时间，也可因情绪激动或寒冷刺激而诱发，或呈周期性定时发作，或在每次心绞痛发作时呈短暂的缺血性心电图改变等。这类患者的心绞痛较固定，多发生在每天晚上十一时至三时，或清晨四时至八时。

冠状动脉痉挛心绞痛可通过心电图（心绞痛发作时及缓解后对照）、冠状动脉造影、心肌扫描及闪烁照像等检查而确诊。

心绞痛属于祖国医学“心痛”、“真心痛”的范畴。隋·巢元方早在公元610年就在《诸病源候论·心痛候》中指出：“心脉急者，为心痛引背”。所谓心脉急，就是心脉痉挛拘急，也就是现代医学所指的冠状动脉痉挛，说明我国医学家早就

认识到心绞痛有因心脉痉挛（冠状动脉痉挛）而致者。

中医认为，“心病者，日中慧，夜半甚，平旦静”说明心脏病的病情变化与一日之中的阴阳消长有关。一些冠状动脉痉挛心绞痛病人每于固定的时辰发作，这与脏腑功能低下，不能适应自然界阴阳消长变化有关。对于这类病人，治宜温阳舒脉。

方一：制附片15克（先煎），干姜6克，肉桂末3克（冲服），当归12克，细辛6克，薤白30克，赤芍10克，白芍10克，黄芪30克，乳香10克，没药10克，毕拔10克，炙甘草6克。水煎服。每日一剂。连服一个月。心绞痛发作时须急服救心丸（成药）。服上方可预防和减少冠状动脉痉挛之心绞痛发作（发作时伴有腰酸腿软、畏寒肢冷等症状）。

方二：柴胡15克，郁金12克，白芍12克，玄胡索10克，炙甘草6克，桂枝10克，丹参30克，羌活10克，细辛6克，制附片10克，水煎服。每日一剂，连服15—30天。本方适用于伴有两胁胀痛，抑郁不乐之冠状动脉痉挛心绞痛患者。

有一类冠状动脉痉挛心绞痛，每由受寒冷刺激而发作。治宜宣痹温阳，通络舒脉。

方三：制附片15克（先煎），干姜10克，细辛6克，瓜蒌30克，薤白30克，枳壳10克，陈皮10克，法半夏10克，乳香10克，没药10克，川芎12克，郁金15克，水煎服，每日一剂。连服半个月。本方适用于由寒冷刺激而引起冠状动脉痉挛心绞痛发作的患者。

有一类冠状动脉痉挛心绞痛，过去有高血压病，平时胸闷，气憋，善太息，急躁易怒，头晕头痛，舌红，脉弦，上亢，阴虚内热。治宜养阴清热，柔肝解痉舒脉。

方四：炒白芍50克，甘草12克，丹参30克，钩藤12克

山甲 12 克, 野菊花 45 克, 茯苓 10 克, 麦冬 30 克, 威灵仙 20 克, 络石藤 20 克, 鸡血藤 30 克, 蜈蚣 2 条, 乌梢蛇 20 克。水煎服。本方适用于阴虚阳亢的冠状动脉痉挛心绞痛患者。

有一类冠状动脉痉挛心绞痛患者, 其发作与情绪激动有关。治宜养阴柔肝, 解痉行郁。

方五: 芍药 50 克, 甘草 10 克, 沙参 20 克, 麦冬 20 克, 生地 30 克, 当归 30 克, 枸杞 15 克, 川楝子 10 克, 郁金 12 克, 鸡血藤 30 克, 全蝎 10 克, 蜈蚣 2 条。水煎服。本方适用于冠状动脉痉挛心绞痛每因情绪激动而诱发的患者。

注: 上述诸方适宜于患者平时服用, 以预防或减少冠状动脉痉挛心绞痛之发作。至于急性发作时, 仍须含服救心丸之类或硝酸甘油片以缓解之。

24. 急性心肌梗塞

急性心肌梗塞是临床常见的心脏病, 病情复杂, 死亡率高。绝大多数患者在心肌梗塞前有先兆表现。临床医生只要对此病有足够的认识, 早期诊断, 及时治疗, 对降低病死率有积极意义。

急性心肌梗塞是冠状动脉硬化, 痉挛, 栓塞, 血流中断, 心肌缺血缺氧, 造成心肌急性坏死的一种心脏病。绝大多数患者有过度劳累、情绪激动、受寒着凉、暴饮暴食(饱餐)等诱因。

急性心肌梗塞的临床表现: 剧烈而持久的心绞痛样心前区疼痛, 休克, 心律失常, 心悸气短, 甚至心脏骤停, 进行性心电图改变, 伴有发烧, 白细胞增高, 红细胞沉降率增快, 血清酶活力增高等症状。

急性心肌梗塞的先兆症候群: 先兆症候群的出现可因患

者的个体差异而有所不同,大体可归纳为以下五个方面:①以往有高血压、冠心病或心肌梗塞史,近一月来又出现心绞痛,且较以前为严重。②心绞痛发作次数更为频繁,发作时间延长而且转为定时,疼痛加重,常在夜间发作而且服硝酸甘油片不易缓解。③心绞痛时伴有恶心、呕吐、大汗、心律失常、血压大幅度波动,并有恐惧不安或濒死之感。④伴有心功能不全。⑤进行性心电图改变。

急性心肌梗塞属于祖国医学心悸、怔忡、真心痛等的范畴。中医认为,急性心肌梗塞多因心阳不振、心血淤滞、心络痹阻所致。严重时可出现阳气暴脱,阴气内竭,阴阳离决的危象。中医还认为,过度激动,暴食,受寒等会直接影响人体阴阳、气血、脏腑、经络功能失调,从而产生痰阻、寒凝、气滞、血淤等病变,痹阻心脉,发生胸痹心痛。

急性心肌梗塞发生时的舌象改变有一定的特征及演变规律,一般由薄→腻→黄→黑为逆;由黑→黄→腻→薄为顺,薄白苔多见于急性心肌梗塞的早期或恢复期。病程中始终为薄白苔者,一般病情轻,合并症少,预后较好。如舌苔黄腻持续不退,病情多有恶化的可能。

急性心肌梗塞多属本虚(气虚)、标实(血瘀、痰浊),治宜标本兼顾,治本侧重益气,治标侧重活血。

治疗方法

一、扶正固本,调整阴阳。

方一:红参6克,制附片30克(先熬),当归15克,白术12克,黄芪30克,干姜10克,桃仁10克,红花10克,瓜蒌15克,薤白20克。水煎服。

本方适用于治疗急性心肌梗塞患者的心绞痛、心悸症。

方二:麦冬20克,党参60克,五味子15克,山药30克,

山茱萸12克,熟地20克,当归12克,枸杞12克,炙甘草10克,郁金15克。水煎服。

本方适用于急性心肌梗塞患者心悸气短的治疗。

二、对症治疗,顾及整体:

方三:黄芪60克,当归10克,赤芍12克,川芎12克,红花10克,蒲黄12克,五灵脂12克,乳香10克,没药10克,郁金20克。水煎服。

本方适用于急性心肌梗塞患者心绞痛的治疗。

方四:吴茱萸10克,黄芩10克,竹茹12克,陈皮10克,法半夏12克,茯苓12克,旋覆花12克,代赭石30克。水煎服。

本方适用于急性心肌梗塞先兆症状恶心呕吐的治疗。

方五:龟板15克,鳖甲15克,生牡蛎30克,生地30克,党参60克,麦冬20克,当归15克,甘草10克。水煎服。

本方适用于急性心肌梗塞患者心动过速的治疗。

方六:红参10克,(另煎兑服),制附片20克(先熬),干姜10克,五味子15克,炙甘草10克,桂枝12克。水煎服。

本方适用于急性心肌梗塞患者心动过缓的治疗。

方七:黄芪60克,白术30克,茯苓20克,桂枝12克,泽泻20克,红参10克(另煎兑服),麦冬20克,制附片20克(先煎)。水煎服。

本方适用于急性心肌梗塞患者心力衰竭的治疗。

方八:红参10克(另煎兑服),制附片30克(先熬),生龙骨30克,生牡蛎30克。水煎服。

本方适用于急性心肌梗塞患者休克的治疗。

25. 慢性心力衰竭

慢性心力衰竭是临床常见重危症之一，多见于冠状动脉粥样硬化性心脏病、高血压心脏病、风湿性心脏病、肺原性心脏病等患者。

慢性心力衰竭的临床表现是：持续性心慌心累（心悸怔忡）；脉搏疾数；呼吸困难（气短），不能平卧；水肿，以下肢浮肿为明显；发绀（口唇青紫）；颈静脉怒张；肝肿大等。

慢性心力衰竭属于祖国医学“怔忡”、“心悸”、“水肿”“喘症”、“症瘕”等范畴。中医认为本病是以心为主，又累及肺脾肝肾的一种病证。其诱因与外邪的反复侵袭、劳累过度以及脏腑功能失调等因素有关。《素问》云：“水病下为跗肿大腹，上为喘呼不得卧者，标本俱病”。说明客邪久侵，内及于心。

中医将慢性心力衰竭的临床证候和体征，大致归纳为：①水气凌心：证见心悸，怔忡，脉结代等。②水饮射肺：咳嗽，咯血，喘促，不能平卧。③脾肾阳虚、水湿泛滥：恶心，纳差，便溏，四肢浮肿，甚则出现胸水、腹水等。④淤血停滞：面色晦暗，颈脉动，肝肿大，舌质紫暗，脉涩等。上述诸症中又以呼吸困难、心悸、水肿为心力衰竭的三大主证。

中医治疗慢性心力衰竭的法则主要有“益气，温阳，利水，化淤”。温阳、益气是治疗心力衰竭的主要措施，利水是重要环节，而活血化淤常贯穿治疗的始终。

方一：红参须10克，黄芪30克，瓜蒌12克，薤白12克，桂枝10克，枣仁12克，麦冬20克，五味子15克。水煎服。

本方适用于气阴两虚、胸阳痹阻之心力衰竭患者，证见心悸气短，胸闷心烦，口干出汗，舌淡红，苔薄白或薄黄，脉细弱或细数。

方二：生地15克，茯苓15克，白术12克，桂枝10克，当归12克，赤芍12克，红花10克，丹参15克，川芎10克，炙甘草10克，水煎服。

本方适用于心阳不振，心血淤阻之心力衰竭患者。证见心悸怔忡，心胸刺痛，口唇青紫，舌有淤点，苔白润，脉细涩或结代。

方三：制附片15克（先熬），泽泻10克，法夏10克，肉桂6克，淮山药30克，茯苓12克，山萸12克，葶苈子12克，五味子10克，甘草6克。水煎服。

本方适用于肺肾气虚、痰浊壅盛之心力衰竭患者。证见咳嗽气喘，不能平卧，心悸自汗，痰清稀或黄稠且量多，舌紫暗，苔白滑或黄腻，脉沉细或弦滑。

方四：红参6克，制附片15（先熬），炙甘草10克，桂枝10克，白术12克，干姜10克，茯苓12克，泽泻12克。水煎服。

加减：肿甚者加防己12克、黄芪40克，咳嗽者加杏仁12克；呕吐者加木香、砂仁各6克。

本方适用于阳气衰微、水湿泛滥之心力衰竭患者。证见心悸气短，汗出肢冷，全身浮肿，舌体胖嫩，苔白润，脉微细或结代。

方五：党参60克，麦冬30克，五味子30克，茯苓20克，丹参30克。水煎服。

加减：心悸甚者加炙甘草、酸枣仁；气喘甚者加葶苈子、肉桂、炙麻黄；水肿甚者加茅根、泽泻；恶心呕吐者加法夏、生

姜；肺心病者可用本方合苏子降气汤联用；风心病者合血府逐瘀汤；高血压心脏病者可于本方中加地龙、川牛膝、淮牛膝。

26. 病态窦房结综合征

病态窦房结综合征（简称S. S. S.），是窦房结及其周围组织的器质性病变，引起功能障碍或衰竭，从而产生了一系列心律失常，并可伴有不同程度的脑、心、肾等供血不足的症状，构成了一组综合征，临床表现以脏器组织缺血为主，多见心动过缓，停搏，眩晕，心悸，乏力，失眠，记忆力减退，呼吸不畅等症状，最重者可致昏厥。多见于老年人。

病态窦房结综合征属于祖国医学“胸痹”、“厥证”、“脉结代”、“寒厥”、“血厥”的范畴。《素问·厥论篇》说：“寒厥因阴气胜，阳气衰”。《素问·本神篇》又说“肾气虚则厥”。说明阳气虚衰是病态窦房结综合征的主要病机。

本征有持久性的脉来迟缓，系心肾两脏功能不足，阳气衰微，阴寒之邪内侵，凝聚不解，使阳气失于敷布，气血运行受阻所致。《内经》说：“经脉流行不止，环流不休，寒气入经而稽迟”，“病属寒，脉多迟”。各器官长期灌注不足，而有气滞血淤的表现。

病态窦房结综合征之脉象常以迟、涩、结、代为主，迟涩之脉为气血不足，寒凝血淤之象，而结、代脉皆气血虚弱之证。张景岳谓结脉“多由气血渐衰，精力不佳，所以断而复续，续而复断”，《素问》谓代脉系“代则气衰”。《中医简明辞典》谓结脉“主阴盛气结，气壅痰滞，积聚症瘕”。代脉“主脏气衰弱，多见于心脏疾患、惊恐、跌打重症”。

祖国医学认为本病脉象之迟数交替出现（心房纤颤、心

律阵发性加快),是“阴极似阳”,“阴损及阳”之危候。明代赵献可在《医贯》中作过本病症状表现的较详细的描述:“有人平居无疾苦,忽如死人,身不动摇,默默不知人,目闭不能开,口噤不能言……但如眩冒,移时方寤,此由汗出过多,血少气并于血,阳独上而不下,气壅塞而不行,故身如死,气过血还,阴阳复通,故移时方寤,名曰郁冒,亦名血厥”。指出本病以眩晕、畏寒、肢冷,发时“忽如死人”为主证。

本病多由阳虚、血淤与气血不足引起,治宜益气,养血,温阳,活血,化淤。

方一:红参6克,制附片15克(先熬),黄芪30克,甘草10克,桂枝10克,当归12克。水煎服。

本方对病窦综合征有较好的治疗效果,可以提高心率,纠正心律紊乱,改善心功能及由于心脏供血不足而引起某些器官血液灌注不良所产生的一系列症状。

方二:制附片15克(先熬),麦冬15克,生地30克,熟地15克,炙甘草10克,大枣30克,白术12克,茯苓12克,炙麻黄10克,玄参30克,桂枝12克。水煎服。

本方温心阳兼补心阴。《景岳全书》谓“善补阳者,必于阴中求阳,则阳得阴助而生化无穷”。故补阳之中必兼补阴,方能阴阳相济,互为促进,而使心功能恢复正常。

方三:仙灵脾30克,川芎12克,黄芪30克,补骨脂12克,五味子15克,党参60克,玉竹12克,菖蒲12克,当归20克,干姜10克。水煎服。

本方适用于气虚型病态窦房结综合征。

方四:肉桂6克(后下);制附片30克(先熬),生地20克,仙茅10克,巴戟天12克,三七粉3克(冲服),丹参30克,麦冬20克,黄精15克,炙甘草12克。水煎服。

方五：肉苁蓉15克，桂枝15克，沙参30克，菟丝子12克，党参30克，当归20克，细辛6克。水煎服。

方四、方五均适用于肾阳虚型病态窦房结综合征。

科学实验表明，仙茅、补骨脂、桂枝、当归、附片、肉苁蓉、仙灵脾、菟丝子对病态窦房结综合征的治疗均有重要作用。但温补药多系辛温燥烈之品，易于伤津耗液，故必须伍用养阴生津之品如生地、麦冬、黄精、玉竹、沙参等。所谓“善于补阳者，必于阴中求阳；善于补阴者，必于阳中求阴”。

方六：活心丹(成药)，每次2丸，每日服2次。

方七：瓜蒌30克，薤白30克，党参30克，麦冬20克，五味子20克，桃仁10克，红花10克，当归15克，熟地10克，川芎10克，丹参30克，赤芍10克。水煎服。

方六、方七均适用于气滞血淤型之病态窦房结综合征。

方八：附子注射液8克，加5%葡萄糖液500毫升，静脉滴注，并每晚再加肌注附子注射液4克，此为一日量，两周为一疗程。一般治疗两个疗程，症状可有改善。

附子能提高与改善窦房结功能及心功能，尤其对阳虚病例疗效显著。

可见，病态窦房结综合征患者患病日久、阴阳两虚而阳虚为甚者，宜用温而柔施治，不宜用热而燥之药。在着重解决阳虚气虚的同时，要相应的处理好气血同源、阴阳相关与寒滞、血淤、痰浊等因虚而实的病理变化。只有这样，疗效才能提高。

针灸疗法

针灸可作为病态窦房结综合征的辅助治疗。体针取穴：足三里、内关、间使、通里。耳针取穴：心、小肠、神门、交感、皮质下。

27. 无 脉 症

无脉症，又称多发性大动脉炎，亦称缩窄性大动脉炎。

无脉症，血压测不出，脉搏摸不到，而病人的心脏却在跳动，也没有休克现象。只是有的病人伴有发热、乏力、面色苍白、心悸、气短、头晕头痛、健忘、视力减退、胸痛、关节疼痛、肢体麻木、昏厥、癫痫样发作等症状（不一定以上症状全都具备），实验室检查可有血沉增快、白细胞计数增多等现象。

人的心脏通过左心室的收缩，把血液压进主动脉，再通过主动脉之分支供给全身。动脉富于弹性，可以伸缩搏动。当主动脉至桡动脉的血流通道发生障碍，桡动脉不能搏动时，就出现无脉症。无脉症主要是多发性大动脉炎引起。其他一些疾病如血栓闭塞性脉管炎等也可引起无脉症，但较少见。主要是多发性大动脉炎引起者为多。故这里指的无脉症即为多发性大动脉炎。无脉症的基本病理是血管管腔变窄堵塞，或血管受压受阻。

无脉症属于祖国医学“脉痹”、“虚损”、“眩晕”、“淤血”等范畴。中医认为本病病因与先天不足，后天失养，感受寒湿之邪致使气血受损，脏腑失调、脉络受阻而发病。《素问·痹论》云：“风寒湿三气杂至合而为痹，……痹在骨则重，在脉则血凝而不流……”。《素问·调经论》云：“寒独留则血凝泣，凝则脉不通”。人体感受寒湿之邪。阻遏脉络，耗伤正气，痹证迁延日久，寒湿之邪内侵五脏，遂发生五脏之痹，累及心则心悸、胸痛；累及肝则视力减退；累及脾则乏力；累及肺则气短；累及肾则关节疼痛。《素问·痹论》云：“五脏

皆有合，病久不去者，内舍于其合也。……脉痹不已，复感于邪，内舍于脾……”故本病的伴随症状错综复杂。祖国医学认为，脏者藏也，藏精气而不泄，藏邪气亦难愈。邪入阴血，阻遏血脉，致病变多端。女子阴血旺盛，易生淤滞，故本病以女性为多见。

有的无脉症可见全身发热而局部发凉的症状，或只见局部红肿发热灼痛而体内无热象。

祖国医学认为无脉症的临床症状虽多种多样，但都有血脉痹阻、淤血阻滞的共同证候。病机是邪气闭塞，正气不得宣通，脉道潜伏不显。临床采用温阳散寒，扶正固本，活血化淤等治疗，经过一段时间后随着气血恢复运行，脉管通畅，无脉症往往能有显著的改善，使病情不再发展，有一部分无脉症患者可以恢复正常的血压和脉搏。

无脉症多数为上肢脉搏摸不到，上肢血压测不出，下肢血压则正常或增高。

无脉症治宜温阳散寒，理气活血，通脉开窍。

方一：麝香0.05克，制马钱子粉0.2克，红参粉1克，制成药片二片，密闭保存，勿使泄气。每次服二片，每日服二次，饭后服。

方二：化症回生丹(成药，照说明服用)。

方三：黄芪60克，川芎10克，当归10克，红花10克，桃仁10克，桂枝10克，附片30克(先熬)，赤芍10克，鸡血藤30克，五味子15克，麦冬15克，党参30克。水煎服。

方四：当归10—50克，白芍10—50克，丹参10—50克，附片30克(先熬)，枸杞30克，独活10克，鸡血藤30克，茯苓12克。水煎服。

注：方中当归、白芍、丹参用量可由10克逐渐增至50克。

方五：制附片30克(先熬)，淫羊藿(仙灵脾)30克，桂枝10克，葛根30克，党参30克，黄芪30克，当归15克，红花12克，丹参30克。水煎服。

针灸疗法

取穴：太渊，内关透外关，合谷透劳宫，曲池透少海。
强刺激或电刺激，每天一次，十天为一疗程，需治疗数月。

目前对上肢无脉症的治疗尚无特效疗法，服中药及针灸治疗有一定疗效，一般须连治数月，才能获效。应说服患者坚持服药，坚持作针灸治疗。

28. 心脏神经官能症

心脏神经官能症是由于神经功能失调，引起心脏血管功能紊乱所产生的一种综合征。患者最常见的自觉症状是心慌，心跳加快，心前区痛，呼吸不畅，经叹气样呼吸才觉得舒适，全身乏力，易激动，潮热，手冷，多汗，颤抖，头晕，失眠，多梦，小便频繁等等。每因情绪波动或劳累而发作。但多次心电图检查亦未发现心脏有实质性病变，全面体格检查亦无异常发现，而患者认为自己患心脏病，情绪紧张，严重失眠，全身无力，稍一活动则感心悸，呼吸迫促，两手发抖。

现代医学研究认为，心血管系统主要受神经系统的调节，即高级神经中枢通过交感神经和副交感神经调节心血管系统的正常活动。由于外来的和身体内部的各种因素的作用，使中枢兴奋和抑制过程失调，神经系统正常活动规律受到干扰，心血管系统的功能也因而发生紊乱，引起心脏神经官能症。

心脏神经官能症属于祖国医学“惊悸”、“怔忡”、“不寐”、“眩晕”等范畴。祖国医学认为，“心藏神”，“心主血脉”。心

主管人体精神、意识和血液运行的功能。如果心的功能发生障碍，就会引起一系列的症状。一般说来，体质虚弱，久病，忧思惊恐等均可导致气血亏耗不能养心。具体地说，心脏神经官能症大多由于平素心虚胆怯，情志不畅，暴惊暴恐，损伤心气，扰乱心神；或因心脾血虚不能养心；或因肾阴不足，心火内动；或因心阳不振，心气虚弱而致病。经云：“心主神明”，“心者精神之所舍”，“心者五脏六腑之主也，……故悲、哀、愁、忧则心动，心动则五脏六腑皆摇。”“心动”就是心脏血管功能发生紊乱。治宜养心安神。

方一：桂枝12克，生龙骨30克，生牡蛎30克，甘草10克，党参30克，炒酸枣仁25克，炙远志12克，黄芪30克，当归12克，白芍30克。水煎服。

方二：浮小麦30克，大枣30克，甘草15克，党参30克，麦冬20克，五味子20克，酸枣仁12克。水煎服。

针灸疗法

主穴：内关。

配穴：神门，足三里，三阴交，太溪。

方法：主穴每次均用，配穴随证加减。中等度刺激，使得气感向肢端放散。其中内关穴宜斜刺，深1—1.5寸，针尖向上，用小幅度捻转法，使针感扩散至肘、腋、前胸等处。留针20—30分钟，中间行手法2—3次，每日或隔日针治一次，10次为一疗程。一般需作2—4个疗程。

推拿疗法

方法1：病人直坐，医生用双手掐住病人手腕附近的内关穴，用力轻重以病人能耐受为度。掐完后用手掌轻揉内关穴处，以减轻酸胀不适感。

方法2：病人仰卧屈膝，足底部平放于床上，医生用手

指掐病人足部大拇趾与二拇趾之间的太冲穴，掐2—5分钟，掐时应作间歇，掐后轻柔地加以抚摩，以消除掐后引起的皮肤不适。

方法3：病人仰卧，医生用两手掌放在病人的胸部（心脏部位），左右来回横摩5—10分钟，摩到肋巴骨部位时，用力可稍重，摩到腹中部时用力应缓慢而轻柔。

方法4：病人俯卧，医生站在病人的头部前方，用双手直推病人背脊（双手紧贴背部皮肤），自上而下来回推摩5—7分钟。如病人皮肤干燥，或肌肉瘦削，医生双手蘸酒再推。用力轻重以病人能耐受为度。

方法5：病人俯卧，医生坐在病人头部前方，用手掌在病人颈项作自上而下的摩动，或左右来回摩动，另一手可扶住头部，用力轻重以病人能耐受为度，摩动5—7分钟。

这种手法，能调和气血，安神开窍。

方法6：病人直坐或仰卧，前臂平伸，手掌向上，医生先用大拇指在手心到肘窝间来回摩动3—5分钟，然后用一手拇指按住病人手腕附近的内关穴，另一手拇指按住病人手腕横纹尺侧的神门穴，用手按掐5—7分钟，然后轻轻揉几下，以消除按掐的酸胀不适感。

这种手法能镇静安神，宁心通络。可作为心慌、心跳快、呼吸不畅、头晕、失眠的辅助治疗。

心脏神经官能症的治疗，首要的是要热情帮助患者解除思想顾虑，不要被一些自觉症状（检查心脏无病变）所吓倒，振作精神，合理安排好日常生活，保证充足的睡眠，合理的脑力活动，坚持体育锻炼，从事适当的文娱活动，培养乐观主义精神，这对提高疗效是十分有益的。

心脏神经官能症并非不治之症，只要患者自己能正确对

待疾病，乐观向上，振奋精神，轻松愉快，积极从事体育锻炼，也可作一些太极拳、气功等辅助疗法，坚持针灸治疗，自能逐渐减轻自觉症状，最后获得痊愈。

29. 心房纤颤

心房纤颤是心房内异位起搏点极快而不规则地发出冲动所引起的心律失常。心房纤颤时，心音强弱不一，脉搏快而不规则，每分钟120—180次之间。症状有心悸、胸闷与惊慌。心房纤颤常见于风湿性心脏病、冠状动脉粥样硬化性心脏病、高血压心脏病等器质性病变，可通过心电图检查而确诊。

心房纤颤发生后对心脏功能有不良影响：①降低心脏储备力，冠状循环及脑部血供减少，诱发心力衰竭。经研究证明，心房纤颤变为窦性心律后，即使心率无明显改变，心脏排出量常可增加20—40%，劳动耐量明显降低。②心房纤颤发生后还易引起心房内血栓形成，部分血栓脱落可引起动脉栓塞，临床上以脑栓塞为最常见，常导致死亡。

心房纤颤属于祖国医学“心悸”、“怔忡”等范畴。本病多因气虚或血虚，或气滞血淤，或肝胆郁热，扰及心神，证见心悸，气短，头晕，情绪激动或劳累后每易诱发心房纤颤。伴口苦，目赤，口干，干呕，舌红，苔黄，脉结代。治宜益气安神。

关于本病的治疗，明·绮石云：“怔忡、惊悸种种神病者，必本于气治，盖安神必益其气，益气必补其精”。这一论点，对本病治疗颇有指导意义。

方一：炙甘草30克，当归30克，酸枣仁15克，龙胆草12

克，泽泻10克，木通10克，竹叶6克，菊花10克。水煎服。

本方适用于高血压心脏病患者之阵发性心房纤颤。

方二：红参10克(另煎兑服)，五味子10克，生龙骨30克，生牡蛎30克，炙鳖甲15克，生地30克，麦冬15克，石斛15克，浙贝10克，淮牛膝30克，天冬15克。水煎服。

本方适用于风湿性心脏病患者惊慌心悸症状明显的心房纤颤。

方三：党参60克，苦参30克，五味子30克，麦冬30克，玉竹12克。水煎服。

本方适用于风心病患者之阵发性心房纤颤。

笔者曾用本方(方三)治疗一风心病心房纤颤患者(女，35岁)。经三家医院心电图确诊为心房纤颤，因伴有预激症候群，不适宜作电击除颤，也不宜服奎尼丁除颤，乃延余医治，试用本方治疗，服五剂后，脉象好转，继进五剂，心脏听诊已无心房纤颤，前往三家医院复查心电图，提示心房纤颤消失，已转为窦性心律。

30. 短暂性脑缺血发作

短暂性脑缺血发作是脑血管疾病的一种临床类型。以反复发作的短暂性语言、运动或感觉障碍为其特点。如不及时加以控制，部分病人就会演变成完全性中风(脑血管意外)。

人的脑细胞对缺血缺氧极为敏感，脑的血液供应不足，就会使脑组织受到损害而产生一系列严重症状，人们常把这种由于急性脑血液循环障碍导致的严重脑危象称之为中风或卒中。

中风有多种类型。按其性质可分为出血性中风与缺血性

中风。根据病情轻重又可分为大中风与小中风。由于血管破裂或血管闭塞所造成的持久性难治性脑损害症状者称为大中风或完全性中风。而小中风则指短暂性脑缺血发作。

短暂性脑缺血发作，又称脑供血不足，每次发病持续时间不长，数秒钟，数分钟，数小时不等，最多不超过24小时。症状来得快，消失也快，恢复后不留任何后遗症。具体症状为：突然偏瘫，口舌蹇涩，语言不清，突然肢体麻木，无力，四肢沉重，在动作中掉物、摔物，头晕目眩，单眼黑矇或失明，或视物飘动，走路摇晃不稳，动作不协调等等。

本病发作时血压可突然降低或升高。

短暂性脑缺血发作的原因很多，心脏病、动脉粥样硬化、糖尿病、高脂血症、颈椎病等是主要和常见的病因。情绪紧张、劳累、伤风感冒可促使其发生。

由于本病症状来的快，消失也快，且不留后遗症。有些病人到医院就诊时查不出神经系统有中风迹象，无经验的医生常诊断病人“无病”。

短暂性脑缺血发作属于祖国医学“中风先兆”之范畴。中医认为本病与七情六淫、风寒外袭、饮食不节、色欲过度等因素有关。

中风先兆的辨证施治可分为以下几种类型：

一、风火挟痰型：平时头痛头晕，面红目赤，口苦耳鸣，便干溲赤，心烦易怒，舌红苔黄。治宜泻肝火，化痰热，息肝风。

方药：寒水石30克，生龙骨30克，钩藤15克，生牡蛎30克，生石决明30克，磁石30克，滑石30克，地龙15克，赤芍12克，菖蒲12克，川芎12克。水煎服。

二、肝阳上亢型：平素头痛眩晕，目胀耳鸣，失眠健忘，

烦热多梦，肢麻震颤，突然发生中风先兆。治宜滋阴潜阳，镇肝息风。

方药：生赭石30克，酸枣仁12克，生石决明30克，生龙骨30克，生牡蛎30克，白芍30克，淮牛膝30克，玄参15克，生龟板30克，川楝子12克。水煎服。

三、气虚夹瘀型：素有头痛眩晕，形体肥胖，气短懒言，身倦嗜卧，恶寒肢冷，心悸，舌胖嫩，脉涩。突然发生中风先兆。治宜益气通络。

方药：黄芪60克，当归10克，赤芍10克，地龙10克，川芎10克，红花10克，党参30克，桃仁10克，鸡血藤30克。水煎服。

四、肾虚痰浊型：平素面色㿔白，精神不振，形寒肢冷，头晕目眩，耳鸣耳聋，失眠多梦，腰膝酸软，腰痛。突然发生中风先兆。治宜滋肾明，补肾阳，开窍化痰通络。

方药：生地30克，巴戟10克，山茱萸12克，石斛12克，肉苁蓉12克，制附片20克(先熬)，五味子10克，肉桂6克，茯苓10克，麦冬15克，菖蒲10克，远志10克，钩藤15克。水煎服。

31. 颈 椎 病

颈椎病又名颈椎综合症，为颈部长长期劳损等原因引起颈椎间盘组织以及颈椎骨与关节逐渐发生退行性变而出现临床各种症状的一种疾病，中年以后尤为多见，病情绵延不愈，时轻时重。症状有颈肩疼痛，上肢麻木，颈活动受限制，握力减弱，经常落枕，肌肉萎缩等。X线摄片可以确诊。

脑力劳动者由于长期静坐低头伏案工作，容易促使颈椎

间盘退化变薄，骨质增生，形成骨刺，以致椎间隙逐渐变窄，椎间孔缩小，或韧带、关节囊松弛，因而使颈髓或颈神经根受到压迫或刺激，受这些神经支配的区域如头、颈、肩、背、臂、手及胸前区产生疼痛和麻木感，头颈活动受限。部分病人还因压迫了向脑部供血的椎动脉，出现头晕，头痛，视力减退等脑供血不足的症状。颈椎病人最大的痛苦是头颈不能自由活动，手臂刺痛和麻木感，尤其是在头向后仰时，神经受压加重，疼痛和麻木感更加强烈。

颈椎病的临床表现，依病变部位、受压组织以及压迫轻重而有所不同，大致可分为神经根型、脊髓型、椎动脉型、交感神经型等四型。各型之间症状常彼此参杂。

一、神经根型：本型发病率最高。主要由于患侧突出物刺激或压迫神经根所致。临床表现为颈、肩、背疼痛和沿颈脊神经节段走行方向的烧灼样或刀割样疼痛，伴有针刺样或过电样串麻感。患侧上肢发沉、无力、握力减退，受压后有酸胀、麻木等症状。

二、脊髓型：此型症状乃脊髓血运障碍所引起。病人早期常出现一侧的上、下肢或两侧上、下肢单纯的运动障碍、感觉障碍或两者同时存在的症状，亦可为一侧上肢和对侧下肢出现运动障碍。有些病人，还有头痛、头晕等头部症状和排尿障碍等骶神经症状。随着病情的发展，可逐渐出现脊髓明显的受压症状，甚至四肢瘫痪、卧床不起。

三、椎动脉型：患者颈肩痛或颈枕痛与神经根型症状大体相同，且还有头晕、恶心、呕吐、位置性眩晕、猝倒、耳鸣耳聋、视物不清等椎动脉供血不全的症状。这些症状，往往因转动头部，侧弯头部而诱发或加重。

四、交感神经型：病人除有神经根型或脊髓型颈椎病的

临床表现外，尚合并有眼部症状(眼窝部胀痛、视物模糊、瞳孔扩大)、头部症状(头晕、头痛、枕部痛)、心脏不适(心动过速或心动过缓)、周围神经血管症状(血管痉挛引起肢体发凉、肢体与头面部麻木感，或因血管扩张引起指端发热、疼痛或痛觉过敏)和多汗或少汗等一系列交感神经症状。

颈椎病属于祖国医学“痹证”范畴。按中医的辨证分型可分为下列五型：

一、痹证型：《素问·痹论》中说：“风寒湿三气杂至，合而为痹也。其风胜者为行痹，寒气胜者为痛痹，湿气胜者为着痹。”《济生方》说：“皆因体虚，腠理空虚，受风寒湿而成痹也”。痹证型颈椎病的症状表现为：颈项剧痛，转动不便，掣引肩背。遇冷及感冒易发，颈背旁可扪及条索状硬块结节，伴枕部头痛等。

二、气虚血瘀型：“《医林改错》指出：“元气既虚，必不能达于血管，血管无气，必停留而瘀”。气虚与血瘀互为因果，构成了“本虚标实”，“虚中挟实”的病理特征。气虚血瘀型颈椎病的症状表现为：头痛如裂，或头昏，眩晕耳鸣，头重似倾，项强，手指麻木，颈肩部有结节扪及，压痛明显，四肢乏力，神疲心悸，畏寒气短，或眼睑无力。稍有感冒、受凉、疲劳、失眠等常诱发颈椎病的上述症状。

三、痰瘀交阻型：朱丹溪说：“痰挟瘀血遂成窠囊”。痰与瘀既是两种不同的病理产物，又是两种主要致病因素（痰瘀致病），痰瘀之间存在着不可分割的内在联系，它们互存互依，相互转化，共同消长，瘀血阻络可使津液难行，聚为痰浊，痰浊滞经，亦可使血运不畅而成瘀血。痰瘀交阻型颈椎病的症状表现为：头痛如刺或钝痛，放射至肩臂，手指麻木，头目昏蒙，项背剧痛，颈背扪及结节硬块，压痛明显。发作时伴

恶心呕吐，胃纳不佳，心悸，肢体软弱无力，或肌肉萎缩，或喉间痰缠，或大便不调，或面部充血，或一时性精神失常，昏迷，失眠，或嗜睡。

四、气滞血瘀型：《素问·调经论》指出：“五脏之道皆出于经隧，以行血气，血气不和，百病乃变化而生”。中医认为，“气为血帅，血为气府，气行则血行，气滞则血滞”。说明气滞可导致血瘀。肝以血为体，以气为用，藏血以养体，疏泄以其用，若失疏泄，初病在气，久则伤血，以成瘀血之证。气滞血瘀型颈椎病的症状表现为：头痛如掣行走不定，但有一固定痛点，手指发麻，头晕胸闷心悸，时而精神兴奋，时而抑郁不振，喜叹息，大便不调。女子以月经前发作明显。舌有瘀斑。

五、肝肾不足挟瘀血型：肝肾不足，筋骨失养，气血不足，瘀血阻络，精血亏虚，髓海不足。肝肾不足挟瘀血型颈椎病的症状表现为：肢体沉重，抬举乏力，步履蹒跚，头痛绵绵而不移，肢体麻木，肌肉萎缩，脑转耳鸣。

颈椎病治宜补益气血，活血化瘀，散风利湿。

方一：黄芪30克，党参30克，丹参30克，白芍20克，川芎10克，生地20克，桃仁12克，红花12克，香附12克，地龙15克，葛根30克，穿山甲15克，土鳖虫10克，威灵仙12克。水煎服。

注：骨质增生之颈椎病重用威灵仙至20克，颈项强硬者，葛根可用至60克。

本方用黄芪、党参补气；桃红四物汤养血活血通络；并用破瘀软坚通脉之土鳖虫、穿山甲、地龙；香附理血中之气而止痛，威灵仙散风湿、利关节、通经络。以上活血化瘀、散风祛湿、舒筋止痛的中药合用，有促使椎间孔周围关节囊

滑膜充血水肿消退的功用，对减轻或解除神经根、脊髓的压迫起积极的作用，从而缓解症状，获取疗效。

方二：熟地30克，鹿含草30克，淫羊藿30克，骨碎补12克，肉苁蓉12克，鸡血藤30克，当归12克。水煎服。亦可制成蜜丸服用。

方三：木瓜30克，白芍30克，巴戟天10克，桂枝12克，皂角刺12克，葛根40克，仙茅12克，淫羊藿30克。水煎服。

加减：痛引头枕耳后者加川芎、羌活；痛引肩臂者加僵蚕、蜈蚣、伸筋草；有瘀血者加姜黄、丹参；烦躁、失眠、多梦者加夜交藤、龙齿；阳虚肢冷者加鹿角霜、黄芪；眼目昏花者加枸杞、菊花。

方四：葛根30克，全蝎10克，蜈蚣2条，乌蛇12克，赤芍15克，川芎15克，自然铜6克，穿山龙12克，木瓜15克，鹿含草30克，黑木耳12克，甘草6克。水煎服。

加减：气候变化时症状加重者，加豨薟草、汉防己；椎动脉型或合并冠心病者加丹参、红花；合并高血压者加玄参、钩藤；气虚者加黄芪、党参；肾虚者加淫羊藿、补骨脂；脾虚者加茯苓、白术。

简易推拿疗法

一、按法：一手固定患者头部，另一手拇指按压患者哑门穴1分钟，能起到消除头晕、头重、头胀等症状，达到安神醒脑之目的。

二、拿法：一手轻按患者头顶，另一手从两侧风池穴开始顺项肌至下方两肩井穴施行拿法，即拿、捏，能起到消除项肌紧张，舒筋活络，消除疲劳等作用。

三、捻法：患者端坐，医生用两指轻捻其锁骨上窝（臂丛神经），这时酸胀感可向两胸壁放射，能起到消除胸骨疼痛，

疏通血脉和改善血液循环的作用。

四、揉法：医生用小鱼际或大鱼际，顺患者颈肌柔缓地施行揉法，使气血运行，血管扩张，肌肉得以松弛。

五、抓法：一手固定患者头部，另一手从前额开始至后枕部顺发际方向来回施用抓法。这时，患者头部可有明显的清醒感觉，可消除烦躁症状，达到安心宁神、舒通血脉的目的。

六、划法：用两手手指尖在患者两耳上方即十二经脉循行处，来回施行划法，能明显改善头晕、耳鸣等症状，能活血通脉。

七、弹拨法：一手固定头部，另一手仔细触摸偏歪之棘突及颈韧带剥离情况，施以弹拨理筋、可使移位的韧带组织复平，使椎体适合生理活动的需要。

八、牵拉法：两手扶住下颌部，轻巧而缓慢地向上进行牵拉，可改善脊髓受压及骨赘刺激。

九、点法：两手拇指分别在两睛明穴轻轻点按，然后沿眉间向两侧太阳穴分推，能起到消除目眩、两眼眶痛的作用。

十、叩击法：以上手法施毕后，两手分别在患者头顶、两肩背部适当叩击，使血脉疏通，气机通畅。

针灸疗法

常用穴：风池、翳风、太阳、大椎、肩髃、列缺、合谷。

备用穴：

1. 神经根型：肩髃、臂臑、曲池、外关。

2. 脊髓型：肾俞、命门、殷门、委中、足三里、手三里、中渚。

3.椎动脉型：印堂、上关、听宫、内关。

4.交感神经型：攒竹、膻中、四白。

方法：每日针刺一次，根据不同类型酌选3—5穴，交替使用，10次为一疗程。病程较久者，可配合应用灸法。

颈椎病的预防：

坚持体育锻炼是预防颈椎病和减轻颈椎病症状的有效方法。体育锻炼可改善血液循环，减轻增生骨质对神经根或椎动脉的压迫，减轻颈椎病的症状，改善颈椎间关节的活动功能，矫正不良的身体姿势，从而能预防和减轻颈椎病。

预防颈椎病的锻炼方法可多种多样，因地、因时制宜，最简易的保健锻炼方法叫做“五分钟颈健操”：包括摇头屈颈，左顾右盼，扩胸旋肩，捶肩拿肘，挥臂扣球等（就是做一些摇头旋肩的自由动作，时间五分钟也可以，这叫做“健康储蓄”，每天坚持做五分钟的简易保健锻炼，长期坚持，必奏保健之功）。

颈椎病患者枕头不要垫得太高，枕芯要软硬适中。弹簧枕头和空气枕头对颈椎病者不利。

32. 植物神经功能紊乱

植物神经功能紊乱，又称下丘脑植物神经机能紊乱，是临床常见的神经官能性病症之一。本病症状繁多，但却没有相应的器质性损害。

植物神经系统之功能，在于维持机体之生命活动，保证体内环境相对稳定与平衡，同时对于正常精神状态之保持、内分泌之调节、各器官活动之协调等均有重要作用。一旦植物神经功能紊乱，就会出现气短、疲乏、倦怠、流涎、多泪、

盗汗、半身出汗、情绪不稳、焦虑不安、健忘、胸部胀满或压迫感、发冷或发热等全身症状。并可出现神经系统症状如失眠、头晕、头痛、头面烘热、沉重、耳鸣、眼睑震颤、感觉过敏等；循环系统症状如心悸易惊、心律不齐、血压不稳、胸部压迫或绞扼感、四肢厥冷、紫绀等；呼吸系统症状如呼吸急促、呼吸困难、气喘、喉头有异物感；消化系统症状如食欲不振、恶心呕吐、腹部胀满、胃痉挛、下腹疼痛、神经性呕吐或腹泻等；泌尿生殖系统症状如尿频、神经性多尿、夜尿、月经失调、性功能障碍；皮肤症状如多汗或少汗、或无汗、阵发性皮肤潮红、皮肤瘙痒或荨麻疹等。

现代医学认为本病是由于神经系统功能障碍——兴奋、抑制两个过程的失调，大脑皮层和皮层下的平衡失调，交感和副交感神经活动失调所致。

根据脉搏、血压、呼吸、植物神经反射、药物负荷试验及基础代谢等检查，可对植物神经功能紊乱进行确诊。

植物神经功能紊乱属于祖国医学“气阴两虚”、“脾肾阳虚”、“心肾阴虚”等范畴。本病以虚证居多，其次为虚实互见，纯实之证较少，受病范围较广泛，五脏六腑几乎都可波及，但最多见为心、肝、脾、肾之病证。其发病原因，常与操劳过度，思虑无穷，七情郁结等有关。气阴两虚症状（神疲乏力，肢软倦怠，自觉气短，颧红面白，自汗盗汗，五心烦热，潮热低烧，眠差多梦等）是植物神经功能紊乱时较易出现的基本证候。植物神经功能紊乱一般可分为下列证型：

一、脾肾阳虚，胃失和降：证见恶心呕吐，唾液多，胃肠蠕动增强，大便稀溏，一有便意即迅速登厕，胃脘持续隐痛，心动过缓，头昏，眩晕，易于精神受刺激之后或站立过久之后（或突然站立时）发生昏厥（跌倒）现象。治宜温补

脾肾，和胃降逆。

方药：制附片30克（先熬），白术15克，党参15克，肉桂6克，吴茱萸6克，香附12克，台乌12克，法半夏10克，砂仁克，炙甘草6克。水煎服。

加减：小便多，加巴戟天10克，桑螵蛸6克。

二、心肾阴虚，肝阳不潜：证见心悸，头晕，盗汗，遗精，两手轻微颤抖。治宜滋养心肾。

方药：熟地20克，当归12克，白芍12克，杜仲15克，麦冬15克，钩藤15克，金樱子20克，莲须10克。水煎服。

三、气阴两虚：证见神疲乏力，五心烦热，颧红面白，潮热，低烧，口燥咽干，自汗盗汗，眠差多梦，动则气促。治宜益气养阴。

方药：黄芪30克，太子参30克，生地20克，地骨皮15克，山茱萸12克，大枣12克，酸枣仁12克，首乌15克。水煎服。

四、肝郁脾虚：证见抑郁不乐，急躁易怒，失眠多梦等。治宜疏肝解郁。

方药：生地40克，当归20克，茯神20克，酸枣仁20克，山药20克，炙甘草12克，陈皮10克，远志10克，沙参12克，丹皮10克。水煎服。

加减：头面烘热，五心烦热者加地骨皮20克，银柴胡10克；心慌惊悸较重者加龙齿10克，紫石英15克；胸中烦热者加炒山栀10克，竹茹10克。

除上述分型治疗外，还可内服综合治疗的药酒，方药为：

黄精90克，枸杞45克，生地45克，白芍45克，夜交藤45克，党参30克，黄芪30克，当归30克，麦冬15克，红花15克，菊花15克，佩兰15克，菖蒲15克，远志15克，用白酒3000毫

升泡一个月后服，每次服10毫升，每日服三次。

中医治疗植物神经功能紊乱，不是通过加强神经系统的抑制过程而取效，而是着重增强机体的机能，从而减轻或消除体内不平衡状态，导致临床症状的改善。

33. 腓肠肌痉挛

腓肠肌痉挛，俗称“脚转筋”，是痛性肌痉挛中最常见的一种。受寒冷刺激而发病者最多，其次为劳动或运动中发作，下肢静脉曲张也可引起腓肠肌痉挛的发作。有的患者在不平卧或快步行走、或跳跃时可有阵发性单侧或双侧腓肠肌挛急，轻者数秒钟，重者数分钟乃至数小时，有的一天之中发作数次乃至数十次。轻者经猛伸下肢或足跟用力向下蹬即可缓解，重时须作热敷或按摩后方可渐渐缓解。治宜解痉缓急。

方一：虎杖30克，猪脚爪一个，米醋适量。用水将虎杖、猪脚爪同炖，炖好后将虎杖药渣弃去，加米醋适量，喝汤吃猪脚爪。

方二、白芍60克，甘草15克，桂枝15克，木瓜10克。水煎服，每日一剂。

本方是《伤寒论》芍药甘草汤加味。芍药甘草汤是酸甘化阴，治疗足挛急不得伸的名方，经现代药理研究证明，对横纹肌、平滑肌的挛急，不论是中枢性的，或末梢性的，均有镇静作用，其中甘草是直接作用于平滑肌和骨骼肌的末梢神经，而芍药的镇痛作用和解痉作用是中枢性的。腓肠肌挛急可能与供血不足有关，加用桂枝以扩张微血管，改善局部供血。加用木瓜则可提高远期疗效。

针灸疗法

主穴：承山，承筋，阳陵泉，后溪，足三里，三阴交。

对正在发作的患者，可单取对侧后溪一穴，手法用强刺激，痉挛可立即缓解；或取承山、阳陵泉、承筋等穴（均为患侧）。进针得气后用泻法。如经常发作者，尤其常于夜间发作者，可每日治疗一次。并配用足三里、三阴交。一般留针¹—2小时，5次为一疗程。承山穴针后加灸，效果更佳。对于好发于运动或劳动中者，活动前可预灸承山、承筋穴，往往可以防止发作。

34. 周期性精神病

周期性精神病，呈周期性发作，每次发作症状相同而间歇期间完全正常。本病多发于女性患者，且与月经周期关系密切。

周期性精神病属于祖国医学“癫狂”范畴。系冲任不足，痰瘀交阻，神机不运，本虚标实。治宜通补冲任，活血化瘀，攻补兼施。

方一：紫石英24克（先煎），巴戟天15克，肉苁蓉15克，丹参15克，肉桂5克（研末冲服），鹿角片12克，三棱12克，莪术12克，香附12克，白芷5克，陈皮6克。水煎服。

本方适用于心悸胆怯，哭泣，自语，情绪低沉，思维迟钝，行为畏缩之周期性精神病。

方二：生牡蛎30克（先煎），龟板30克（先煎），炙鳖甲30克（先煎），丹参15克，麦冬15克，山萸肉15克，钩藤20克（后下），莪术12克，郁金12克，三棱12克，石菖蒲6克。水煎服。

本方适用于情志兴奋，烦躁易动，时有哭笑，心悸不宁，神志恍惚，心怀疑窦，周身烘热，口干咽燥之周期性精神病。

方三：当归15克，川芎10克，熟地20克，赤芍15克，益母草30克，香附15克，郁金12克，石菖蒲12克，远志12克，胆南星10克，茯苓10克。水煎服。

本方适用于痰多、抑郁的周期性精神病。

35. 肋间神经痛

肋间神经痛系指一个或几个肋间发生经常性疼痛的疾病。其症状是：肋间神经分布区出现针刺或刀割样疼痛，时时发作，剧痛时可放射到背部，在咳嗽、深呼吸或用力过猛时疼痛加剧。相应的肋骨边缘压痛明显。X线及B型超声波检查未见脏器异常。

肋间神经痛属于祖国医学“胁痛”范畴。其病因多因气机壅滞，肝失条达，血分不畅，脉络失宣，不通则痛。或久病体虚，肝阴不足，血虚不能养肝，使筋脉失养，不荣则痛。治宜活血化瘀，理气养荣止痛。

方一：柴胡12克，瓜蒌15克，当归30克，红花12克，山甲15克，桃仁10克，大黄10克，玄胡12克，生蒲黄10克，五灵脂10克。水煎服。

方二：沙参15克，麦冬20克，生地30克，枸杞15克，当归20克，川楝子12克，三七粉3克，乳香12克，没药12克。水煎服。

针刺疗法

取穴：内关、阳陵泉、阴陵泉。均留针30分钟，并配合在患处（疼痛最明显处，亦即阿是穴）拔火罐。

36. 不宁腿综合征

不宁腿综合征又称不安腿征、多动腿征。贫血、妊娠末期多见此征，糖尿病、尿毒症、维生素缺乏、前列腺炎、癌肿、震颤麻痹等疾病均可并发不宁腿综合征。其症状是：小腿深部酸痛，困胀，沉紧，发麻，虫爬瘙痒感等多种难以忍受的不适症状，休息及睡前症状加重，活动及按摩后症状可减轻。有时这种症状也可出现于上肢。病程可持续几年甚至几十年。内科及神经系统检查均正常。

本征发病机理尚未明瞭，有人认为与休息时肢体血流量减少，代谢产物在小腿肌肉内堆积，引起局部血液循环障碍，缺血缺氧有关。也可能与局部神经失养等因素有关。活动后可使症状改善。

中医认为不宁腿综合征属于血虚挟瘀症。“血主濡之”，“血和则……筋骨劲强，关节清利”。血不足，则关节活动不利，四肢酸麻，皮肤干燥作痒。轻者，捶捶揉揉即可缓解，重者非得起来走动方能缓解。

中医认为，不宁腿综合征的发病还与肝肾虚损有关。肝主筋，若肝阴不足，筋失濡养，则可出现肢体酸麻不适。肝久虚而失治，肝虚及肾，肝肾阴阳俱虚，风阳入络，病情更趋严重。明·章潢《图书编·肝脏说》谓“肝亏则筋急”。汉·华佗《中藏经》谓“肾生病则腿筋痛”。肝脏又主调节血液，王冰注释《素问》谓“肝藏血，心行之，人动则血运于诸经，人静则血归于藏，何者？肝主血海故也”。休息或睡眠时，人体处于相对“静”的状态，易致肢体筋肉血运不足。不宁腿综合征好发于休息或睡前，可能和此有关。

综上所述，不宁腿综合征的治疗宜养血补虚，活血化瘀。

方一：桃仁15克，红花15克，当归20克，熟地30克，白芍30克，川芎15克，黄芪30克，鸡血藤30克，甘草10克。水煎服，每日一剂。连服5—10天。

方二：生地30克，山药30克，黄精12克，当归12克，石斛12克，赤白芍各12克，白术12克，柴胡10克，山栀10克，茵陈15克，甘草10克，水煎服。每日一剂，连服15—20天。

方三：白芍60克，甘草20克。水煎服。

方四：木瓜30克，淮牛膝30克，白芍30克，甘草10克。水煎服。

方五：党参30克，黄芪30克，桂枝10克，白术10克，茯苓10克，甘草10克，当归10克，熟地10克，白芍15克，川芎10克，木瓜30克，山药30克，酸枣仁10克。水煎服。

针灸疗法

取穴足三里，解溪，后溪。留针15分钟。

推拿疗法

方法1. 病人侧卧，医生双手合抱病人小腿，上下来回摩动（上至膝关节，下至踝关节），用力大小以病人能忍受为度。如病人皮肤干燥，可蘸酒或使用滑石粉，以防止擦伤皮肤。

在推拿过程中，可将小腿肌肉（承山穴处）向上拿提，操作3—5分钟。拿提后再上下摩动，以消除拿提的不适感。

此法之作用，为通气行血，缓解痉挛，逐痹除痛。

方法2. 病人俯卧，膝关节微弯曲，医生用一手拇指置股内侧血海穴处，其余四指分置其相应之股外侧，自上向下至阴陵泉穴平高处止，作钳形揉捏1—2分钟，再以一手四指

置臑上内侧之阴谷穴处，拇指置其相对部位向上拿提3—5分钟，拿提时应将肌肉扣紧，用力大小以能耐受为度。

此法之作用，调和气血，通络健膝。

方法3. 病人俯卧，双腿伸直，医生用双手在病人下肢委中穴、承山穴及腓肠肌处横摩、搓揉，反复搓揉3—5分钟。用力大小以病人能耐受为度。

此法之作用，为活血通络，强筋壮骨。

37. 麻痹性斜视（眼肌麻痹）

麻痹性斜视，又称眼肌麻痹，它不同于面神经麻痹。

眼球的运动靠内、外、上、下直肌，上、下斜肌等六条眼外肌的协调运动。当某一眼外肌或几条眼外肌麻痹后，引起眼球位置偏斜及眼球运动障碍，两眼就不能共同注视一个目标，即仅一眼的视线对正目标，另一眼的位置偏斜而视线偏向目标的一侧，称为麻痹性斜视（眼肌麻痹）。

眼肌麻痹分为外直肌麻痹（内斜视）、内直肌麻痹（外斜视）两种。

临床表现：眼球偏斜，眼球运动障碍，患眼不能向麻痹肌作用的方向转动。如外直肌麻痹时眼球不能向外转动，则眼球向内斜视；内直肌麻痹时眼球不能向内转动，眼球则向外斜视。患者并有复视、头晕、恶心、代偿头位（即头向麻痹肌作用方向偏转）。

麻痹性斜视的发病原因为颅脑疾病（脑膜炎、颅脑外伤、肿瘤或出血等病变），影响支配眼外肌的颅神经；或眼眶局部病变（外伤、炎症）；或全身性疾病如白喉、梅毒、铅中毒、多发性神经炎、重症肌无力等。

麻痹性斜视类似于中医的“目偏视”，病因为中气虚，络脉空虚，风邪乘虚而入。眼与脏腑经络有密切关系，古人将眼分成五轮八廓，其肉轮（包括眼肌）为脾所主。《素问》云：“脾主身之肌肉”。《银海指南》：“中气不足为眼皮宽纵”。《脾胃论》云：“胃虚元气不足，诸病所生”。中医还认为，本病由于风痰内阻，风邪中络，引动肝风。肾虚肝旺，筋脉挛急或缓纵，以致眼球偏斜于一侧。治宜益气和营，祛风通络，扶正鼓邪外出。

方一：黄芪30克，党参30克，白术12克，当归15克，陈皮6克，羌活6克，防风10克，全蝎10克，升麻6克，柴胡10克，甘草3克。水煎服。

加减：恶心者加竹茹10克，菊花10克；头痛减轻后可去防风、羌活，加白附子10克，僵蚕10克，以增强祛风通络之功。

方二：黄芪60克，女贞子30克，旱莲草30克，当归12克，桃仁10克，红花10克，川芎10克，赤芍12克，地龙10克，僵蚕10克，枸杞15克，淮牛膝15克。水煎服。每日一剂，连服20—60剂。

方三：白术15克，乌药12克，沉香3克，白芷12克，紫苏12克，木瓜30克，天麻12克，党参30克，生姜10克，全蝎6克，僵蚕10克，白附子10克。水煎服。每日一剂，连服30—90剂。

据1985年第6期《中医杂志》报道，对眼肌麻痹采取辨证分型治疗，验之临床，有较好疗效。

脾气虚弱：药用黄芪、党参、白术、升麻、柴胡、羌活、防风、陈皮、甘草。

脾肾两亏：药用党参、仙茅、黄芪、续断、淮牛膝、茯

苓、枸杞、防风、五味子、当归、龟板。

风邪外袭，痰湿阻络：药用秦艽、荆芥、防风、羌活、钩藤、全蝎、白附子、僵蚕、木瓜、地龙、当归、甘草。

营卫不和，风邪袭络：药用桂枝、白芍、当归、甘草、生姜、防风、羌活、茯苓、荆芥。

瘀血阻络：药用桃仁、红花、熟地、当归、白芍、川芎、钩藤、鸡血藤、丹参、羌活、防风、郁金、甘草。

针灸疗法

方法1. 内斜视取穴：①童子髻、风池、四白、太冲。②球后、太阳、外关。③丝竹空、鱼腰、头维、光明（足）。

交替针刺，要严格消毒，不宜大幅度捻转。

外斜视取穴：①睛明、眉中、鱼腰、合谷。②攒竹、四白、风池、太冲。③下睛、光明（头）、曲差、京骨。

交替针刺，不宜大幅度捻转。

方法2. 取穴：睛明、承泣、瞳子髻、印堂、四白、丝竹空、太阳、鱼腰、攒竹、合谷。

手法：睛明穴宜用弱刺激，印堂透两侧鱼腰（强刺激），攒竹透鱼腰（强刺激），其他穴位或补或泻，随病人体质而定，一般需留针20—40分钟。

推拿疗法

方法1. 揉太阳穴：病人直坐或仰卧，医生站在病人一侧。医生用两手拇指掌侧分置病人头部两侧太阳穴处揉动1—3分钟后，再以一手扶定头部，另一手拇指自左或右侧自头维穴起，向外下方经太阳穴至耳门穴止，反复摩动2—5分钟。

指揉时用力宜轻揉，摩动时可稍着力。

操作时有酸胀感及放射至额前的感觉，治疗后有头脑清

爽感。

作用：疏风散热，清神明目。

方法2. 掐睛明穴：病人直坐或仰卧，医生坐在病人头部前方。医生用两手拇指甲轻掐两眼内眦之睛明穴1—2分钟后，再以两指指掌侧自睛明穴向外下方沿上颌缘经四白、颧髻至下关穴止，反复摩动1—3分钟。

掐睛明穴后，可配合指揉法，以消除掐法后之局部不适感。摩动时宜缓而有力。治疗时局部有酸麻胀的感觉，这是正常的推拿效应。

作用：疏风清热，通络明目。

方法3. 推攒竹穴：病人仰卧，医生坐在病人头部前方。医生用两手拇指甲置眼内眦上方攒竹穴处施行掐法后，再以拇指掌侧分置两目内眦沿眉弓向外方摩动至太阳穴止。再自眉弓上方用拇指摩动至头部曲差穴止。反复操作2—3分钟。

向两侧摩动时应沿眉弓方向，向上摩动应按垂直方向。

治疗时有酸麻胀的感觉，治疗后局部有温热感与增益视力感。

作用：宣泄太阳热气，活络明目。

38. 周围性面神经麻痹

面神经麻痹又称面瘫，是神经内科中常见的一种疾病。有中枢性面神经麻痹（脑卒中之中枢性面瘫）和周围性面神经麻痹之分。本文着重谈谈周围性面神经麻痹的中药治疗。

周围性面神经麻痹主要表现为口眼歪斜。发病前可先有患侧耳下或耳后部疼痛或不适，继而出现口眼歪斜。患者常

在吹风或受凉后，眼睑闭合不上，流泪，患侧面部表情动作消失，说话发音不清，吃饭时漏饭漏水，额纹消失，不能皱额、皱眉、鼓腮、示齿和吹口哨等，鼻唇沟消失，人中沟由左或向右侧偏，口角下垂或偏向健侧。患者闭眼时，患侧眼球转向外上方，露出白色巩膜。病变影响鼓索神经时，可有患侧味觉障碍，患侧面部感觉减退。部份患者病程迁延日久或恢复不全者，可出现“倒错现象”（即遗留患侧肌肉挛缩和抽搐，使同侧睑裂变小，鼻唇沟加深，口角反歪向病侧），并可有肌肉跳动，面部牵板不适等。

中枢性面神经麻痹能够皱额，而周围性面神经麻痹则不能皱额。两者很容易检查鉴别。中枢性面神经麻痹多发生于脑卒中之后，治疗多不容易恢复。而周围性面神经麻痹多因虚而发病，治疗相对容易些。当然也不能拖延治疗。

周围性面神经麻痹，祖国医学称其为“口眼歪斜”、“口眼喎斜”、“口噤”、“喎噤”等，属“中风”病中的中络症范畴。中医认为，“邪之所凑，其气必虚”，本病多由脉络空虚，外感风寒侵袭面部阳明、少阳之脉，以致经气阻滞，流行失常，气血不和。或风湿痰阻，瘀停脉络；或气虚血瘀，兼挟风痰，上犯头面，瘀滞经脉等导致经筋失于濡养，肌肉纵缓不收，而发生本病。治宜祛风通络。

方一：秦艽10克，白附子10克，川芎10克，红花10克，羌活10克，没药10克，香附10克，白僵蚕12克，桃仁12克，当归12克，地龙12克，全蝎6克，鸡血藤30克。水煎服。

方二：牛蒡子30—40克，白芷6—10克。可根据病情，用量由小逐渐加大。先煎牛蒡子，沸后煎一小时，再加入白芷同煎三次，每次煎30分钟左右。每剂煎汤量宜多些，至少600毫升，每次服200毫升，分3次服完，每日一剂，直至病

愈。除个别患者服药后大便次数增多1—2次外（不需停药，继续服用2—3天后，大便次数可恢复正常），没有其他副作用。病程越短治疗效果越好。

方三：羌活10克，防风10克，白附子10克，茯神10克，半夏10克，胆南星10克，甘草6克，木瓜12克，秦艽10克，僵蚕10克。水煎服。黄酒30毫升分次兑服。

方四：黄芪100克，当归15克，白附子10克，僵蚕10克，全蝎10克。水煎，滤汁后加白酒10毫升，一天分三次服完。

加减：肾阴不足、肝阳上亢者加石决明、天麻、栀子、石斛；脾运失司、内生痰浊者加胆南星、浙贝；头痛者加川芎、夏枯草；失眠多梦者加珍珠母、龙齿、枣仁。

方五：细辛3克，麻黄1克，制川乌10克（先煎），制南星10克（先煎），制白附子10克（先煎），白芷10克，生姜10克，葱白15克。水煎服。

加减：恶寒、头项强痛、身痛者，加羌活、防风；项背强、颈不能转、头难回顾者，加桂枝、葛根；身热、烦渴或头额痛者，加生石膏；唇舌深红而身热者，加夏枯草、大青叶或板蓝根；久病或素体虚弱者，加党参、黄芪、炙甘草、白术、当归、苡仁、枸杞、肉桂、附片等。

方六：台乌10克，沉香末1克（冲服），白芷10克，白术10克，天麻12克，苏叶10克，党参30克，木瓜30克，当归15克，蝉蜕10克，川芎10克，秦艽10克，甘草6克。水煎服。

方七（外敷药）：生南星6克，白芨6克，生草乌6克，白僵蚕6克，共研细末，生鳝鱼血调成糊状，敷患侧，外用敷料保护固定。

方八：白附子30克，僵蚕30克，蝉蜕30克，钩藤30克，海风藤30克，防风30克，川芎30克，制马钱子10克，共研细

末，炼蜜为丸，每丸重6克，每次服1—2丸，每日服3次，温开水或黄酒送服。10天为一疗程。

方九：熟附子90克，制川乌90克，乳香60克。

用法：将上三味药研成细末，混匀，分成10包，每日一次，每次一包，临用前加生姜末放入药面内，用开水调成糊状，即可使用。敷药前嘱患者用热姜片擦患处，擦至局部充血为好，将上药调成糊状敷患侧（上至太阳穴，下至地仓穴），宽约3厘米，用纱布敷盖，胶布固定。嘱患者用热水袋热敷（将热水袋放在纱布上）。第二天换药，配制方法同上。每日换药一次直至痊愈为止。

方十：防风18克（注：此方须重用防风），僵蚕10克，蝉蜕6克，当归12克，川芎12克，细辛6克，蜈蚣2条（炒微黄，研末冲服），甘草6克。水煎服。

本方的特点是重用防风，李时珍《本草纲目》谓防风能治三十六般风。防风不仅善于祛风，还可抑蜈蚣之燥烈。

方十一：马钱子，温水中浸泡6天后取出，每枚切成6薄片，按面瘫范围大小，一片片摆在氧化锌贴膏上（2—3层平展贴在一起），敷贴在患者口角侧，向左歪斜者贴在右侧，向右歪斜者贴在左侧。

针灸疗法

周围性面神经麻痹的治疗，除中药外，以温针灸最为有效，在面部施以透穴针法则疗效更佳。

主穴：阳白透鱼腰，上关透太阳，下关透颧髎，下关透颊车，颊车透地仓，颊车透颧髎，大迎透颧髎，地仓透颧髎，颧髎透迎香，颧髎透四白，地仓透禾髎，地仓透承浆。

配穴：风池、翳风、合谷、曲池、足三里、内庭、丰隆等。

每次选主穴（透穴）1—2个，配穴1—2个，交替使用。

一般初病及恢复期多采用平补平泻法，每穴均留针，并加艾条悬灸十分钟左右。久病者，则多用轻针久留之法，常留针一小时以上，并加艾条悬灸。

推拿疗法

方法1. 推眼轮肌：医生左手大拇指把患者患侧瞳子髎处的肌肉，尽量向太阳穴处拉紧，后用右手大拇指，推揉环眼轮七次。

方法2. 直推印堂至额部七次。

方法3. 揉推太阳穴至率谷穴七次。

方法4. 揉推口轮肌：医生用左手大拇指，把患侧地仓向颊部拉紧，后用右手大拇指环唇揉推七次。

方法5. 揉推耳后：由翳风、风池穴沿胸锁乳突肌至肩部揉推七次。

方法6. 最后按揉合谷或足三里。

周围性面神经麻痹治疗的效果与精神因素有一定的关系，患者应避免过度忧虑、失眠等。有的患者求治心切，私自找江湖医生治疗或不经医生同意，自己胡乱找药吃，往往误事。因此，医生应重视做好患者的思想工作，调动患者的主观能动性，积极配合治疗。在神经功能开始有所恢复后，应加强各单个面肌随意动作的练习（练习皱额、皱眉、鼓腮、启齿、吹口哨等），以巩固疗效。

39. 面肌痉挛

面肌痉挛系指半侧面部肌肉阵发性不规则抽搐。发病之初只是上、下眼睑（眼轮匝肌）轻微的间歇的跳动，逐渐发

展至口轮匝肌，甚至牵涉整个面颊，抽动频繁，眼睑痉挛，眼裂变小。伴有乏力、心烦、纳差、失眠等症状。

面肌痉挛属祖国医学“筋惕肉瞤症”范畴。一般认为系肝风内动或血虚生风，上犯清空，扰乱面部经脉，气血流行失常所致。

就面肌痉挛的临床特点而言，恰与面瘫相反。治瘫需振奋其气机，而治痉挛则应以熄风镇静为主。面肌痉挛的治疗，应从平肝熄风，滋肾养血，豁痰止痉，解热除湿等方面考虑。

方一：白芍60克，木瓜30克，甘草15克，黄芪30克，桂枝12克，茯苓10克，丹参30克，水煎服。

方二：生石膏30克，苍术10克，黄柏10克，槟榔10克，僵蚕10克，蝉衣10克，钩藤15克，制川乌10克（先煎），制白附子10克（先煎），制南星10克（先煎），甘草3克。

加减：久病体虚者加党参、黄芪、白术、茯苓；阴液不足者加生地、天冬、麦冬、元参、石斛；头胀脑鸣，肝阳上亢者加草决明、青箱子、夏枯草、菊花；小便短赤者加车前草、木通、滑石；大便秘者加芒硝、大黄、蜂蜜、草决明。

针灸疗法

针灸治疗面肌痉挛有一定的疗效，但若取面部穴位治疗，则往往失败，甚至会加重病情，这是因为面部穴位易引起阳气上升，阳性善动，故治不对症。针灸治疗面肌痉挛应取四肢穴位和腹部穴位为主，着重取阳明经穴。

取穴：气海（温针灸）、中脘、三阴交、足三里（均用补法）、太冲、后溪、合谷、曲池、内庭、冲阳、丰隆。

笔者曾遇几例面肌痉挛患者，针刺面部穴位引起病情加重，影响中药治疗效果。故在此大声疾呼，望同道注意。病

员也应注意，勿针面部穴位。

针刺四肢穴和腹部穴位，一般用轻刺激手法，留针30分钟以上，每日针灸一次。

面肌痉挛患者，病程短者单独用中药或针灸治疗有效，病程迁延日久者，需中药和针灸疗法同时并用，方能收效。本病与精神因素有密切关系，情绪紧张，七情因素都会使病情加重，影响疗效。因此，医务人员要向病人作好思想工作，使其情绪安定，心情开朗，避免过度疲劳，保证充足的睡眠。

40. 震颤麻痹

震颤麻痹综合征（旧称帕金森氏病）是神经系统的一种疾病，也可由外伤引起。症状有：下颌及口唇肌肉震抖（不自主抖动），影响进食和说话，口角流涎，语言不清，四肢倦怠，两手颤抖，不能拿碗筷，不能写字，步态蹒跚，行走困难。劳累过度即出现手足抽搐颤动，头摇。平时面色萎黄，表情呆板，呈“面具脸”，两上肢弯曲好象篮球运动员投篮时的形状，大小便失禁。

震颤麻痹属于祖国医学之“内风”证、“痲疯”等范畴。“内风”有血虚生风、热极生风、肝阳化风三种。震颤麻痹综合征多属气血不足，复感寒邪，沉寒痲阻致筋脉失养，血虚生风。中医认为，痲疯可分为两大类：一是阴亏液涸，筋脉失于濡养，多见于热病伤阴或失血、失汗、吐泻之后，二是阳气虚弱，筋脉失于温养，见于久病阳虚，或寒湿留滞，或瘀血阻络，致经隧不利，阳气不达。治宜补气益血，温阳散寒，熄风镇潜，活血通络。

方一：鹿角霜20克，肉桂3克（后下），黄芪30克，党参30克，当归12克，干姜10克，白芥子12克，地龙12克，防风12克，附片30克（先熬），全蝎3克。水煎服。

方二：黄芪60克，党参30克，当归30克，熟地20克，川芎15克，赤芍15克，钩藤30克，全蝎10克，蜈蚣3条，生龙骨50克，生牡蛎50克。水煎服。

加减：自汗气短，黄芪可重用至100克；心悸失眠者加酸枣仁20克、炙远志10克；怕冷者加制附片20克（先熬2小时）。

方三：黄芪60—90克，当归12克，红花12克，川芎10克，赤芍10克，地龙15克，全蝎10克，鸡血藤60克，白芍30克，甘草10克。水煎服。

以上两方以重用补气药为主，气为血之帅，气行则血行，验之临床，每多获效。

41. 周期性麻痹（低血钾型）

周期性麻痹是一种与钾代谢障碍有关的呈周期性发作的弛缓性瘫痪。病因尚不明瞭。

临床上分为：①低血钾型周期性麻痹（最多见）；②高血钾型周期性麻痹（甚少见）；③正常血钾型周期性麻痹（甚少见）。

本文着重谈谈低血钾型周期性麻痹的中药治疗。

低血钾型周期性麻痹通常在20岁前起病，常于熟睡中或清晨初醒时突然发生。发作前一天可有饱餐高糖饮食、剧烈运动、外伤、感染等诱因。发作初可有剧渴、出汗、肢体酸痛、感觉异常等症状。瘫痪自下肢开始，延伸至颈部，瘫痪

常在一小时内达到高峰。有时伴有心律紊乱。患者意识清醒，感觉正常。发作历时数小时至数日后而迅速自行恢复。发作时可查到血清钾的降低和心电图的低钾表现。

周期性麻痹属于祖国医学“痿证”范畴。中医认为劳伤脾气，脾失健运，肌肉失养，能影响四肢的运动。治宜健脾益气。

方一：党参30克，黄芪30克，茯苓15克，白术12克，甘草10克，山药30克，当归12克，淮牛膝30克，伸筋草30克。水煎服。

本方适用于出汗、心律紊乱的周期性麻痹。

方二：制附片30克（先熬），桂枝10克，干姜10克，淮牛膝30克，草薢15克，山药30克，苍术12克，白术12克，茯苓12克，党参30克，鹿角片15克，黄芩10克，黄柏10克。水煎服。

本方适用于手足冷、性功能减退的周期性麻痹。

方三：核桃仁30克，麦冬25克，白芷12克，防风12克，甘草10克，党参30克，白术12克，茯苓12克，黄芪30克，夏枯草30克。水煎服。

本方适用于肢体酸痛、感觉异常之周期性麻痹。

方四：香薷10克，厚朴10克，扁豆12克，薄荷10克，六一散一包。水煎服。

本方适用于夏季发生的低血钾型周期性麻痹。

针灸疗法

取穴：大椎、肩井、肩俞、曲池、合谷、环跳、足三里、太冲、伏兔。中等刺激，不留针。

周期性麻痹患者平时应适当多吃些含钾的食物如核桃、牛奶等，并应进行适当的体育锻炼（不能剧烈运动），避免受凉，避免大量地吃高糖食品等等。

附：三种周期性麻痹的鉴别要点

临床情况	低血钾型	高血钾型	正常血钾型
发病年龄	青年为多	10岁以前	10岁以前
发病诱因	剧烈运动高糖 饮食等	剧烈运动，饥饿 等	食盐摄入过少
发作时间	睡醒	白天	睡醒
持续时间	数小时至数天	1小时内	数天至数周
程 度	完全麻痹	轻度局部无力	完全麻痹
血 钾	血钾浓度低	血钾浓度高	血钾正常
肌强直	无	有	无
心电图检查	低钾表现	高钾表现	无特殊

42. 血卟啉病(血紫质病)

血卟啉病又称血紫质病，是一种比较少见的由先天性和后天性卟啉代谢紊乱所引起的代谢病。迄今尚无特效疗法。当出现明显的神经精神症状时预后不良。本病多有遗传。

血卟啉病的临床表现主要有光感性皮肤损害、腹痛及神经精神三大症群。

(一)皮肤症群：在婴儿期，从额、鼻、耳、手等部位开始出现红斑，以后逐渐发展为疱疹，甚至溃烂，结痂后常遗留瘢痕，引起畸形和色素沉着。病人可有特殊的紫色面容。

(二)腹部症群。腹痛发生急骤，异常剧烈，可伴有恶心、呕吐、呕出咖啡样物，腹痛多为绞痛、隐痛、腹部有重压感。腹痛的部位不定，可在腹上部、脐周、左腹或右腹、有时在背部或放射至膀胱区及生殖器。腹痛时限有长有短，(数小时、数日甚至数周)。便秘，腹胀，黄疸。

(三) 神经精神症群：下肢疼痛，感觉异常，自觉腹中气逆上冲，咽梗阻，吞咽困难，胸闷，乳胀，甚至四肢瘫痪，心动过速，高血压，精神失常（谵妄）等等。

血卟啉病可通过血液、尿、粪、骨髓等实验室检查而确诊。

血卟啉病属于祖国医学“蓄血证”、“腹痛”、“奔豚气”等范畴。系瘀热相搏于胃肠，气滞血瘀所致。治宜逐瘀清热止痛。

方一：当归12克，桃仁10克，大黄10克，芒硝10克，桂枝12克，白芍30克，赤芍12克，土鳖虫10克，玄胡索10克，蒲黄10克，五灵脂12克，甘草10克。水煎服。

本方适用于血卟啉病瘀热蓄血型的患者服用。证见腹痛持续，阵发绞痛，以脐周及下腹为剧，按之痛剧，烦躁谵妄，面色暗黄，或巩膜发黄，便秘尿赤，舌质暗，苔黄，脉弦涩。

方二：黄芩15克，法半夏10克，茵陈30克，藿香12克，厚朴12克，白蔻仁12克，桃仁10克，竹茹10克，大黄15克，丹参20克，枳实12克。水煎服。

本方适宜于血卟啉病湿热阻滞型患者使用。证见腹痛腹胀，恶心呕吐，胸闷纳呆，面色萎黄，便干或溏，小便短赤，舌暗红，苔黄腻，脉弦细。

方三：白芍30克，当归12克，川芎12克，桃仁12克，黄芪30克，桂枝12克，甘草10克，党参30克，生姜10克，水煎服。

本方适用于血卟啉病气血两虚型的患者。证见腹部隐痛或闷痛，时作时止，面色苍白，神疲乏力，自汗盗汗，便畅尿黄，舌淡苔白，脉沉细。

血卟啉病患者应避免精神刺激，增加高糖饮食，禁止饮酒。

方四：干姜6克，元胡6克，生姜6克，大枣6克，党参10克，白术10克，甘草10克，白芍10克，桂枝6克，川楝子10克。水煎服。

本方适用于持续低烧，但畏寒、腹痛喜按喜温的“血紫质病”。

方五：太子参15克，沙参12克，生地12克，麦冬12克，石斛12克，白芍12克，谷芽12克，五味子10克，甘草10克，银花藤30克，浮小麦30克。水煎服。

本方适用于气阴不足之急性间歇性血卟啉病。

43. 痛 风

痛风是一组嘌呤代谢紊乱所致的疾病，病程长，临床表现可分三期：

一、无症状期：

不少患者在症状发生前早有高尿酸血症，血尿酸浓度在7毫克/100毫升以上。不少病人无临床症状，只有少数病人发生“痛风”的症状。

二、急性关节炎期：

起病急骤，多数患者在夜半突感关节剧痛，伴以发热等全身症状而惊醒。最先最多发生疼痛的是拇趾及跖趾，其次是踝、手、腕、膝、肘及足部的其他关节。在发病数小时后局部出现红、肿、热、压痛及动作受限。不经治疗，上述炎症反应在3—10天内自行消退。此后经数月或数年又再度或多次发作。初发者容易被误诊，不少病人长期当作关节炎治

疗，直到转入慢性期，出现了关节畸形僵硬或心肾严重合并症时，才引起注意。

三、慢性关节炎期：

当疾病发展，尿酸钠在关节内沉着逐渐增多，发作逐渐频繁，间歇期缩短，关节累及增多，炎症进入慢性阶段而不能完全消失时，关节开始畸形僵硬，关节及肾脏有痛风石沉积，尿路结石，肾功能衰竭，伴发高血压、动脉硬化等。

痛风不是受风寒而致的关节疼痛。痛风与风湿性关节炎是两种不同的疾病。痛风是新陈代谢障碍引起的疾病，有家族遗传性，发病的主要原因是蛋白质中的嘌呤代谢失调，使血液中尿酸的含量增高，当尿酸盐达到一定的浓度时就沉积于关节、软组织、软骨、肾脏等组织内，从而产生多种临床症状。

痛风多发生在30—40岁的中年人或老年人，男性为多，起病急骤，常在夜半突感关节剧痛。体胖的中老年人，遇有突然发生的关节剧痛，应警惕是否患有痛风，应及时到医院检查。如检查血尿酸值增高（大于6毫克%），或抽吸红肿部位找到尿酸盐结晶，即可确诊为“痛风”。

祖国医学无“痛风”病名，根据痛风石沉积等表现，类似中医的“痰核”。中医认为脾虚生湿（痛风患者多数有脾虚纳差等症状），湿久郁成痰浊，故见“痰核”（痛风石沉积）。治宜软坚化痰，健脾补肾。

方一：昆布30克，海藻30克，生龙骨30克，生牡蛎30克，浙贝10克，赤芍10克，太子参30克，茯苓12克，熟地12克，山药30克，仙灵脾30克。水煎服。并服豨莶丸（成药），每日二次，每次10克。

方二：木瓜30克，桑枝30克，知母10克，生石膏30克，

生地30克，桂枝10克，苍术12克，淮牛膝15克，银花藤30克，络石藤30克，海风藤30克，黄柏10克。水煎服。并加服豨莶丸(成药)，每次10克，一日二次。

方三：地龙12克，山甲12克，蜈蚣3条，桂枝12克，生石膏30克，苡仁30克，生地30克，淮牛膝30克，萆薢15克，丹皮12克，银花藤30克。水煎服。

本方用虫类药搜风通络剔邪，可增强疗效。

方四：当归20克，羌活12克，党参30克，苦参15克，升麻6克，葛根30克，苍术10克，黄芩12克，茵陈30克，防风15克，知母12克，泽泻20克，猪苓12克，甘草6克。水煎服。

由于痛风是嘌呤代谢失调的疾病。血液中嘌呤代谢产物尿酸有一部份来自膳食，故限制膳食中的富含嘌呤食品，对控制痛风的病情发展，有现实意义。动物的肝、心、肾、脑等。含嘌呤量极高，痛风病人应禁食这些食物。猪肉、牛羊肉及各种禽类、鱼类、嘌呤含量也较高，痛风病人也应限制吃这类食物。奶类和蛋类食品不含嘌呤，病人可放心食用。

带皮谷物(全麦、糙米)、豌豆、小扁豆、花菜、菠菜等均含少量嘌呤，痛风病人不可多吃这些食物。含嘌呤很低的食物有白米、白面、芹菜、卷心菜、胡萝卜、茄子、蕃茄、黄瓜、萝卜等。痛风病人可大胆进食这些食品。

痛风病人还应多饮茶或咖啡。促进尿酸从尿中排出。吃适量的绿叶蔬菜和水果，提供足量的维生素和铁质。

痛风病人还应禁酒，不要狂饮暴食。

44. 男性乳房增大症

男性乳房增大症是内分泌紊乱的一种症状。乳房逐渐增

大如少女之发育状，伴有性功能减退如阳痿等症状。

男性乳房增大症发病的主要原因为雌激素分泌过多伴乳腺组织对雌激素敏感性增强所致。这种病可见于各种年龄。乳房呈双侧对称性或不对称性增大。或单侧性增大。大小不一，有时乳房有结节。一般患者无自觉症状，但也可有局部胀痛、压痛或触痛，乳晕色素加深甚至溢乳。有的伴肝脾肿大及男性假两性畸形等，有的可引起精神或情绪方面的变化。

睾丸疾病、睾丸肿瘤、垂体疾病、肾上腺皮质疾病、甲状腺病、肝脏病、性发育异常、营养不良、神经疾病等均可引起男性乳房增大症。有些肝炎病人出现男性乳房发育，肝炎愈后乳房发育即消退。这是因为肝功能不全时，血中雌激素水平增高，兼之雄激素不足，故少数肝炎病人出现男性乳房发育症。

方一：锁阳10克，巴戟天10克，枸杞子15克，仙茅12克，淫羊藿30克，合欢皮30克，橘核30克，荔枝核15克，炙龟板30克，鹿角胶10克，菟丝子12克。水煎服。

方二：杞菊地黄丸(成药)，照说明书上的常规剂量加倍服用。

方三：五味子15克，复盆子12克，菟丝子12克，韭菜子12克，胡芦巴子12克，枸杞子15克，金樱子15克，补骨脂12克。水煎服。

方四：雄狮丸(成药)，照说明书剂量服。

食物疗法：男性乳房增大症患者平时应常吃羊肉、狗肉、麻雀肉等，这些食物均有利于症状之消除。

45. 男性更年期综合征

不论男女，从壮年过渡到老年，都有一个“更年期”。男性的更年期是在55—65岁之间，比女性要晚一些。男性更年期综合征是指在更年期出现的内分泌、代谢功能失调的一组症候群。其症状不象女性更年期综合征那样明显，主要是由于男性睾丸不象女性卵巢那样易于萎缩。

有的学者对男性更年期综合征的概念有不同看法，甚至怀疑男性更年期综合征的存在。笔者临床实践经验证明这种综合征是客观存在的。主要临床表现有：疲乏，心悸，失眠，心烦易怒，易激动，头痛，记忆力减退，精神紧张而不易集中，皮肤有蚁行感，腰膝酸痛，性欲衰退等。

男性更年期综合征属于祖国医学“肾虚”、“虚劳”等范畴。特别是肾虚，是男性更年期综合征的主要病因。肾为先天之本，内寄元阴元阳，乃人体阴阳之根蒂。男子进入更年期，由于肾精匮乏，肾气日衰，天癸渐竭，以致元气不充，阴阳偏颇，抗病力减弱。唐·孙思邈说：“人五十以上，阳气日衰，损与日至……”说明更年期易于出现阴阳失调、脏腑虚损的病理变化。此外，脾胃失健，生化乏源，也是引起男性更年期综合征的原因之一。脾胃乃后天之本，主受纳运化，升清降浊，为气血生化之源。“五脏六腑皆禀气于胃”，“脾虚则四肢不用，五脏不安”，“元气，乃先生身之精气也，非胃气不能滋之”，“欲实元气，当调脾胃”。人到更年期，脾胃功能渐衰，气血化生日减，化生乏源，肾气不充，从而导致更年期综合征种种症状的出现。治宜滋养肝肾，补肾健脾，宁心安神。

方一：仙茅12克，淫羊藿30克，菌灵芝30克，补骨脂12克，山药30克，茯苓12克，五味子15克，枸杞12克，杜仲12克。水煎服。

本方适用于男性更年期综合征脾肾阳虚型患者，证见神疲无力，情绪低沉，形寒怯冷，腰膝或少腹冷痛，性欲减退，阳萎早泄，纳呆食少，大便稀溏，小便清长等。

方二：菊花12克，枸杞15克，熟地20克，山药30克，山萸肉10克，桑椹15克，茯苓12克，当归15克，生龙骨30克，生牡蛎30克。水煎服。

本方适用于男性更年期综合征肝肾阴虚型患者。证见烦躁易怒，忧郁紧张，头晕目眩，耳鸣，健忘多梦，五心烦热，潮热盗汗，腰膝酸软。

方三：酸枣仁12克，茯苓30克，首乌30克，夜交藤30克，天冬12克，麦冬15克，珍珠母30克，炙远志10克，菖蒲10克，柏子仁12克，五味子12克。水煎服。

本方适用于男性更年期综合征心肾不交型患者服用。证见心烦不寐，多梦易惊，怔忡不安，健忘，口咽干燥，头晕耳鸣，潮热汗出。

方四：黄连6克，枳实10，竹茹12克，陈皮10克，茯苓15克，瓜蒌15克，柴胡12克，郁金12克，酸枣仁15克，白芍30克，甘草10克。水煎服。

本方适用于男性更年期综合征肝郁胆热型患者。证见情志不舒，忧郁烦闷，神思敏感，易生幻疑，寐多恶梦，胆怯心悸，头晕目眩，口苦咽干。

男性更年期综合征是一种暂时现象，预后良好。患者应解除思想顾虑，坚持治疗，自能逐渐恢复正常。

46. 变态反应性亚败血症

变态反应性亚败血症,又名过敏性周期热。其发病原因未明。由于临床表现类似败血症,但血培养始终未证实有细菌,故有“亚败血症”之称。“变态反应”则因关节疼痛、皮疹起伏无常等特殊反应而得名。本病以长期发热(间歇型发热),反复出现一过性皮疹、关节痛、肝脾肿大、白细胞增多、血沉增快、血培养阴性、抗菌素治疗无效、激素治疗能使症状缓解等为特点的临床综合症。表现为:体温波动在38--41℃之间。持续数小时后可自行退热,而数小时后体温又复升高,每天发作2--3次。高热时全身可出现团块状荨麻疹,伴关节疼痛。热退时荨麻疹亦消失,关节疼痛亦减轻。除寒热往来外,尚可有口苦、谵语、躁扰不安、肌衄、鼻衄、黑便等症状。

本病属于中医的温病范畴。温病易伤阴液,常呈阴虚内热之象。本病以营血症候为主。常不出现卫分、气分的临床症状。总的说来,火毒内盛充斥三焦,累及营血。治宜清热解毒,凉血散瘀,增液养阴。

对长期依赖于肾上腺皮质激素治疗的变态反应性亚败血症患者,亦可用以补肾为主的方药加以治疗,以逐步撤除激素。

方一:银花30克,黄连30克,黄芩15克,黄柏15克,栀子12克,连翘12克,蒲公英30克,丹参30克,丹皮15克,玄参30克,麦冬15克,生地30克,生牡蛎60克(先煎),生军10克(后下),玳瑁3克(研细末冲服)。

方二:柴胡10克,生地30克,广角粉6克(冲),玄参30

克，知母12克，赤芍15克，麦冬15克，丹皮12克，紫草15克，龙胆草10克，银花12克，连翘15克，槟榔12克，青蒿12克，水煎服，每日一剂。

加减：热毒症状重而便秘者加生军10克、羚羊角粉0.3克(冲服)；倦怠、苔腻、便溏有挟湿表现者，加藿香10克，厚朴10克，苡仁30克、苍术10克；病久体虚者去广角粉、紫草、龙胆草，加黄芪30克，当归15克。

方三：生地60—90克，山药30克，淫羊藿30克，仙茅12克，菟丝子15克，补骨脂12克，肉苁蓉12克，党参30克，徐长卿15克，秦艽12克，土茯苓30克，苍耳草15克，甘草6克。水煎服。

本方适用于长期依赖激素治疗，要求逐步撤除激素的患者。方中徐长卿、秦艽、土茯苓、苍耳草对皮疹、关节痛、皮肤瘙痒等症状有效。

方四：蜈蚣30克，全蝎30克，白花蛇20克，乌梢蛇20克，共研细末，每次服6克，用汤药冲服，日服二次(汤药处方：羚羊角5克，地龙10克，知母10克，生石膏30克，秦艽15克，桂枝8克，制川乌10克〔先煎〕，炮山甲10克，苡米30克，赤芍12克，桑枝30克，甘草6克，鸡血藤30克)。

有的变态反应性亚败血症患者的症状表现以寒湿痹证为主，寒湿内闭，侵袭肌骨、阻滞经络，格阳于外，逼阴于内，久之化热伤阴。遇此等情况，当先以祛风散寒为主，滋阴凉血为辅。先用乌头15克(先煎)，麻黄10克，白芍15克，黄芪30克，甘草10克，紫草15克，丹皮12克，知母12克，萆薢15克，以凉血清热，滑利关节。高热一退，当救其阴，当用元参30克，生地30克，知母12克，沙参30克，丹皮12克，鳖甲15克，银花15克，连翘15克，蒲公英30克，秦艽15克。水煎服。

47. 自发性气胸

气胸是指肺泡和脏层胸膜自发性破裂，空气经裂口（隙孔）进入胸膜腔，产生胸膜腔内积气和肺脏萎缩。

气胸按病因可分为自发性气胸和创伤性气胸两大类。按肺部裂口的情况及胸膜内压不同，又可分为开放性气胸、闭合性气胸、高压性气胸三型。

现谈谈自发性(闭合性)气胸的中药治疗。

自发性气胸可分为特发性气胸和继发性气胸。

特发性气胸系指肺部X线检查无明显病变的健康者发生的气胸，这种气胸并发症甚少，但可能复发。

继发性气胸，多由慢性支气管炎、肺气肿、支气管哮喘、支气管扩张、尘肺、肺癌、肺结核、肺脓肿等引起。

少量气胸可无明显症状，大量气胸发病急骤。气胸的症状有咳嗽、呼吸窘迫、出汗，重者引起呼吸循环衰竭。气胸一般无全身性毒性症状。胸膜有继发性感染时，则可有发热、白细胞增多。气胸可经X线检查等确诊。

气胸属于祖国医学“肺胀”、“胸痹”等范畴。《灵枢·胀论》云：“肺胀者，虚满而喘咳”。由于卫气逆乱，壅滞不行，肺失清肃，肺气壅滞，故胸满，肺气上逆则喘咳。中医还认为，肺居胸中，胸为清阳所聚和清肃之区。胸痹者，其因为虚，其果为实。“胸中阳微不运，久则阴乘阳位而为痹结也”。说明“胸痹”乃正气不足，肺气素虚，阴邪痰浊停留于胸中，胸阳痹阻，阳气不得疏通所致。治宜通阳泄浊，下气通络，扶正宣痹。

方一：黄芪60克，白芨30克，党参30克，麦冬20克，五

味子15克，杏仁12克，草决明30克。水煎服（症状减轻后，用百合固金汤巩固疗效）。

方中黄芪、白芨、草决明等有生肌之功，可促使胸膜裂口愈合，减少气胸复发。

方二：山药30克，黄芪30克，党参30克，瓜蒌15克，薤白15克，桂枝10克，五味子15克，苏子10克，莱菔子10克，大枣15克，甘草10克。水煎服。

方中黄芪、党参益气补肺扶正，山药补肺健脾益肾（肺气根于肾，脾为肺之母），五味子益肾敛肺，甘草、大枣益气健脾，桂枝、薤白通阳宣痹，瓜蒌散结，苏子、莱菔子涤痰降浊，全方扶正祛邪，可促使积气吸收、减少复发。

方三：枳实12克，桂枝12克，薤白20克，桑白皮15克，葶苈子15克，杏仁12克，桃仁10克，红花10克。水煎服。

加减：便秘者加大黄；痰黄者加瓜蒌、桔梗；痰清稀者加白芥子。

48. 单纯性甲状腺肿

单纯性甲状腺肿，又称地方性甲状腺肿。其主要发病诱因系缺碘所致。高原、山区土壤中的碘盐被冲洗流失，以致饮水和食物中含碘量少。因此，高原、山区居民患此病的较多，故又称“地方性甲状腺肿”。

青春发育期、妊娠期或经绝期妇女，有时也可发生轻度的弥漫性甲状腺肿大，这是由于人体对甲状腺素的需要量暂时性的增大所致。

患者一般无全身症状，基础代谢率正常。甲状腺可有不同程度的肿大，能随吞咽上下移动，两侧呈对称性的弥漫性

肿大，腺体表面平滑，质地柔软。肿大的甲状腺可压迫邻近器官而出现压迫感，呼吸迫促，咳嗽，吞咽困难，头晕。

单纯性甲状腺肿属于祖国医学“瘰”、“瘰瘤”、“气瘰”等范畴。又名“大脖子”。患者发病与水土有关，或忧思郁虑，肝郁不舒，脾失健运，致气滞痰凝而成瘰瘤。治宜祛痰软坚。

方药：昆布150克，海藻150克，海螵蛸150克，夏枯草150克，共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克，每次服一丸，每日服二次，连续口服三个月为一疗程。

49. 链霉素毒副反应

链霉素的毒副反应的主要症状有：耳鸣，头晕，耳胀堵塞感，视物浮动，失眠，多梦，摇晃，步履不稳，听力下降等。但神经系统检查无阳性体征。

链霉素毒副反应的主要症状类似于祖国医学“眩晕”范畴，多数与病人平素体质虚弱有关。中医认为“无虚不作眩”，“诸风掉眩，皆属于肝”。主要由于阴血不足，不能滋养肝木，肝阳上扰致肝风内动。治宜平肝安神，养血熄风。

方一：石决明20克，钩藤15克，寄生10克，白芍10克，首乌10克，防风10克，荆芥10克，当归10克，川芎6克，蝉蜕6克，茯苓10克。水煎服，每日一剂。直至毒副作用完全消失。

加减：大便秘结者加大黄；呕吐加竹茹。

本方用石决明、钩藤、白芍、茯苓以平肝安神，当归、首乌、寄生以养血，川芎、防风、荆芥、蝉蜕以熄风。服本方除少数病人有口干、大便干结外，没有其他不良反应，多

数病人乐于接受，保证了链霉素的连续用药，抗结核治疗不间断。

方二：骨碎补12克。水煎服，每日一剂，直至链霉素毒副作用完全消失。

方三：银花30克，连翘15克，大力子15克，生地30克，菊花15克，白蒺藜15克，桔梗10克，甘草10克。水煎服。

方四：石决明30克，草决明30克，青箱子12克，石斛15克，知母12克，黄柏10克，当归15克，淮牛膝18克，泽泻15克，路路通12克，石菖蒲24克，枸杞24克，熟地24克。水煎服。

针灸疗法

取穴：完骨，针向同侧眼球，平补平泻，不留针。每日针刺一次，以饭后针刺为宜。

上述方药和针刺疗法不仅对链霉素毒副反应有治疗效果，而且对卡那霉素、新霉素的毒副反应也有一定治疗效果。

50. 慢性苯中毒

慢性苯中毒是一种职业病，多发生于从事苯作业的工人，如皮鞋制造业的配胶工、刷胶工及钳帮工，制漆业的操作工、分析工、喷漆工等。

慢性苯中毒的症状有：头昏头痛，乏力，失眠，记忆力减退，易感冒，手掌和腋下出汗增多，心动过速或心动过缓，贫血，牙龈出血，鼻出血，妇女月经量多，血常规检查时可见白细胞减少。

皮肤长期接触苯，可出现干燥、瘙痒、发红、水疱疹，有时出现脂溢性皮炎或湿疹。

根据苯接触史和中毒的表现，诊断慢性苯中毒一般不难。

慢性苯中毒属于中医的虚证范畴。治宜健脾补肾化瘀。

方一：丹参15克，当归15克，黄芪30克，太子参15克，熟地10克，枸杞15克，淫羊藿12克。水煎服。

本方有补气补血，提高白细胞数的作用，长期服用，无副作用。

方二：土茯苓30克，甘草3克，虎杖30克，党参30克，当归15克，决明子30克。水煎服。

方三：银花15克，甘草3克，金钱草30克，黄芪30克，黄精15克。水煎服。

方四：防风15克，泽兰10克，苍术15克，黄芪30克，绿豆30克，甘草10克，水煎服。

方五：银花15克，细辛10克，白芨30克，虎杖30克，生石膏30克，紫珠草30克，食盐10克，共研成极细末，刷牙，可治慢性苯中毒的牙龈出血。

51. 矽 肺

矽肺是一种常见的职业病，多发生于采矿、采煤、采石、爆破及井下作业的工人，轧石，磨粉，制造玻璃、搪瓷和耐火材料的拌料工人和铸造业工人等。矽肺是由于长期吸入含有游离二氧化硅粉尘引起的全身性疾病，主要表现在肺内广泛结节性纤维化，严重者影响肺功能。

矽肺的主要症状有：咳嗽、咳痰（少数患者可有血痰）、胸痛（常在阴雨、天气多变时发生）、胸闷、气急、乏力，还伴有头昏，失眠，心悸，纳差等症状。

矽肺可通过X线检查确诊。

矽肺属外邪侵肺，血络瘀阻，聚成结节，日久则肺肾之阴耗损。治宜健脾益气，宣肺化痰。

方一：党参60克，牡蛎60克，乌梅15克，瓜蒌30克，马齿苋15克，禹余粮15克，薤白15克，茯苓12克，杏仁12克，桔梗15克，前胡12克，枳壳6克，生姜6克。水煎服。

加减：咽干、痰粘者加玉竹、知母、天冬、麦冬；痰白不粘者加桂枝、陈皮、半夏；痰黄口渴者加黄芩、生石膏；痰黄口不渴者加竹茹、海石；怕风畏冷者加荆芥、防风；发热咳嗽口渴者加桑叶、菊花；纳差者加山楂、炒麦芽、炒谷芽；失眠者加远志、酸枣仁。

方二：金钱草30克，木贼30克，桔梗15克，姜半夏12克，丹参30克，桃仁12克，虎杖30克，生牡蛎30克。水煎服。

加减：伴感染者加蒲公英、鱼腥草、百部、夏枯草、黄芩；伴腰膝酸软者加淫羊藿、补骨脂、黄精、山药、枸杞、菟丝子。

52. 放射性直肠炎

放射性直肠炎是放射治疗子宫颈癌常见的并发症。病人较为痛苦。凡子宫颈癌放射治疗后2—3个月，再出现大便次数增多，粘液便，脓血便，肛门灼痛，排便前腹痛，经直肠镜检查发现肠壁粘膜充血、水肿、糜烂、溃疡、纤维化，而排除肠道传染病和直肠癌者，即可诊断为放射性直肠炎。

本病系子宫颈癌放射治疗所引起。因直肠位于子宫颈附近，直肠组织对放射线敏感，故直肠粘膜容易受射线的影响而发生糜烂溃疡等病变。

祖国医学无“放射性直肠炎”的病名，根据本病具有下痢赤白、里急后重、腹痛、肛门灼痛等表现，属湿热毒邪郁积于肠，气血受阻，传导失职。若长期耽误治疗，湿阻于中，湿邪困脾，脾虚失运，不能统血，久之气血生化不足，精气耗损，脏腑功能失调，加上湿邪未尽，可出现形体消瘦、面色萎黄、咽干舌燥等症状。

辨证分型治疗：

1. 湿热型：大便粘液多，肛门灼痛，里急后重，尿短赤，舌红，苔腻，脉数。治宜清热解毒，利湿化瘀。

方药：黄芩12克，黄连10克，黄柏12克，白头翁15克，秦皮10克，石莲子12克，升麻10克，马齿苋30克，白芍15克，陈皮10克，厚朴10克，白花蛇舌草30克。水煎服。

2. 脾虚湿困型：血便粘液多，肛门坠痛，纳呆，乏力，面色萎黄，舌胖苔白，脉细缓。治宜祛湿健脾，兼清余热。

方药：山药30克，党参30克，扁豆12克，枳壳10克，升麻10克，葛根30克，血余炭10克，陈皮10克，茯苓10克，罂粟壳10克，白术12克，苡仁30克，白蔻10克。水煎服。

3. 脾肾两虚型：肛门严重坠痛，排便不畅，血便多，食少乏力，消瘦贫血，烦热，咽干，舌红无苔，脉沉细无力。治宜培补脾肾，养血祛邪。

方药：党参30克，黄芪30克，生地炭12克，升麻10克，葛根30克，乌梅12克，罂粟壳10克，当归炭10克，阿胶12克（烔化），白术12克，甘草10克。水煎服。

53. 放环后月经失调

放置节育环后月经失调是妇女的常见病。表现为放环后月经量多，经期延长，周期不规则等，有的还伴有头眩耳鸣，腰膝酸软，畏寒肢冷，或烦热盗汗，或腹部坠痛，面浮肢肿，或大便秘结，或大便溏薄等症状。

放环后月经失调类似于祖国医学“崩漏”。但放环后出血系由“金创所伤”，初时血络损伤，出血既久，气血俱损，气不摄血，乃致淋漓难尽。治宜益气止血。

方一：黄芪30克，党参30克，白术10克，茜草12克，乌贼骨12克，地榆10克，阿胶10克，山萸肉12克，艾叶10克，白芍12克，复盆子10克。水煎服。

出血止后，气血未复，冲任未调，尚须补气血，调冲任，以还其旧。调冲还旧在于养脾胃，补肝肾。否则，血虽止，周期仍不能正常，或下次行经又淋漓不尽。

放环后月经失调不同于气虚崩漏，用补中益气汤往往效果欠佳。但在补中益气汤中将升麻一味药减去不用，则治疗有效。这是什么道理？1985年第11期《上海中医药杂志》报道：因升麻能促进子宫收缩，可用于子宫收缩不良的出血。又，马齿苋也有麦角样收缩子宫止血的作用。对放环后的子宫出血，就不宜使用有收缩子宫作用的提升药（如升麻等，因其能增强节育环对子宫内膜的刺激）。

放环后月经不调，尚宜塞流、澄源并进，治宜祛瘀止血，补肾调冲任。

方二：生地15克，补骨脂12克，金樱子30克，生蒲黄10克，五灵脂10克，白头翁30克，生地榆30克，熟军炭10克，

制香附12克,大枣10克。水煎服。

注:出血量多者,地榆应重用至60克,熟军炭重用至15克。本方用于因输卵管结扎后引起的崩漏、月经失调,亦有较好疗效。

54. 蜕膜样痛经

蜕膜样痛经又称膜样痛经,是痛经中比较严重的一种疾患,多见于青年女子。现代医学认为患者不同程度地存在卵巢及子宫发育不良,因子宫内膜碎片释放过多的前列腺素引起子宫平滑肌强烈收缩,大片内膜不易从宫体排出,因而导致行经时腹痛。患者的子宫内膜整块排出(即在月经内混有肉样内膜),少腹疼痛剧烈,疼痛可向腰臀部放射,疼痛难耐(行经的第二天),出冷汗,面色苍白,肢冷,恶心呕吐、晕厥等。当子宫内膜脱落(月经中排出肉样物)后,腹痛即缓解。

膜样痛经属于祖国医学“痛经”范畴。系元气不足,命门火衰,肝郁气滞,寒凝血脉所致。瘀血内滞,不通则痛。治宜活血祛瘀,理气止痛。

方一:三棱6克,莪术6克,肉桂3克,五灵脂10克,共研细末,分三次用开水吞服。此为一日剂量。

方二:川芎10克,当归15克,熟地15克,赤芍10克,生蒲黄10克;五灵脂10克,丹参30,香附12克,元胡10克,益母草30克。水煎服。

方三:桃仁10克,红花10克,当归15克,赤芍12克,川芎10克,泽兰12克,熟地15克,三棱10克,莪术10克,淮牛膝30克,水煎服。

以上三方均须在行经前4天开始服用，每日一剂，有助于消散子宫内膜，以利排出。这三个方剂均有活血化瘀，理气止痛的作用，可使气顺血调，与西医采用的使子宫内膜变薄、减少大块蜕膜排出的激素疗法，不谋而合，且无副作用。

55. 输卵管阻塞

输卵管阻塞是妇科的一种疾病。主要表现为下腹疼痛，腰酸，乳房胀痛，白带增多，心烦易怒，形寒身楚，性欲淡漠，个别患者兼有性交疼痛，大便秘结，盗汗低热，口苦咽干，神疲乏力，下腹坠胀，月经不调，面目浮肿，乳头痒，嗜睡等症状。妇科检查可见附件增厚，附件包块，后穹窿可触及结节。

引起输卵管阻塞的原因较多，输卵管炎、慢性盆腔炎、输卵管结核、盆腔手术后附件粘连、子宫内膜异位等均可引起输卵管阻塞。

输卵管阻塞可造成不孕。

输卵管阻塞属于祖国医学“无子”、“带下”、“断绪”、“症瘕”、“月经不调”等范畴。系气滞血瘀所致。治宜活血化瘀，清热解毒，软坚散结。

方一：当归15克，路路通10克，莪术10克，穿山甲15克，延胡索12克，夏枯草15克，丹参30克，乳香6克，没药6克，血竭6克，生牡蛎30克，红藤30克，蒲公英30克。水煎服。

加减：经行腹痛剧烈者加香附、白芷、小茴香；怕冷者加肉桂、附子；腰酸者加杜仲、狗脊；如因盆腔炎而引起输

卵管不通者应加用清热解毒药如败酱草、银花、连翘、白花蛇舌草等；如因子宫内膜异位症、附件粘连引起输卵管阻塞者应加用软坚散结药如昆布、海藻、浙贝、皂角刺等。

穿山甲配合路路通为疏通输卵管之要药。穿山甲有消痈、搜风通络、通经下乳之功，路路通有祛风通络、利水除湿之效，两药配伍有祛风通络、除积聚、祛瘀血、疏通输卵管阻塞之效。

用上述方药治疗输卵管阻塞的头三个月内，病人可能有腹痛反而加重现象，这是药物作用之故，待瘀阻消除、粘连松解之后，腹痛会大减，此时攻药宜减少，宜加用扶正补益药调理。

方二：山药30克，生地20克，熟地20克，山茱萸12克，茯苓10克，丹皮12克，泽泻12克，黄柏10克，知母10克，紫草30克，地骨皮30克，桃仁12克，红花12克。水煎服。

加减：腹痛甚者加乳香、没药、丹参、山甲；心慌者加党参、麦冬、五味子；纳差加山楂、陈皮。

56. 多囊卵巢综合征

多囊卵巢综合征是妇科疾病，临床主要表现为月经失调、闭经、不育、多毛、肥胖、双侧卵巢呈多囊性增大。或伴有皮肤粗糙，面部痤疮等。现代医学认为本病的发病机理是下丘脑-垂体功能紊乱，神经-体液调节功能失常。如精神过度紧张，或药物过度刺激，或长期受疾病影响，使下丘脑对垂体的调节功能发生障碍，卵巢卵泡膜细胞增生及黄体化和包膜增厚，妨碍卵泡的发育、成熟和排出，从而产生闭经、不孕、多毛、肥胖、双侧卵巢增大等。多囊卵巢综合征可经

妇科检查、气腹造影等进行确诊。

多囊卵巢综合征属于祖国医学的“闭经”、“不孕”、“崩漏”、“症瘕”等范畴。中医认为，情志不遂，损伤心脾，脾不运化则胃不受纳，生化不足，阴精匮乏，久则经闭，甚则虚劳肌瘦、潮热、盗汗；中医还认为，督脉主一身之阳，阳虚宫寒，则女子不孕。脾阳不振，气不摄血，或中气下陷，或阴虚内热均可致崩中漏下。综上所述，阴虚和阳虚均可造成经闭、不孕、症瘕、崩漏等症，但以阴虚内热为主，特别是脾胃阴虚与多囊卵巢综合征的关系最为密切。

脾胃为后天之本。心主血，全靠脾输布精微；肺主气，全赖脾输布津液；肝藏血，肾藏精，精血的来源亦莫不依赖脾的生化和传输。阳明主润宗筋，如脾阴虚胃燥热，则生化不足，宗筋不润，而致足三阴、冲、任、督诸经生疾，多囊卵巢综合征的症候群，多数与脾虚有关，脾虚湿盛，积聚为痰，痰瘀交阻，可成囊块；脾虚血少，津枯胃燥，热瘀交阻，亦可成块。

本病并与肝经病变有关。女子以肝为先天，以血为用。肝血不足则影响冲任血海之调节充盈，表现为月经不调，闭经等。肝血不足，肝阳偏亢，郁结化热化火，即所谓气有余便是火，表现为面部痤疮等阳实之证。肝气横逆克土则脾胃受制，运化失司，痰湿脂膜积聚，表现体胖壮盛。

辨证分型治疗：

1. 阴虚内热、热瘀交阻型：证见月经不调，量少色褐，牙龈出血，消瘦，口干欲饮冷，基础体温单相，气腹造影等可以证实为多囊卵巢综合征。

方药：玄参30克，麦冬20克，花粉10克，石斛12克，三棱10克，莪术10克，皂角刺12克，穿山甲片12克，白芍30克，甘草10

克。水煎服。

加减：便秘者加大黄、玄明粉；兼心火旺者加黄芩、黄连、远志；兼肝火旺者加丹皮、山梔、郁金、川楝子；目糊目涩加明目夜光丸。

2. 湿聚为痰、痰滞经络型：证见经闭，形体肥胖，口干，便秘，基础体温单相，气腹造影等可以证实为多囊卵巢综合征。

方药：桂枝12克，茯苓15克，桃仁10克，陈皮10克，法夏10克，浙贝12克，胆南星10克，皂角刺12克，穿山甲12克，三棱10克，莪术10克。水煎服。

加减：寒湿阻滞者加制附片、小茴香。

3. 肾虚“痰”实型：证见腰酸，头昏，乏力，怕冷，便溏，基础体温偏低（基础体温是指早晨醒来但尚未起床时测量的体温）。

方药：熟地20克，菟丝子12克，复盆子12克，仙灵脾30克，仙茅10克，夏枯草30克，穿山甲15克，皂角10克，昆布30克，浙贝10克，山药30克，水煎服。

加减：便溏者加胡芦巴；怕冷者加附子、肉桂。

用本方的优点是没有副作用，能提高雌激素水平。

4. 肝阳偏亢型：证见经闭，面部痤疮，毛发浓密，脉弦，舌红苔黄。

方药：龙胆草10克，川芎10克，山梔10克，泽泻10克，车前子10克，柴胡10克，当归10克，生地30克，甘草6克，木通6克。水煎服，隔日一剂，连服1—3个月。

57. 盆腔瘀血症

盆腔瘀血症是妇科的一种常见病。主要症状有：下腹及

腰骶部疼痛，乳房胀痛，性感不快和白带过多等。发生盆腔瘀血症的原因有：由于女性盆腔器官的解剖特异性，容易造成静脉血流缓慢，形成盆腔静脉瘀滞。或由于体质虚弱，血管壁弹性纤维减少，盆腔静脉管壁容易扩张而形成瘀血。或久立、重体力劳动、腹泻、便秘、剧烈咳嗽等，都可使腹压增大，造成盆腔瘀血的机会就多。早婚，早孕，多产也容易引起盆腔瘀血。其他如慢性宫颈炎、慢性盆腔炎、子宫肌瘤、卵巢囊肿等疾病均可引起盆腔充血，久而久之可促使盆腔瘀血症的发生。

盆腔瘀血症的具体症状如下：

一、下腹及腰骶部疼痛（主要症状）。痛的规律是上午较轻，下午较重，休息时减轻，劳动则加重，侧俯卧位或膝胸卧位时减轻，久立或久蹲时加重。

二、乳房胀痛。在月经中期以后开始疼痛，经前一两天或月经来潮时疼痛加剧。与此同时，乳房可出现硬结，并有压痛。待月经过后，疼痛逐渐减轻，硬结亦随之消失。下次月经中期以后，乳痛、硬结又复出现。

三、白带增多。白带呈白色透明样粘液，有时呈水样。合并感染时呈脓样或脓血样。

四、月经异常。月经量增多，经期延长或淋漓不尽，痛经。

五、性交疼痛，有时痛得难以忍受。而且性交过后疼痛加剧，使患者对性生活有恐惧心理，时间久了，即可产生性冷淡，或对性生活发生厌恶感。

六、大小便症状：排大便有疼痛感或里急后重的感觉。并有尿频、尿急、尿痛或血尿。

七、精神神经症状：头痛，头昏，胸闷，心慌，耳鸣，腹胀，失眠，多梦，精神忧郁，情绪低落，疲劳，手指发

麻，全身有蚁行感。

盆腔瘀血症通过妇科检查、体位试验、盆腔镜检查等可以确诊。

附：体位试验的方法：取胸膝卧位（俯卧，两膝屈向胸部，臀部抬高，大腿与床成垂直，胸部与床贴紧），可使下腹部及腰骶部的疼痛减轻或消失。然后再将臀部向后，紧紧坐在足后跟上，头部和胸部保持略高于下腹的位置。采取这种姿势时间稍久，病人的下腹部及腰骶部又会出现疼痛。如果病人再作膝胸卧位，疼痛又可减轻或消失。这种现象叫做体位试验阳性。

盆腔瘀血症属于祖国医学“气滞血瘀”范畴。治宜活血化瘀。

方一：生蒲黄12克，五灵脂12克，白芍30克，甘草10克，三棱10克，莪术10克，当归15克。水煎服。

方二：川芎10克，香附12克，丹参15克，玄胡12克，川楝子12克，丹皮12克，赤芍12克，桃仁10克，王不留行10克，当归12克，甘草6克。水煎服。

58. 女性生殖道结核

女性生殖道结核是由结核杆菌侵入生殖道引起的慢性炎症性疾病，包括盆腔结核、宫颈结核、子宫内膜结核、输卵管结核等。全身症状有午后潮热、盗汗、闭经、消瘦等，妇科肛门检查可发现附件增厚或附件包块，可通过宫腔X线碘油造影或病理切片检查等确诊。

女性生殖道结核属于祖国医学“干血癆”范畴，中医认为，室女闭经久则成癆不治。本病的致病因素，有内因外

因,外因系瘵虫传染,内因系气血虚弱,二者互相影响。正气不足之人,最易感染成疾。明·徐春圃说:“凡人平素保养元气,爱惜精血,瘵不可得而传。惟夫纵欲多淫,……精血内耗,邪气外乘”。

本病临床以阴虚者为多见,元代朱震亨倡导“瘵瘵主于阴虚”的学说,突出了病机证候重点,确定了滋阴降火的治疗法则。中药治疗本病,可增强人体抗病能力,改善症状,若能与西药(抗瘵药物)并用,可望缩短疗程,减少副反应,提高疗效。

方一:黄精30克,百部12克,天冬15克,麦冬30克,白芨30克,骨碎补10克,补骨脂10克,生地30克,地骨皮12克,枸杞30克。水煎服。

方二:白芨30克,杏仁12克,黑芝麻15克,青羊参(小白芨)12克。水煎服。

方中的白芨入肺,治结核、疮疖,对结核性瘵管有效;杏仁入肺,平喘润肠益精;黑芝麻补肝肾,入肝益血,润五脏,治病久虚羸;青羊参(小白芨)补肾镇痉,治腰痛,治蛊毒,调气分之郁。这四味药有调养气血,益肾,治结核之效,平补而不燥,久服增益病体,价廉易得。

加减:阴虚内热者加当归、熟地、生地、沙参、麦冬;潮热者加地骨皮、银柴胡;气血两虚者加黄芪、党参、当归、熟地;肾虚者加杞菊地黄丸、右归丸。

59. 子宫肌瘤

子宫肌瘤是妇科的良性肿瘤。其症状有:阴道不规则出血,量多色红或紫暗,有瘀块,月经淋漓不断,白带增多,小腹

刺痛，痛有定处，小腹可触及包块，且逐渐增大，按之坚硬，不滑移。伴口干舌燥(血结则燥)，大便秘结，口唇溃疡，烦躁不安等症状，舌质暗红，舌边有瘀点。子宫肌瘤可通过妇科检查，B型超声波检查等确诊。

子宫肌瘤属于祖国医学“症瘕”、“石瘕”范畴。《灵枢·水胀篇》谓：“石瘕生于胞中，寒气客于子门，子门闭塞，气不得通，恶血当泻不泻，瘀以留止，日益以大，状如怀子，月事不以时下，皆生于女子，可导而下。”《妇人良方》谓：“妇人腹中瘀血者，由月经闭结，或产后余血未尽，或风寒滞瘀，久而不消，则为积聚症瘕矣”。中医认为，六淫之邪，七情内伤，引起脏腑功能失调，气血不和，以致气滞血瘀，新血与旧血凝聚成块，结于胞宫，日益长大而成子宫肌瘤。治宜行气破血，软坚消积为主，佐以扶脾补肾调肝。

方一：生地30克，熟地20克，白芍15克，贯众10克，海藻30克，夏枯草30克，淮山药30克，淫羊藿30克，鹿含草20克，侧柏叶12克，红藤30克，路路通12克，天葵子12克，花蕊石20克。水煎服。

本方能减少出血量，调整月经周期，改善体质，全身症状减轻，控制肌瘤生长，对小型肌瘤有消散作用。

方二：当归尾12克，川芎10克，小茴香10克，肉桂6克，赤芍12克，生蒲黄10克，五灵脂10克，三棱10克，莪术10克，益母草30克。水煎服。

加减：气滞甚者加香附、川楝子、荔枝核。血瘀偏重者加丹参、水蛭。

方三：穿山甲片15克，王不留行10克，昆布30克，海藻30克，苡仁30克，川牛膝12克，当归12克，夏枯草30克，续断30克，香附12克。水煎服。

60. 乳房纤维瘤

乳房纤维瘤是妇女的一种良性肿瘤。患者乳房有硬块，逐渐增大，乳房胀痛，月经来前疼痛更甚，经后疼痛稍减，质地坚韧，推之可移动，边缘清楚，表面光滑。现代医学认为乳房纤维瘤的发生与雌激素作用活跃有密切关系，多发生在18—25岁，妊娠期增长特别快。给实验动物注射雌激素可促其发病，说明此病的发生与雌激素有关。

乳房纤维瘤属于祖国医学“乳癖”范畴。证属肝郁气滞挟瘀，痰浊凝结，治宜疏肝解郁，化痰散结。

方药：当归75克，乳香、没药、甘草、香附各30克，大瓜蒌（焙干）8个。此为一料量。上药研为粗末，每次取60克，水煎去渣，加入黄酒30毫升为引（不能饮酒者可不加），临睡前服用，每日一次。

方中香附理气解郁，当归、乳香、没药宣通活血，止痛散结，瓜蒌化痰散结。黄酒为引，通血脉，助药力。诸药合用对乳房纤维瘤有一定疗效。

61. 奶 瘻

奶瘻系产妇乳腺炎经手术切开后伤口久不愈合而成瘻道，乳汁和脓汁从刀口流出。伴有发热，倦怠，纳差，面色㿠白等气虚症状。瘻道处或可见腐肉外翻，乳汁从刀口外流。治宜补中益气，升阳举陷。

方药：黄芪60克，党参30克，当归15克，升麻15克，白术12克，陈皮10克，蒲公英30克，柴胡10克，银花30克，甘草6

克，水煎服。

加减：伴有乳房肿块者加穿山甲片；便秘者加大黄；乳房肿大、发热者加紫花地丁、赤芍；乳汁从瘻道口流量多，自汗者，黄芪可重用至60克；伤口疼痛严重者加乳香、没药。

注：有的患者因抵抗力弱，须坚持服药，耐心治疗，有的需连服数十剂方能显效。

62. 进行性肌营养不良症

进行性肌营养不良症是一种由遗传因素引起的肌肉疾患。主症为随意肌肌群逐渐衰弱萎缩，最后不能运动。下列二型最为常见：

一、假性肥大型（最多见）：发病徐缓，五、六岁即开始发病，腓肠肌、棘下肌、棘上肌、三角肌、肱三头肌等出现假性肥大，而其他部位的肌肉却出现萎缩现象，最后假性肥大的肌群亦显萎缩。这种萎缩呈进行性，患儿身体不断衰弱。

初发病时，患儿觉下肢无力，步行摇摆，容易跌倒，上楼梯困难，直立时两足分开甚宽。患儿起床直立很困难。先翻身成俯卧位，用手支起躯体呈俯跪位，后又成深鞠躬位，最后才能达到直立位置。这是本病的特征（肌营养不良导致肌力量不足，故起立困难）。患儿初期尚能在平地上步行，由于腓肠肌萎缩，逐渐至步行困难，直立时，脊椎下部显著前弯，躯干上部则后弯。患儿举臂时宛如鸟翼（翼状肩胛）。

二、颜面、肩胛、上臂型：从幼儿期即开始发病，颜面无表情，闭眼、举眉、皱额均有困难。肱三头肌、肱二头肌、三角肌、棘下肌、棘上肌等逐渐萎缩。

本病病情持续进行，但甚缓慢，皮肤知觉正常。

本症可通过血清检查、骨骼肌活体组织检查而确诊。

本病须与重症肌无力、风湿病引起的废用性肌肉萎缩相鉴别。

进行性肌营养不良属于祖国医学“痿证”的范畴。《素问·

《太阴阳明论》说“今脾病，不能为胃行其津液，四肢不得禀水谷气，气日以衰，脉道不利，筋骨肌肉皆无以生，故不用也”。根据本病的症状表现，证属脾虚，肝肾不足，气血虚弱，筋骨关节肌肉失养。肾亏则足跟痛，耳鸣，夜尿多；肝血不足则面色少华而晦暗，精血失养则四肢肌肉萎缩，脾胃虚弱则食欲减退。根据“肝肾同源”，精血互生之理，治宜温运脾肾，调补气血。

方一：红参10克，（切片另炖），白术10克，山药10克，柴胡10克，当归10克，黄芪50克，乌梢蛇30克，甘草10克，桂枝10克，内金6克，大枣10克，紫河车粉10克。配合服猪骨髓汤。方中乌梢蛇富有营养成分，有强壮神经及抗毒作用，能治衰弱性疾病，对“肌痿”可能有良好的治疗作用。紫河车大补气血，治一切虚劳损极（损脾则肌肉消脱，损肾则骨痿不起），诸药合用共奏全功。

方二：熟地30克，山萸肉12克，枸杞15克，补骨脂12克，寄生30克，淮牛膝30克，当归15克，千年健30克，木瓜20克，鸡血藤30克，杜仲12克，桂枝10克。水煎服。

注：健脾益气补肾药太子参、肉苁蓉、巴戟、续断、黄精、桑寄生、菟丝子、狗脊、刺五加等可随证交叉选用。

方三：天麻50克，全蝎50克，蜈蚣10条，烘干后研为细末，早晚各服2.5克（10岁以下1.5克），温开水送服。连服4—6个月。

方四：胆南星5克，麦冬5克，菖蒲5克，佛手5克，僵蚕5克，川牛膝10克，黄芪10克，伸筋草10克，钩藤5克，丹皮5克，赤芍5克，葛根5克，生牡蛎10克，生龙骨10克，女贞子10克，甘草5克。水煎服。

注：此为10岁以内小儿剂量，成人可增加一倍量，每周

服三剂，不要长期服用。

针灸疗法

取穴：脾俞、肾俞、环跳、髀关、足三里、梁丘、解溪、承扶、血海、商丘、委中。

也可脾俞透肾俞，环跳透承扶，阳陵泉透阴陵泉。

63. 儿童多动症

儿童多动症在临床上较少见。其症状表现为：挤眉眨眼频繁，眼球不时转动，双目常瞬间同向斜视，目光呆滞，视物不能持久，注意力分散，双手腕、手指小动作不断，焦躁不安，难以静坐，走路步态不稳，行走时常扭头回顾或侧身转圈，症状时轻时重，眠食无明显异常。无抽搐、惊叫、昏厥、流涎等表现。

儿童多动症的发病原因目前尚未阐明。有的病例是在受外伤后发病，可能受外界较强刺激，使患儿脑干网状结构抑制区出现不同程度的功能失调，对条件反射失去应有的调节，对大脑皮层运动区的兴奋即运动效应不能有效地控制，从而产生过多的运动效应所致。

祖国医学无儿童多动症的病名，根据症状表现，中医辨证属髓脉失养，虚风内动。祖国医学认为小儿脏腑娇嫩，形气未充，稚阳未充，稚阴未长。发病容易，变化迅速，脾常不足，肝常有余。若受外伤惊吓，稚阴暗耗，髓海不足，肝失所养，故现多动之症。治宜滋养精血，育阴潜阳，熄风镇痉。

方一：生地10克，生白芍15克，阿胶6克（烔化），麦冬10克，炙甘草6克，生鳖甲15克，生龟板15克，生牡蛎20

克，郁金6克，远志6克，菖蒲6克，地龙10克。水煎服。

方二：枸杞10克，熟地10克，当归10克，沙参10克，蜈蚣1条，白芍10克，川芎6克，太子参15克，白术10克，茯苓10克，生牡蛎15克，紫河车粉30克，（冲服），淮牛膝10克。水煎服。

64. 小儿秋季腹泻

小儿秋季腹泻，系指轮状病毒引起的婴幼儿腹泻，此病多在秋季流行，故习称“秋季腹泻”。其临床表现为腹泻、发烧、不同程度的脱水体征。血常规检查时白细胞计数一般不高，大便镜检时以脂肪球为主，大便电镜检查时多数可发现轮状病毒。

小儿秋季腹泻（轮状病毒性腹泻）属于祖国医学“泄泻”的范畴。小儿为稚阴稚阳之体，气血未充，脏腑未实，脾常不足，如喂养不当或感受外邪，易引起脾胃功能失常，故小儿腹泻以脾胃虚弱为主，病邪为次。治宜健脾清热，和胃固肠。

方一：藿香10克，地榆10克，寒水石10克，丁香1克，伏龙肝10克，赤石脂10克。配制成浓缩合剂45毫升。3—6个月的患儿每日3次，每次10毫升；6月—1岁的患儿每日3次，每次15毫升。

方二：青蒿20克，水煎分二次服，每日一剂。

注：青蒿，即菊科艾属植物黄花蒿，味苦性寒，为芳香化湿之品，对伏暑蕴于肠间所致的泄泻（秋季腹泻）有较好的治疗效果。

65. 新生儿硬肿症

新生儿硬肿症，又名新生儿硬皮病，是新生儿皮肤和皮下脂肪变硬或兼水肿的疾病。多见于早产儿或瘦弱的新生儿。其发病可能与下列因素有关：新生儿的生活力弱，体温调节能力差；冬天室温过低，水份、热量供应不足；或合并其他感染性疾病。新生儿的皮下脂肪含有熔点较高的固体脂肪酸多，遇冷则皮下脂肪凝固，形成硬块。患儿常表现为体温不升（低于35℃），皮肤变硬、发红，或有水肿，常由面颊部及大腿外侧开始变硬，重者躯干、四肢亦变硬。最严重者全身僵硬。

新生儿硬肿症与中医学“五硬”中的肉硬相似，发病原因为先天不足，元阳衰微，寒凝经络，气滞血瘀。中医认为，肾为先天之本，内藏真阴真阳。患儿因先天不足，形气未充，元阳衰微，脾阳不振，气血乏化生之源，阳气不能温煦肌肤，气血不能荣于四肢，风寒之邪乘隙而侵，阻于肌肤，血不行营，痹塞不通，营卫失和。治宜健脾温肾，活血化瘀。

方一：鹿茸0.3克，（研末调服），熟地4.5克，巴戟4.5克，丹参3克，当归3克，桂枝3克，黄芪6克，制附片6克。水煎频服。

方二：红参6克，炙甘草6克，白芍6克，桂枝5克，当归10克，木通3克，细辛3克，大枣3克。水煎频服或鼻饲。

方三：小茴5克，橘核12克，细辛3克，红花2克，丹参6克，木通5克，白芍5克，桂枝5克，当归5克。水煎服。

方四：鸡血藤10克，补骨脂6克，苁蓉6克，巴戟3克，制附片3克（先熬），红花3克，丹参10克，炒白术10克，茯苓

10克，炙甘草3克，大腹皮6克，桂枝6克，白芍6克。水煎服。

方五(外敷药)：肉桂6克，丁香6克，川乌5克，草乌6克，乳香5克，没药5克，当归15克，川芎15克，红花15克，透骨草15克，共研细末，用凡士林调敷硬肿处。隔日换药一次。

对新生儿硬肿症，重在预防。冬天产妇分娩时，室内要暖和些，孩子一出生就要用被褥包好，放在热炕头上，或用热水袋放在被褥下。对早产儿更要注意保温。切不可受旧风俗的影响，认为男孩子火气大，不敢在室内生炉火，不给孩子保温，结果易发生硬肿症。医务人员应作好新生儿的访视工作，及早发现及早医治。

66. 腱鞘囊肿

腱鞘囊肿是手和足部的关节或腱鞘内的滑液增多后发生的囊性疝出（囊性肿块）。其大小不一，为圆形或椭圆形的单囊或多囊（如图），内含胶性液体。手或足的肌腱或关节因长期过度运动引起，也可由结缔组织的粘液性变所致。



腱鞘囊肿可发生于腕背部、腕掌侧、足背部、踝关节周围、膝关节周围等处。

患者女性较多。起病缓慢，在腕或足背部出现一圆形包块，约1—1.5厘米大小；表面光滑，不与皮肤相连；基底固定；橡皮样硬度，当关节位置调节至囊内压降低时，可有波动感，反之，硬如实质性肿瘤；疼痛和压痛很轻。

腱鞘囊肿可以自消，但时间很长。西医骨科或外科对腱鞘囊肿的处理，一般主张先在局部垫以硬物，随后用皮榔头之类猛击之，以使其消散。或用手术切除。此等疗法病员痛苦较大，复发机会亦多。

腱鞘囊肿，中医称之为“筋疔”或“筋结块”。其发生常与劳损、风湿等因素有关。多采用针刺或手法治疗。

方法一：作局部常规消毒，用大号三棱针（先消毒），对准囊肿最高点，迅速刺入，捻捣二三次，立即出针，同时用力挤压肿块，务使囊内胶性粘液从针孔全部排出，然后用酒

精棉球擦净局部，绷带加压包扎即可。

方法二：用消毒注射针头在囊肿四周分别针刺，然后再用手挤压。囊肿挤破后，嘱患者用手按原囊肿处，以后每天按摩10分钟。

方三：红花15克，白酒100克。红花放入热酒内浸透，速从热酒内将红花取出放于患处，反复搓擦，一日数次。

67. 非化脓性肋软骨炎

非化脓性肋软骨炎是病因未明的一种常见病。多发生于20—30岁的青年，累及部位多在胸骨旁第2—4肋软骨。症状为局部肿大隆起结块，吸收缓慢，皮色正常，自感胸痛（钝痛或锐痛，有压痛），严重者甚至拼气，不能举臂。局部皮肤并无炎症反应。疼痛消失后，肿块可存留较长时间，肿大的肋软骨甚至可持续数年之久。有时劳累后，疼痛还会发作。患者除有低烧外，极少有全身症状出现。胸部X线透视也无异常。

妇女患肋软骨炎多数以乳痛就诊，因肋软骨与乳房部位相近。肋软骨炎的疼痛常放射到乳房，因此诊断宜注意，未诊断清楚时，治疗最好适当地双方兼顾。肋软骨炎与乳房疼痛虽容易混淆，但还是可以鉴别的：肋软骨炎疼痛较剧，咳嗽、深呼吸、侧身等均能使疼痛加剧，而乳房疼痛则不受这些因素影响。

肋软骨炎属于祖国医学“胸痛”、“胸痹”范畴。本病多由肝失条达，外淫风热毒邪及痰湿侵及肝络瘀阻而成。中医还认为，肋软骨炎疼痛窜及胸部、上臂、肩背乃气滞；局部隆起，压痛明显，痛点固定不移乃血瘀。气滞血瘀也是肋软骨

炎的病机之一。《医学发明》云：“血者，皆肝之所主，恶血必归于肝，不问何经之伤，必留于肋下”。说明肋软骨炎与瘀血有密切关系。瘀血阻络，不通则痛。治宜理气祛痰，活血化瘀，宽胸散结。

方一：木防己30克，全瓜蒌30克，生石膏30克，桂枝10克，赤芍15克，柴胡12克，半夏12克，当归15克，香附12克，延胡索12克。水煎服。

方二：穿山甲15克，桃仁12克，红花12克，夏枯草30克，青皮12克，丹参30克，银花15克，大黄15克(后下)。水煎服。

方三：生大黄30克，黄连30克，黄柏30克，乳香15克，没药15克，共研细末，加米醋适量调成糊状，每日一料分两次外敷患处。一般1—2日疼痛可消失，4—6日肿胀、压痛可消失。

方四：当归15克，赤芍15克，香附10克，玄胡10克，川芎10克，郁金12克，地鳖虫12克，丹参12克，益母草30克，王不留行12克。水煎服。

方五：瓜蒌壳20克，薤白30克，枳壳10克，桂枝10克，姜半夏12克，柴胡12克，玄胡12克，川楝子10克，白芍30克，制川乌15克(先熬)。水煎服。

加减：局部肿痛甚者加蒲公英、银花、白芷；上肢痛者加姜黄；第2—4肋痛者加桔梗；第8—10肋痛者加青皮、香附；胸闷者加广木香、砂仁、郁金、佛手；体虚者加党参、黄芪、当归。

方六：夏枯草30克，青皮10克，橘核30克，桃仁10克，红花10克，白芍15克，当归15克，白术12克，茯苓15克，三棱10克，玄胡10克。水煎服。

加减：气滞者加郁金、香附；肾阳虚者加仙灵脾、仙茅；肾阴虚者加女贞子、旱莲草；口干者加生地；便秘者加全瓜蒌、昆布。不解决便秘，疗效往往不佳。

68. 落 枕

落枕是枕头高低不当及头颈歪斜致使颈椎长时间扭曲，或突然猛力转头导致颈椎后关节轻度移位，椎间肌力失去平衡，局部肌肉、肌腱、筋膜等软组织发生痉挛导致颈项强硬。中医认为落枕多由于局部经络组织在伸展状态下过久而疲劳，致局部经络气血凝滞，复受风寒侵袭，筋脉拘急，转动不灵，不通则痛。治疗应以解除痉挛，利节止痛。手法治疗不宜在病人注意力高度集中时强行操作，颈椎结核及颈关节脱位者不宜作手法治疗。

一、耳穴疗法

耳穴按压法：

取穴：颈、神门。

治法：取绿豆1—2粒，放在市售伤湿止痛膏（剪成的约1×1厘米）方块中间，粘贴在选定的耳穴上，将边缘压紧，同时按压已贴好的耳穴1分钟，手法由轻到重，按至有热胀感和疼感（以患者能忍受为度）。并嘱患者转动头颈。这样，大多数患者自觉症状即行缓解。再嘱患者时常按压粘贴绿豆的耳穴以巩固疗效。

二、推拿疗法

取穴：风池、天柱、后溪、极泉、小海。

病人坐于靠背椅上，医生站于病人背后，双手捏拿病人颈肩部的所选穴位，再以双手掌根相合扶住病人后颈部的两

侧，将病人面部稍转向患侧，做轻而慢的头前屈运动，以分散病人的注意力，待病人呼气的瞬间双手掌根同时突然用力，

(即以扶病人健侧之手掌根向前推与扶病人患侧之手掌根往后拉的合力)，向病人的患侧拨动其颈椎，立即可闻及清脆的“咔咔”响声，一般向患侧拨一次就可收到明显的效果。但掌拨的角度不能超过头部侧转的35度。用力要轻而快，不宜过猛。每日一次，每次3—5分钟，1~3次即可。

又：患者俯卧，双臂前屈于颌下，右颈痛头向左歪斜，左颈痛头向右歪斜，双侧痛取正卧位，暴露患部，术者于疼痛部位，施行旋转按摩法，由轻到重，并施以揉法、捏法等，直至颈部松弛，痉挛缓解，疼痛消除为准。

三、针刺疗法

取穴：①落枕穴（患侧的手稍握拳，于手背第二掌指关节尺侧缘取“落枕”穴，又名颈项点）。

②悬钟穴(又名“绝骨穴”)。

落枕穴进针0.5—0.8寸；悬钟穴进针1.5寸。均取患侧(单侧)，然后令病人活动颈部，留针30分钟，在留针期间每隔5分钟运针一次，平补平泻。

四、艾灸疗法

艾条点燃后在压痛明显处回旋熏灸约15分钟，每天一次。有温通经络之效。

五、穴位注射疗法

取穴：天柱，足三里。用当归注射液2毫升，注入天柱穴皮下后，推药1毫升，剩余药液注入同侧足三里穴。

69. 直肠息肉

直肠息肉系泛指 直肠粘膜表面向肠腔突出的隆起性病

变。包括有腺瘤、儿童型息肉、炎性息肉及息肉病等。有的是良性肿瘤，有的是炎症增生的后果。直肠息肉经直肠镜检查可以确诊。

直肠息肉的主要症状是便后出血，血色鲜红，量不多。血常染在粪便之外。位于直肠下端的带蒂息肉常在排便时脱出肛门外，呈鲜红、圆樱桃状，便后可以自行复回。当息肉并发溃疡及感染时，则大便次数增多，里急后重，大便有排不尽的感觉，便后出血，常有血性粘液排出。息肉病时则直肠满布息肉，每日多次腹泻，成血性粘液便，消瘦，营养不良，重度贫血。

诊断直肠息肉，直肠指检很重要。较大的息肉均可于直肠指检时扪及，为圆形柔软肿物，活动度较大。

直肠息肉属中医肠风便血范畴。大便带血，血色鲜红，血与粪便不相混杂，属“近血”。治宜攻坚散结，收敛止血。

方一：乌梅1500克（酒醋浸泡一夜，以浸透乌梅为度，去核，焙焦存性），僵蚕500克（米拌炒微黄为度），人指甲15克（用碱水或皂水洗净，晒干，再和滑石粉入锅内同炒至指甲黄色鼓起为度，取出筛去滑石粉，放冷，碾粉备用），象牙屑30克。上药共为细末，炼蜜为丸，每丸重10克，一日服三次，每次服一丸，白开水送下。

方二：党参15克，乌梅15克，当归12克，地榆12克，赤芍12克，前仁12克，僵蚕12克，生牡蛎24克，黄连5克，甘草6克。水煎服。

加减：大便干者加火麻仁；腹痛甚者改赤芍为白芍；腹胀痞满者加莱菔子；便血甚者加地榆炭，并配用2%枯矾液保留灌肠，每次20分钟，每日2次。

方三：鲜鳝鱼1500克，置瓦上用火焙烤至焦黄，泡入500

毫升白酒内，(泡三天)每日服二次，每次服20毫升。

70. 睾丸鞘膜积液

鞘膜积液系指睾丸或精索的鞘膜囊有液体积聚。多由先天发育异常，腹膜鞘状突闭合不全而致，多见于婴幼儿。主要临床表现为：阴囊内肿物呈圆形或长圆形，光滑，有囊性感，多单侧发生，自觉下坠，无疼痛。液量多时不易扪及睾丸。继发性鞘膜积液发生较快，常有剧痛，但积液不多，混有血液。

鞘膜积液属于祖国医学“疝气”、“胎疝”、“水疝”、“癰疝”、“阴肿”、“偏坠”等范畴。中医认为，水液运化，其制在脾，脾气不升，运化失司，则水气停滞，肝脾互相影响，酿成本病。积液量少者可自行消失。积液量较多且有疼痛者可用中药治疗。

方一：党参10克，白术10克，茯苓6克，泽泻6克，巴戟6克，淫羊藿6克，菟丝子6克，仙茅6克，胡芦巴6克，桂枝4.5克，炙甘草3克。水煎服。(此为4—5岁小儿用量，下同)。

方二：桂枝6克，白术6克，泽泻6克，荔枝核6克，橘核6克，猪苓6克，茯苓6克，党参10克，黄芪10克，昆布6克，海藻6克。水煎服。

方三：小茴香6克，台乌6克，青皮6克，黄芪10克，木香6克，车前草10克，槟榔6克，川牛膝6克，赤芍6克，当归6克，桃仁3克。水煎服。

方四：篇蓄30克，苡仁45克，加水浓煎，分三次服，每日一剂。

方五(外用方): 枯矾、五倍子各12克, 研粗末, 加水1000毫升, 煎30分钟, 去渣, 待温, 把阴囊浸入药液中, 每次浸洗30分钟。

方六(外用方): 紫苏15克, 银花30克, 蝉蜕30克, 水煎, 去渣, 外洗或热敷, 每次30分钟, 每日一剂, 洗2—3次。

方七(外敷方): 白胡椒12克, 肉桂24克, 研末, 调入万应膏药500克内, 摊布上, 贴患处, 3天换药一次。

方八: 水蛭1克, 苡仁30克, 苍术6克, 木通3克, 车前子6克, 桃仁3克, 昆布6克, 海藻6克, 荔枝核6克, 橘核6克, 小茴香3克。水煎服。

若鞘膜积液难消, 加五倍子12克, 肉桂6克, 研细末, 米醋加温, 调敷肿大之阴囊。

71. 网 球 肘

网球肘因网球运动员好发而得名。主要表现为肘外侧疼痛, 本病又名劳损性桡骨疼痛、肱骨外上髁炎、前臂伸肌联合肌腱炎、桡骨头滑囊炎等。网球肘一般均无明显发病原因, 病人多数是长期以手持工具, 作腕肘伸展动作的工人, 以肱桡关节处, 桡骨头外侧持续性疼痛为主要症状。多数病人劳累后疼痛加重, 少数病人疼痛放射至前臂伸侧、桡侧及腕部, 极少数病人放射至上臂及肩部, 个别病人气候变化时疼痛加重且多有关节炎史。

中医认为网球肘系劳损所致, 气滞血瘀, 不通则痛。治宜疏筋活络, 活血化瘀。

方一: 仙鹤草30克, 桑枝30克, 银花藤30克, 白芍30克, 姜黄10克, 甘草10克, 大枣15克。水煎服。

加减：疼痛向前臂放射者加茜草10克，生地30克；疼痛向上臂放射者加威灵仙10克，羌活10克；兼风湿者加桂枝10克，细辛6克。

方二(外治方)：五加皮30克，刘寄奴30克，伸筋草15克，威灵仙15克，没药10克，红花10克。水煎外洗。

72. 足 跟 痛

足跟痛是临床上常见的一种病证。多在50岁以后发病，妇女较男子为多见。症见足跟或脚底部酸胀作痛，或针刺样痛，牵连小腿酸痛，步履困难，发作时间不定。

中医认为足跟痛的病因系肾虚。多由先天不足，情志失调，房劳过度所致。足跟为肾经所过之所，此处作痛，乃肾脉亏损，肝失所养。肝主筋，肝血不足，筋失濡养，血行瘀滞；或肾亏髓空，寒湿之邪乘虚入侵，脉络失和，发为本病。《素问·上古天真论》说：“女子七岁，肾气盛，齿更发长。……丈夫八岁肾气实，……二八肾气盛……五八肾气衰，发堕齿槁。”说明男女生长和衰老的过程是以肾经为主的。从经脉循行路线上看，足少阴肾经，起于小趾下，斜向足心(涌泉)，出于舟骨粗隆下，沿内踝后，进入足跟。说明足跟痛是老年肾虚的象征。

此外，外伤、骨质增生、邪毒、风湿等也可引起足跟痛。

足跟痛的辨证分型治疗：

1. 虚损型：以老年、产妇和体虚病人多见。病程长，绵绵作痛，伴全身虚弱症状。病人有两种情况：一是久病卧床，筋骨痿弱，动则无力，行走不稳，足跟不敢着地，有空虚感；

二是病人年迈，不能久立久行，足跟绵绵作痛，全身骨质有疏松现象。足跟位于骨骼之末，承担全身重量，年老体弱，肝肾亏虚，足跟作痛，治宜补益肝肾。

方药：山药30克，熟地15克，制首乌15克，当归12克，苁蓉12克，杜仲12克，白芍12克，山萸肉12克，淮牛膝30克，鸡血藤30克，伸筋草30克。水煎服。

2. 损伤型：病人多有外伤史或跑跳史，痛点以跟腱抵止点的跟骨结节附近为著，呈牵扯样或针刺样疼痛，跛行，行走时缺乏弹性，局部有肿胀、压痛。由于局部脉络损伤，气滞血瘀，致使血脉运行受阻或血液停留积聚，引起肿胀，“血不利则为水”。治宜行气活血，渗湿止痛。

方药：当归15克，赤芍15克，桃仁10克，红花10克，乳香10克，没药10克，丝瓜络30克，川牛膝30克，苡仁30克，千年健30克。水煎服。

3. 骨质增生型：以足跟疼痛为著，多为钝痛或针刺样痛，轻者不能久立久行，重者站立和行走困难，寒冷刺激或劳累后疼痛加重。X线检查可发现足跟底部有骨刺形成。此由肝肾阴液不足，髓不养骨，故而生赘、疼痛。治宜补益肝肾，渗湿活血。

方药：鹿衔草30克，淫羊藿30克，苁蓉15克，熟地15克，补骨脂12克，骨碎补10克，茜草12克，红花10克，篇蓄10克。水煎服。

4. 邪毒注骨型：青少年多见，包括跟骨结核、骨髓炎等。证见足跟肿胀疼痛，局部压痛，如有破溃则长期不愈，有分泌物。化验检查可见白血球增高，血沉增快。此乃结核、邪毒下注于骨，久而不解。治宜解毒祛邪，疏通脉络。

方药：银花30克，连翘15克，当归30克，玄参15克，蒲

公英30克,紫花地丁20克,桃仁12克,红花12克,天冬20克,黄芪30克,党参30克,香附12克,黄精15克。水煎服。

5.风湿束骨型:病人多有感受风寒外邪史,复因夜露,涉水或工作、居住环境潮湿,邪毒侵于骨而发病。特点是发病急,足跟疼痛,下肢沉重,行走困难,甚至足跟肿胀,伴有乏力、自汗、全身酸痛等全身症状。治宜祛邪散寒。

方药:羌活12克,独活12克,苡仁30克,防己15克,苍术15克,茯苓15克,桂枝15克,桃仁12克,桑枝30克,豨莶草30克,鸡血藤30克,黄芪30克,续断30克。水煎服。

足跟痛还可采取“下病上取”法治疗。取穴:合谷后约一寸处,直刺,深约1.5寸,以有酸胀感为度,留针1小时。进针后10分钟左右,有的患者即感足跟有发热感(即刻效应),这类患者疗效明显。

73. 关节腔积液

关节腔积液,现代医学认为是一种原因不明的关节疾患,临床以膝关节等关节肿胀、疼痛和活动受限为主要症状。X线摄片检查,可见关节间隙增宽,软组织阴影扩大。

关节腔积液,属中医的“鹤膝风”、“痹证”等范畴。临床表现为关节肿痛酸楚,触之软绵,皮色光亮,微热或不热,屈伸不利,不能行走。患者多形体消瘦,溲短便溏,纳少神疲。中医认为,素禀不足,脾肾亏损,气血两虚等是其内因,饮食失节,起居异常,身体劳倦等是其外因,致使脾肾及三焦功能失调,水液内蓄,浊液稽留关节,阻塞关节经络气血,营卫不和,气血失畅,积聚成疾。如《内经》云:“气伤痛,形伤肿”,遂产生关节腔积液。

内服方一：黄芪30克，桂枝12克，白芍12克，生姜12克，大枣12克，白芥子12克，秦艽10克，防己10克，川牛膝10克。水煎服。

内服方二：猪苓10克，泽泻15克，茯苓皮15克，赤小豆30克，黄芪30克，桂枝10克，白术12克，穿山甲12克，防己12克，制马钱子2克。水煎服，每日一剂。

内服方三：萆薢12克，路路通12克，木通10—30克，黄芪30克，滑石粉15克(包煎)，黄柏10克，菖蒲10克，木瓜15克，苍术30克，泽泻20克。水煎服(本方适用于苔白腻、痰湿重的关节积液症患者)。

内服方四：当归15克，桃仁10克，红花10克，穿山甲10克，川牛膝15克，地龙12克，滑石粉15克(包煎)，茯苓12克，焦术12克，泽泻12克，路路通12克。水煎服(本方适用于膝关节皮色青紫之瘀血型关节积液症患者)。

内服方五：苡仁30克，赤小豆30克，木瓜30克，黄芪60克，炮山甲15克，寄生30克，附片30克(先熬)，肉桂6克(后下)。水煎服。

外敷方一：白芥子60克(微炒先捣烂)，大葱30克，生姜30克，共捣烂外包膝肿部，连包2—3天，患处起泡破皮，不必害怕。此方屡用屡效。

外敷方二：如意金黄散(成药)适量，调酒湿敷关节局部。或用铁箍散(成药)适量调酒湿敷患处。

附：功能锻炼：

1.伸膝抬举：练股四头肌肌力，促进膝关节积液吸收消肿，也可在小腿上加沙袋进行锻炼。

2.屈膝或跪压：待膝关节积液消退，逐渐用单膝或双膝在床上练跪，最好能达到足跟触及臀部。

3.下蹲练习：练习下蹲，从每天20次开始，增加到每天80—100次(维持量)，每天坚持练习，足跟要落地，蹲站要实。也可练习转膝动作。

74. 膝关节结核

膝关节结核继发于肺结核或淋巴结核等。结核杆菌由原发病灶通过血液循环侵入骨关节组织后，当全身抵抗力降低时，即可发病。膝关节结核每使骨质与关节受到不同程度的损害与破坏，病程绵长，往往造成肢体废用性萎缩，如肌肉的拘挛，关节的粘连、强直。

膝关节结核发病缓慢。初期膝关节肿胀，局部温度微高，并有疼痛，膝胀呈梭形，出现跛行，但膝关节仍能完全伸直。到了晚期则膝关节屈伸活动均受限制。严重的可有膝关节屈曲，外旋或外翻畸形，胫骨常有向后不完全脱位，甚至畸形位强直。脓肿破溃后形成窦道，经久不愈。膝关节结核可经X线检查、关节液检查和细菌培养或滑膜组织病理检查等确诊。

膝关节结核属于祖国医学“骨痹”、“流痰”、“鹤膝风”等范畴。本病病因多为正气不足，肝肾亏损，或先天不足，骨骼柔嫩，或因外伤所致气血失和、瘀血阻络，或外感风寒湿邪，以致痰浊凝聚。

本病发病缓慢，缠绵难愈，既有肾亏骨空、气血不足之虚，又有气滞血瘀寒湿痰浊凝聚之实。初发时往往表现为神疲倦怠，形寒肢冷，膝部肿、麻、酸、胀作痛。病久精血内耗，寒久化热，出现盗汗、潮热、消瘦、膝部肿痛增加。当其化脓之时，脓水淋漓，出现气血两虚、阴阳俱衰的症状。

膝关节结核治宜滋阴，凉血，清热，补气，养血，温肾扶正。

一、血热瘀结型：有外伤史，关节红肿热痛，触之灼手，舌红苔黄脉数。治宜泻火解毒，凉血清热。

方药：石斛15克，生地30克，桑枝30克，仙鹤草30克，鸡血藤30克，银花藤30克，赤芍12克，丹皮12克，茜草10克，白芍15克，白薇10克，生大黄10克。水煎服。

二、肝肾不足型：胫枯，膝肿，疼痛，膝关节活动不利，面色萎黄无华，虚羸形瘦，舌淡苔白脉无力。治宜滋阴清骨。

方药：熟地20克，黄芪30克，石斛15克，当归15克，白薇10克，银柴胡10克，胡黄连10克，青皮10克，地龙12克，太子参30克，鹿角胶6克。水煎服。

三、气血两虚型：关节肿痛已久，遇劳则甚，形体瘦削，低热汗出，舌淡苔白脉虚弱。治宜补气养血益精。

方药：红参6克嚼服（或党参30克煎服），海马3克，（调服），石斛15克，生地30克，枸杞15克，银花藤30克，丝瓜络30克，黄芪30克，鸡矢藤30克，仙鹤草30克，淮牛膝20克，当归10克。水煎服。

四、肾虚阳衰型：久病迁延，关节肿痛不已，活动不便，伴神疲面白，倦怠懒言，腰膝酸软，面容憔悴，舌淡苔白，脉沉迟无力。治宜温肾助阳，扶正托毒。

方药：红参6克，鹿角片6克，肉桂6克，熟地30克，黄芪30克，淮牛膝15克，当归15克，山药30克，制附片20克（先熬），苍术10克，炒白术15克，炙甘草6克，陈皮10克。水煎服。

75. 褥 疮

褥疮多见于瘫痪和长期卧床不能自动翻身的患者，由于局部组织的血管神经受压，发生营养障碍所致的皮肤全层坏死。机体衰弱及局部抵抗力减弱者，易于发病。

症状：局部受压迫后，皮肤初呈苍白、灰色或红色，边界清楚，中心颜色较深。病势急速进行，可于表面发生水泡，破裂后形成溃疡。疮面塌陷，脓液稀白。若不及时处理，疮面可蔓延扩大，并向深部发展，侵及肌肉、骨骼，组织坏死，易继发感染或通过血行播散而引起败血症。

褥疮属于祖国医学“席疮”范畴。因久病气血亏损，压挤部位气滞血瘀，血脉不通，经络隔阻，肌肤失养，溃腐成疮。褥疮之共性为瘀，治宜突出“通瘀”。

方一(内服方)：银花12克，连翘15克，石斛12克，赤芍15克，白芍12克，当归15克，丹皮10克，穿山甲片12克，黄芪30克，党参30克，茯苓12克。水煎服。

方二(内服方)：桃仁12，红花12克，川芎12，白芷12克，白术12克，当归30克。黄芪60克，党参30克，甘草10克。水煎服。

方三(外敷方)：煅石膏60克，尿浸炉甘石200克，白蜡60克，枯矾90克，煨马钱子12克，冰片10克，共研细和匀，外敷患处。

方四(外敷方)：滑石60克，龙骨60克，川贝10克，白芨20克，麝香1克，冰片1克，研末，混匀，外敷患处。

方五(外敷方)：珍珠末适量。先用2%白矾水清洗疮面，疮面上再匀撒珍珠末，薄敷料覆盖，隔日一次，如迟迟不收

口，用人参养营汤煎水内服（人参养营汤方：人参、黄芪、白术、茯苓、炙甘草、当归、白芍、熟地、陈皮、桂心、五味子、远志、生姜、大枣）。

艾灸疗法

先用消毒镊子镊取盐水棉球，将疮口中的渗液或脓液除去，如有脓痂须除尽。然后用艾条点燃一端，对准施灸部位，一上一下地熏灸，再回旋熏灸疮周，交替进行。灸治过程中，褥疮周围可出现红晕，这是正常的。每次灸毕，疮内和疮周的热感可持久不息。艾灸的温度较高，可起杀菌作用。

每日施灸一次，每处灸20分钟，不计疗程。

褥疮还必须加强护理，要勤翻身，辅以按摩、外敷疗法。要让患者经常改变体位，解除局部压迫，加强营养，大量补充水果蔬菜或维生素等。

76. 乳头皲裂

乳头皲裂，俗称烂奶头，以哺乳期妇女常见。其症状表现为乳头裂口、疼痛，或有少量流血和渗液，两乳晕溃烂如癣，严重影响哺乳和睡眠。治疗宜用外治药物为主。

方一：白芨（干品）适量，捣烂研极细末，过筛装瓶备用。

用时取白芨粉和猪油（用微火化开）适量调成膏状，涂于患处，日3—4次。流血、渗液多者可干撒白芨粉，待渗出减少后再涂膏。一般3—5天痊愈。

方二：黑白芝麻各20克，炒黄研细，川贝10克，研细。两药混合过筛备用。用时视患处大小，取药粉适量和香油调成糊状，涂敷患处。每日2次，若流血、渗液者，先用药粉

干撒于创面，待脓水收敛后再涂敷。治疗期间患侧停止哺乳。

方三：五味子、五味子各等分研细，冰片少许，生香油适量拌成糊状，外敷乳头。

77. 疥 疮

疥疮是由疥虫(疥螨)引起的接触传染性皮肤病，易在家庭及集体单位中传播。发病多从手指间开始，好发于手腕、腋下、乳晕、脐周、阴部及大腿内侧。初为米粒大红色丘疹，小疱，脓疱和疥虫隧道。日久可因搔抓而继发化脓感染及湿疹样变。

疥疮夜晚瘙痒剧烈，白天轻微。全身抓伤后常有结痂及色素沉着。

患处查到疥虫即可确诊。

疥虫检查法：用大头针针尖刺入手指缝疥虫隧道终点的丘疹或水疱处，挑破，即见灰白色小粒附于针尖之上，有时可见其移动。将此灰白小粒放于玻璃片上，用放大镜(或显微镜)观察即可见到疥虫。疥虫为卵圆形，黄白色或淡褐黄色，全身生有棘毛，有足四对，向前两对肢端有吸盘，向后两对肢端有长刚毛。雌虫较大，长约0.3毫米，宽约0.25毫米。须仔细观察方能见到。

治宜止痒解毒杀虫。

方一：马钱子磨醋外擦患处。

方二：千里光100克，加水适量煎沸后约10分钟倒盆内，去渣，用毛巾浸泡后洗患处，每日1—2次，每次30分钟。

方三：蛇床子30克，地肤子30克，白癣皮30克，苦参30

克，牛蒡子30克，连翘30克。煎水熏洗患处，每日2次。

方四：硫磺膏外搽患处。

注：疥疮具有传染性，发现患者应立即隔离治疗。家庭中或集体单位中如有同患者，应同时进行治疗。每治疗三日应洗澡换衣。换下的衣褥被单要用水煮洗，以彻底消灭疥虫和虫卵。

78. 尖锐湿疣

尖锐湿疣是一种少见的病毒性皮肤病，好发于粘膜和皮肤交界处(皮肤湿润区域)，外阴部如冠状沟、包皮内叶、女阴、大小阴唇、会阴及肛门周围等。少数亦可见于腋窝、脐窝、乳房皱襞或趾缝。常见于慢性淋病、妇女白带过多及包皮过长者。

尖锐湿疣初起为细小、淡红色丘疹，逐渐增大，表面凹凸不平，湿润柔软，呈乳头样、蕈样或菜花样突起。根部有蒂，表面糜烂，皮肤损裂处有混浊浆液渗出，带有恶臭。常由于不断搔抓及局部潮湿等慢性刺激，促进肿物迅速生长，或引起继发感染，肿物互相重叠可如鸡蛋大，持续多年不愈。

尖锐湿疣可通过病理检查确诊。

尖锐湿疣属于祖国医学“湿热下注”范畴。湿热毒邪蕴结发为肿物。治宜清热解毒，软坚消肿。

方一：板蓝根30克，大青叶30克，马齿苋30克，败酱草30克，苡仁30克，旱莲草30克，白花蛇舌草30克，三棱10克，莪术10克。水煎服，每日一剂。同时将药渣煎水熏洗局部。

方二：苦参30克，蛇床子15克，苍术30克，黄柏15克，百部15克。煎水外洗患处。然后撒上适量的松花粉。

注：如由包皮过长，白带过多等引起尖锐湿疣者，应积极治疗白带、包皮过长等，以根除病因。

79. 玫瑰糠疹

玫瑰糠疹是一种炎症性皮肤病，多发于青壮年，春秋两季发病较多，病因尚不明瞭。病变开始常在躯干部先出现一个较大的圆形和椭圆形淡红或黄褐色斑片，直径约3—5厘米，边缘稍高起，上覆细小的糠状鳞屑为其特征。这种直径3—5厘米的淡红色或黄褐色斑片，称作母斑或先驱斑。1—2周内，可发生许多大小不等的皮疹，呈圆形或椭圆形，直径比母斑小，约1厘米左右(称为子斑)，皮疹对称分布于躯干及四肢近端，经4—8周后，开始消退，不留任何痕迹。消退时一般先自中央部开始，由黄红色渐变为黄褐色、淡褐色而消失。愈后一般不复发。只有极个别患者，皮疹会反复成批出现，病程可延至半年以上才能痊愈。

玫瑰糠疹属于祖国医学“风痹”、“血疳”范畴。其病因不外风热挟湿，血热生风。风热为阳邪，热毒灼津伤血，入于营卫，迫血妄行，血不循径，溢于肌表则为红斑；血热生风，风为燥邪，风毒侵表，皮肤生屑，以致瘙痒。治宜清热解毒，祛风润燥。

方一：银花藤30克，黄芩10克，苦参10克，防风10克，白蒺藜10克，苍耳子10克，牛蒡子10克，蛇床子10克，玉竹6克。水煎服。

加减：风热挟湿重者加藿香、佩兰、茯苓；血热风燥重者去苍耳子，加生地、丹皮、玄参、石斛。

方二：蝉衣10克，荆芥10克，苍耳子10克，炙麻黄10克，

当归12克，蚤休10克，车前草30克，苍术10克，地肤子30克。水煎服。

加减：热重加银花、鸭跖草；瘙痒甚加白癣皮、苦参；口渴加天花粉、生地、鲜石斛；大便秘结者加元明粉、生大黄。

方三：龙胆草10克，黄芩10克，栀子10克，泽泻10克，丹皮10克，柴胡10克，玄参10克，当归10克，车前子10克，生地30克，土茯苓15克，白癣皮15克，生甘草5克。水煎服。

本方补中寓泻，凉里含温，使肝火降，湿热清，气机畅则痒疹自愈。

80. 生漆过敏性皮炎

患者因接触漆树、漆木、漆液、漆器（均为生漆）而立即引起皮肤剧烈瘙痒、红肿、水疱等症状，称为生漆过敏性皮炎，亦称漆性皮炎、大漆皮炎。民间习称为“漆痄子”、“漆咬”。

生漆皮炎的潜伏期长短不定，短者数小时，长者两周。

发病部位最初多在脸部、颈部、腕关节周围、手背，继则迅速向外阴部、胸、腹、腰、四肢等处扩延。但很少发生在背部和手掌。

症状可分为皮炎型和荨麻疹型。

皮炎型，轻重不等，一般局部先有剧痒感，搔抓后出现密集的针头至粟粒大小红色小丘疹，迅速变为小疱或大疱，疱液清澄。破裂后露出糜烂面，有大量浆液渗出，可结成黄色浆痂。患部红肿明显，尤于脸部及外阴部为甚，常致眼裂不能睁开。可伴有头痛发热、纳差便秘、心悸等全身症状。

荨麻疹型：仅局部有痒感，由于搔抓而出现大小不等的风团，有明显的皮肤划痕症。

生漆过敏性皮炎，中医称“漆疮”或“湿毒疡”。证属毒邪外袭，肌肤蕴热。祖国医学认为“禀性畏漆，皮毛腠理不密，而受漆气辛热之毒而成”。治宜疏风清热，除湿消肿。

方一：荆芥12克，防风12，当归12克，连翘12克，蝉蜕10克，牛蒡子10克，知母12克，生石膏20克，木通6克，浮萍12克，甘草10克。水煎服。

方二(外用方)：生黄柏500克，干马齿苋500克，加水煎成5000毫升，外洗患处，每日2—3次。

方三：苡仁30克，茯苓15克，泽泻20克，萆薢15克，滑石30克，通草10克，苦参15克，黄柏12克。水煎服。

方四：韭菜适量，捣汁湿敷患处。

方五：鲜螃蟹捣糊外涂患处。

方六：棕榈炭30—60克，枇杷叶20—40克，冬桑叶30—60克，甘草30—60克，煎水湿敷或外洗。

方七：桑叶15克，菊花15克，银柴胡15克，防风12克，乌梅6克，甘草10克，连翘12克，五味子6克。水煎服。

加减：病在上(发于脸面)加薄荷；病在中加黄芩、苍术；病在下加川牛膝、黄柏、滑石、木通；黄水浸淫加白芍、木通、前仁、滑石，并重用乌梅、五味子。

方八：千里光、朴硝、大黄、生山楂各60克，日一剂，煎水300毫升，外洗或湿敷患处，每次洗15分钟。

81. 雀 斑

雀斑亦名夏日斑。脸面、颈部及手背等处发生黄褐色或

暗褐色斑点，患者无自觉症状。雀斑以鼻与颧部为多，甚者整个面部皆发，碎点无数，骤观成片，细看则点与点有隔离。雀斑经日光或其他含有紫外线的光线照射后，能迅速产生黑色素，故夏季雀斑颜色加深，数目增多，冬季减轻。

雀斑，祖国医学亦称雀斑，或称“面皯黚”。中医认为肾水不荣于面，肺火郁于孙络之血分，加之风邪外侵，风血相搏，血滞孙络而成本病。《医宗金鉴》说：“火郁孙络血风成”，即指此意。治宜祛风活血。

方一：丹参30克，鸡血藤30克，浮萍30克，生地20克，红花10克，川芎10克，荆芥穗10克，连翘15克，甘草10克。水煎服。

方二：黄芪30克，党参30克，当归15克，麦冬15克，五味子15克，桂枝12克，红花10克，鸡血藤30克。水煎服。

笔者曾用本方治一风湿性心脏病患者，面色皯白，但满脸雀斑，夏季雀斑加深而且增多，经常服用本方，两年后，雀斑逐渐消退，即使经日光照射后，雀斑也不加深，也不增多。

82. 寒冷性多形红斑

寒冷性多形红斑为冬季较常见的皮肤病之一，是寒冷病在皮肤上一种特殊表现。现代医学认为本病是由于寒冷刺激，使一些对冷敏感者产生异常的免疫球蛋白。寒冷又使它们在血管内凝聚、沉淀，损伤了皮肤血管，造成局部的栓塞、瘀血、皮疹。再加上寒冷本身引起的小血管痉挛、收缩，进一步加重了微循环和免疫功能障碍。

寒冷性多形红斑多发于寒冷季节，气温升高后可缓解。

皮损处遇冷有刺痛感，遇热有难忍之瘙痒及灼热感。发病部位以四肢末端的暴露部位为主，尤其多见于指、趾关节背侧，其它如指、趾屈侧，掌、跖及其侧缘等处亦可发生，多呈对称分布，患部皮肤温度明显低于正常人。患者常伴有手足受冻史及有在低温潮湿环境工作史。

寒冷性多形红斑的皮疹常成批出现，为水肿性斑丘疹，初起为鲜红色，以后丘疹中心逐渐转为暗红色或紫红色。丘疹约绿豆大小，可相互融合，严重时出现紫癜或水疱，疱破则形成糜烂面。

全身症状有恶寒发热，手足厥冷，口淡不渴，尿清便溏等阳虚寒重见证。

寒冷性多形红斑不同于“冻疮”。冻疮仅为局部病变，而寒冷性多形红斑则呈对称广泛地分布，是全身性疾病的皮肤表现。

寒冷性多形红斑属于祖国医学“血瘀证”范畴。祖国医学虽然没有寒冷性多形红斑的具体病名，但对寒邪致病的临床特征，却有着详细的观察记载。。如“寒独留则血凝结”，“血之凝结为瘀，必先见于气”，“寒为阴邪”，易伤阳气。“寒性收引凝滞”，常可导致寒凝血瘀，并可出现各种阳虚见证。本病是因血受寒凝所致。治宜温通散寒，活血化瘀，行气止痛。

方一：黄芪30克，党参30克，附片10—30克(先熬)，桂枝10克，当归10克，赤芍10克，丹参15克，陈皮10克。水煎服，每日一剂。

加减：寒证显著者加干姜10克、炙甘草10克；血瘀证显著者加桃仁10克、红花10克。

方二：川芎、红花、赤芍、桃仁、丹参、桂枝、制乳

香、制没药、生黄芪各等份，共研细末，水泛为丸，每次服10克，一天2次，2周为一疗程。

方三：制川乌10克(先熬)，当归12克，羌活10克，防己12克，川芎10克，生姜皮6克，桂枝10克，大枣12克，赤芍12克，葱管2根，甘草6克。水煎服。

方四：甘遂、甘草各10克，加水1500毫升煮沸10分钟后，对患部先熏后洗，熏15—20分钟，洗15—20分钟，每日一次，连续二周为一疗程。

83. 面部黄褐斑

黄褐斑是发生在面部的一种色素沉着性皮肤病。典型皮损呈蝶状，为淡褐色至咖啡色斑片，境界明显，日晒后加剧。好发于青年女性和孕妇。虽无自觉症状，但有碍美容，给患者心理上造成痛苦。

患者常伴有性情急躁，胸胁或乳房胀痛等症状，或内分泌失调或其他慢性病。

黄褐斑对称发生于脸面，尤以两颊、额部、鼻、唇及颈等处多见。

局部呈钱币大小或小儿手掌大的色素斑，呈黄褐色或暗褐色，境界明显或模糊不清。

现代医学认为黄褐斑的发病原因与性激素失调和卵巢机能不全有关。

黄褐斑属于祖国医学“面尘”、“肝斑”、“黎黑斑”等范畴。中医对此病记述较早，晋代葛洪《肘后备急方》称“肝黯”；隋代《诸病源候论》称“面黑肝”，唐代《千金方》称“面肝”、“肝黯”，《外台秘要》称“面肝黯”，《外科正宗》称“黎黑斑”，《外科论治全书》称为“面尘”，《医宗金鉴》称为“黎黑肝黯”。后

世医家也有其状如蝴蝶而称为“蝴蝶斑”，因多见于孕妇而称为“妊娠斑”，因伴有肝郁气滞而名为“肝斑”。

中医认为本病系由气血不和，肾阴不足，肾水不能上承，忧思抑郁，肝失条畅，痰湿内停，虚火上炎等皆可结滞于面上而酿成褐斑。《诸病源候论》说：“五脏六腑十二经血，皆上于面。夫血之行俱荣表里，人或痰饮渍脏，或腠理受风，致气血不和，或涩或浊，不能荣于皮肤，故发生黑黥”。五脏之中又与肝、脾、肾三脏关系更为密切。治宜疏肝滋肾，解郁散结，利湿祛痰，健脾和中。

方一：柴胡15克，白芍20克，当归15克，茯苓12克，川芎12克，丹皮12克，郁金12克，川楝子12克，龙胆草10克。水煎服。

本方适宜于肝气郁结，胁肋胀痛，胸脘痞闷、烦躁易怒、口苦之患者服用。

方二：桂枝12克，白术12克，茯苓15克，甘草10克，桃仁10克，法半夏10克，防己15克，泽泻15克。水煎服。

本方适宜于痰湿内停、呕吐清水痰涎、小便不利、头昏目眩之面部有黄褐斑患者服用。

方三：熟地15克，山药30克，女贞子30克，茯苓12克，丹皮12克，泽泻15克。水煎服。

加减：阴虚火旺者加知母、黄柏；遗精、盗汗者加金樱子、芡实；失眠多梦者加生龙骨、生牡蛎。

本方适宜于肾水不足、耳鸣腰酸、失眠健忘、遗精、女子不孕的面部黄褐斑患者服用。

方四：珍珠母30克，菊花10克，僵蚕10克，茵陈30克，夏枯草30克，茯苓6克，生地20克，女贞子20克，柴胡12克，炙甘草6克。水煎服，每日二剂，直至黄褐斑完全消退。

加减：脾胃不健、素有胃脘部不适者，去菊花，加炒白术12克；阴虚发热者加地骨皮12克；肝郁气滞明显者加玫瑰花3克。

本方适用于头目眩晕，血压偏高之面部黄褐斑患者。

方五：白芨5克，白芷5克，白附子5克，白蔹5克，密陀僧3克，共研细末，搅入白蜜内，睡前涂局部，一个月内斑痕可退。

84. 鱼鳞病

鱼鳞病是一种较常见的角化障碍性、先天性皮肤病。皮疹主要发于四肢伸侧，重者可波及全身。全身皮肤干燥粗糙，角化过度，有黄褐色或黑褐色鱼鳞状鳞屑，毛发稀少，且有痒感，全身皮疹发生龟裂样改变，状如鱼鳞，故称为鱼鳞病。此病每于冬季加重，夏季减轻，且有遗传现象，往往于幼年发病，持续终身，患者思想极为痛苦。现代医学认为本病与维生素A的代谢障碍有一定关系。

祖国医学称鱼鳞病为蛇皮癣、蛇身、蛇体、鱼鳞风、鱼鳞癣。《诸病源候论》云：“蛇身者，谓人皮肤上，如蛇皮而有鳞甲，世谓之蛇身也。此由血气痞涩，不通润于皮肤故也”。《中国医学大辞典》谓：“蛇皮风此症由于心肾二经受病。先发臂部之间，皮肤迸裂，形如蛇腹之纹，或痛或痒蔓延周身”。中医认为鱼鳞病虽病在皮肤，其本则属肺脾肾三脏。其病因病机乃由于肝肾阴虚，脾肺虚弱，营血不足，血虚生风，风盛则燥，皮肤失养，造成肌肤甲错。此外，本病与外界环境，风热、燥邪侵犯皮肤也有关系。治宜凉血祛

风，活血通络，清热解毒。

方一：生地30克，赤芍15克，丹皮12克，荆芥10克，防风10克，茅根10克，菊花10克，大青叶30克，板蓝根30克，乌梅10克，紫草10克，苦参10克，甘草6克。水煎服，每日一剂。

方中大青叶、板蓝根、茅根、紫草、苦参清热解毒；菊花疏风清热；荆芥、防风祛风解表；生地、丹皮、赤芍活血凉血，养阴生津。诸药配伍，共奏凉血祛风，清热解毒之功。对鱼鳞病有一定疗效。

方二：生地30克，熟地15克，黄芪30克，枸杞15克，白藓皮12克，当归12克，茅根30克，地肤子12克，蛇蜕6克，制首乌15克，赤芍12克，川芎10克。水煎服。

方三：黄芪30克，桂枝12克，红花10克，党参30克，当归12克，鸡血藤30克，防风10克，紫草15克，生地30克，蝉蜕3克，蛇床子10克。水煎服。

方四：黄芪60克，黑芝麻40克，丹参25克，地肤子25克，当归20克，生地20克，熟地20克，枸杞20克，何首乌20克，白藓皮20克，山药15克，防风15克，川芎10克，桂枝10克，蝉蜕10克，甘草10克。水煎服。

加减：心悸、健忘、失眠者加酸枣仁、合欢皮；纳差腹胀减生地、熟地，加白术、鸡内金；气短自汗加党参。

注：凡体质较强、食欲良好、无其他合并症状者，疗效满意。如合并有胃肠及神经症状者应首先治疗胃肠症状及神经症状，再治鱼鳞病，这样，效果才好。

方五：天冬15克，麦冬12克，生地15克，熟地15克，陈皮10克，党参30克，黄芪30克，当归15克，鸡血藤30克，红花10克，茯苓12克，丹参30克，赤芍10克，白芍12克。水煎服。

85. 皮肤划痕症

皮肤划痕症又称人工性荨麻疹。患者的皮肤对外界的机械性刺激非常敏感，皮肤上通常无风团，若用指甲或钝器划皮肤时，在受刺激部位很快出现条状隆起性划痕。外伤、衣服摩擦，束带、搔抓等均可引起风团和瘙痒。

皮肤划痕症是荨麻疹的一种临床类型，属于祖国医学“瘾疹”范畴。中医认为体虚卫表不固，复感风热风寒之邪，郁于皮毛肌腠之间而发病。治宜固表疏风。

方一：防风15克，麻黄10克，荆芥15克，薄荷15克，大黄10克，芒硝10克(冲服)，生石膏30克，黄芩15克，连翘15克，滑石15克，梔子15克，甘草10克。水煎服。

加减：兼气虚者加黄芪30克、党参30克；兼血虚者加当归10克、白芍10克；兼脾虚者加白术10克、茯苓10克；兼瘀血者加川芎10克、桃仁10克；兼痒甚者加蝉蜕6克、苦参10克；兼热甚者加黄连6克、黄柏15克；兼寒热错杂者加附片10克(先熬)、干姜6克。

用本方治疗后，痒消，划痕试验可转阴或转弱阳性(即用指甲划皮肤时，不会出现条状隆起的划痕，或者很轻微)。

方二：黄芪90克，桂枝10克，柴胡12克，白芍15克，白术15克，石苇30克，甘草12克。水煎服。

86. 剥脱性皮炎

剥脱性皮炎是药物性皮炎的一种。药物通过口服、注射等途径进入人体而引起的皮炎，称为药物性皮炎或药疹。

药疹是一种典型的过敏性或变态反应性皮肤病。而在皮肤病中，变应性是一个很重要的因素。

患者的过敏必须在活动期才会发病，一个人的变应性在不活动期，使用某种药物也可很久不发病，而到活动期时突然发病。反之，亦有发几次后产生免疫，再用药而不再发生药疹。

引起药疹的药物必须具有抗原性。有些药物，如磺胺、抗生素、安眠药、退热镇痛药等，抗原性强，引起的药疹亦较多；抗原性弱的药物如铋制剂等，引起的药疹就很少。

一个人只对某一种药或某一些药过敏，而不是对所有的药过敏。

发生药疹的人，在第一次用药后，一般要经过4—10日，平均七、八天的潜伏期，使抗原性药物在他体内引起抗体的产生，再用药后，就发生抗原抗体反应，而出现药疹。如过去已用过药，重用后可在几分钟至24小时内，一般在10小时左右发病。

由于药物种类很多，各人体质的特异性又不一样，同一种药在不同人身上或在同一个人身上的不同时期，可产生不同形态的药疹。反之，不同药物又可在同一个人或不同人身上产生同形的药疹。

剥脱性皮炎就是药疹中严重的一种。

剥脱性皮炎潜伏期长(20天以上)，病程长(1—3个月不等)，病情严重。起病缓慢或突然。病程中常有不定时畏寒、发热。并发生皮肤显著水肿，特别是面部，常有渗液结痂。患者有2—3个星期左右的典型剥脱阶段。此时皮肤大片脱落，重的两手如戴破手套，两足如穿破袜子一样。甚至体无完肤。

剥脱性皮炎系全身反应性病变，其临床表现属于中医的

热毒斑疹范畴。由于热毒极盛，气血两燔，故见症多端而急重。

一、血热受风型：皮肤先见大片发红，迅速延及全身，出现大片鳞屑，灼热瘙痒，寒战高热，口燥咽干，心烦，头昏，谵语，便秘尿赤，舌绛苔黄。治宜凉血清热，散风解毒。

方药：生地30克，生石膏30克，银花30克，土茯苓30克，丹皮12克，赤芍12克，防风12克，知母10克，甘草10克。水煎服。

二、湿热蕴毒型：皮肤见片状红斑，迅速延及全身，鳞屑脱落，滋水渗出，基底潮红湿润，鳞屑黄腻，剧痒，或恶寒壮热，烦渴不欲饮，呕恶纳呆，舌红苔黄。治宜清热燥湿解毒，祛风止痒。

方药：银花30克，土茯苓30克，紫花地丁30克，川牛膝15克，苦参30克，白藓皮15克，车前子10克，防风10克，甘草10克。水煎服。

三、血虚风燥型：鳞屑脱落，两手如戴破手套，两脚如穿破袜子，自觉瘙痒，周身乏力，心悸气短。治宜养血祛风，润燥止痒。

方药：生地30克，熟地15克，防风15克，丹参30克，桃仁12克，红花12克，甘草10克，当归15克，白芍15克。水煎服。

以上三型，均可外用药膏涂敷。

外用方药：紫草60克，黄连30克，黄柏25克，均研细末，用麻油500毫升调敷患处。

以上三型，还可用下列基本方内服治疗。

基本方：生石膏60克，芒硝15克(冲服)，生地30克，黄连10

克，梔子15克，桔梗10克，黄芩15克，知母10克，赤芍10克，玄参15克，丹皮10克，竹叶10克，连翘15克，甘草10克。水煎服，每日一剂，连服10—30剂，再根据病情用养阴益气药调理。

87. 剥脱性唇炎

剥脱性唇炎系唇部粘膜(唇红缘)的一种慢性表浅性脱屑性炎症，病程迁延。患者上唇或下唇干裂、溃烂、脱皮，可反复发作。自感灼痛，病久则溃疡面上有脓液渗出，表面有多量痂皮和鳞屑，层层脱落，脱屑后裸露淡红发亮的基底，患者颇感痛苦。

剥脱性唇炎的病因至今不明。

剥脱性唇炎属于祖国医学“唇风”、“紧唇”等范畴。中医认为本病多由脾胃湿热内蕴，郁久化火，火邪熏蒸肌肤，伤阴化燥所致。治宜滋阴养胃，健脾和胃，除湿清热。

方一：白术15克，茯苓15克，山药30克，草薢10克，苡仁30克，生扁豆30克，枳壳10克，萆薢10克，黄柏15克，芡实15克，桂枝10克，花粉10克。水煎服。每日一剂，一般连服15天。

加减：口干渴者加沙参30克，石斛15克，生地30克。

方中白术、茯苓、山药健脾益气；草薢健脾燥湿；生苡仁、生扁豆、萆薢清脾除湿；枳壳醒脾和胃；黄柏清热燥湿。配用芡实坚肾固脾。湿为阴邪，缠绵难愈，用桂枝辛而散之，温而化之。胃恶燥，胃有热则津液亏少，加用花粉、石斛、沙参、生地以滋润生津，口渴自除。诸药合用，使脾气健而湿热除，唇炎自愈。

方二：生地15克，山药15克，女贞子15克，玉竹15克，栀子12克，丹皮12克，黄芩10克，麦冬10克，莲子心10克。水煎服。每日一剂。

方三(外敷方)：木蝴蝶，每次一张，用开水浸湿后贴于患部，每四小时换一次。

方四：蛋黄油外涂。蛋黄油制法：将鸡蛋带壳煮熟，取出蛋黄，放铁锅中熬焦出油，此即蛋黄油。

88. 植物日光性皮炎

植物日光性皮炎又称蔬菜日光性皮炎，系食用或接触光感性植物(包括蔬菜)后，再经日光曝晒，出现浮肿、瘀斑等皮肤损害的一种疾病。

本病多发于春末夏初，当患者接触或食用某些植物或蔬菜，经日光照射后即可引起皮炎。这些植物或蔬菜包括：灰菜、苋菜、洋槐叶、槐花、刺儿菜、紫云英、榆树叶、柳叶、青青菜、马齿苋、杨树叶、棠梨叶、麦蒿、油菜等。这些植物或蔬菜含有卟啉类光感性物质，当某些人接触这些植物或食用这些蔬菜后，体内一时不能将卟啉类光感性物质转化或排泄，存在于组织内，增加光感作用，再经日光照射，即可发生皮疹。但不是所有人都会发病，与个体易感性有关。本病多见于青壮年女性，有内脏疾患者易发病，年老体弱者发病时症状较严重。

症状：多在进食这些蔬菜后1—3天发病，于脸部、手背、前臂等暴露部位，对称出现非压陷性浮肿，紧张发亮，自觉麻痛、灼痒痛、刺痛或胀痛。严重时皮肤可发生瘀斑、水疱、血疱甚至坏死。头面部肿胀，两眼裂成缝，不能睁开，

口唇厚而外翻，口水外流。个别患者咽部水肿以致语言不清，嚼物不灵，甚至呼吸困难。

部分患者体温上升，全身症状不明显。

植物日光性皮炎类似中医的“红花草疮”。中医认为本病多由禀赋不耐，食用某些蔬菜，复受酷日曝晒，致使脾不运化，湿热内生，郁于肌肤，或因气虚，腠理不固而致本病。治宜益气助阳，化瘀通络。

方药：黄芪60克，桃仁15克，红花10克，皂刺30克，赤芍20克，炒山甲10克。水煎服。每日一剂。药渣再煎一次，冷后洗患处。

加减：伴发热者加生石膏60克，知母20克；伴抓破流水者加焦苍术30克，车前草50克；伴烦躁便秘者加生大黄10克。

本方用“补气破血之剂，通开血道，气直达于皮肤，未有一药而痒即止者”（王清任《医林改错》）。

89. 隐翅虫皮炎

隐翅虫皮炎是隐翅虫叮咬人时，当人挥打将虫体击伤，毒液沾染皮肤所引起的急性皮炎。隐翅虫比蚊子还小，是一种甲虫，在夏秋季节，常栖息于草木或石下，8—9月间活动最甚，入夜有趋光性，常于夜间叮咬人。虫体内有一种强酸性毒液，当人拍击损碎了虫体或压碎虫体，毒液沾染皮肤，即可引起皮炎，疼痛剧烈。为夏季常见病之一。病程1—2周不等。

隐翅虫皮炎的症状：夏日乘凉后发现脸面、颈部、胸背。四肢出现条索状、片状、斑块状、点状水肿性红斑，皮损色鲜红，呈条状或不规则排列小脓疱，极似皮肤被竹签刮

伤后继发感染所致的形态。点状红斑约如绿豆或比绿豆稍大的鲜红色丘疹及斑块。表面亦可有小脓疱，孤立散在或数个排列成条状或簇集成群。片状损害以阴囊部多见，边缘界限不清。

隐翅虫皮炎常伴有头痛、头昏及发热等全身症状，严重者患部淋巴结可肿大。

用中药熬水外洗治疗隐翅虫皮炎有较好的疗效。

方一：苦参30克，连翘15克，野菊花15克，地肤子30克，紫背天葵15克，蛇床子15克，白藓皮15克，蒲公英30克，甘草30克。熬水外洗患处，或用纱布蘸药液湿敷患处，每日3—4次。

方二：季德胜蛇药片（每片0.3克）用10毫升冷开水，放6—8片药片，调糊状涂患处，半小时涂一次。

蛇药片有解毒、止痛、消炎之功，可迅速控制疾病的发展，简便验廉，不失为良方。

90. 稻田皮炎

稻田皮炎又称“秧癩子”、“臭水疙瘩”、“水苕疙瘩”、“痒水病”、“鸭母涎”、“鸭怪”等，是由于参加稻田劳动引起的一种皮肤病。

稻田皮炎可分为尾蚴皮炎和浸渍性皮炎两种。

一、尾蚴皮炎：多发生在插秧时，有明显的季节性。是由于家畜（牛、羊）、家禽（鸭）类血吸虫尾蚴侵入皮肤引起。农民在含有尾蚴的水田中劳动，尾蚴就可钻入人的皮肤，引起尾蚴皮炎。禽畜粪未经无害化处理，就用来施肥或直接排入水中，人接触这种田水就可能发病。气温、水温越高，发病率也随之增高。

尾蚴皮炎的症状：下田半小时左右，四肢接触水的部分（小腿、前臂、手背等处）发生灼热、瘙痒、疼痛，夜间瘙痒更剧烈，烦躁不安，影响休息和睡眠。患部皮肤出现针头到绿豆大的红斑点，搔抓后成红色丘疹，稍高于皮肤，压时褪色，排列不规则；继而可变为水泡，有少许黄色渗出液。搔抓后出现糜烂、结痂；如果感染，水泡变为脓疱，可有低烧，全身不适，或引起腹股沟、腋窝淋巴结炎或局部淋巴管炎。脓疱破溃后，患部又痛又痒，愈后残留暂时性色素沉着。

发病部位主要在接触水面的皮肤，脚趾间和陷于稀泥内的皮肤则不发生。

二、浸渍性皮炎：浸渍性皮炎俗称“烂手烂脚”，多发生于5—8月份，在拔秧、插秧的过程中，皮肤长时间的浸水，再经操作中的摩擦而引起指、趾间的擦破、糜烂。

浸渍性皮炎的症状：开始时指（趾）间皮肤发白、起皱，以后继续下水和摩擦，起皱的皮肤被擦破，露出红色基底，有少许渗液。病变处常有疼痛。剧烈疼痛时影响劳动和睡眠。当停止下水后，症状可在2—7天内消失。如继发感染，局部可以红肿、化脓，甚而引起淋巴管炎以及全身发热等症状。

稻田皮炎属于中医“水渍疮”范畴。中医认为系因久浸水浆、湿淫内侵、阻郁皮肤所致。

中药治疗以外用为主。

方一：白矾35克，雄黄25克，滑石粉30克，密陀僧10克，研成细末，置于纱布包中备用。于上工前及下工后、睡前外敷于手足部位。

方二：明矾13克，食盐38克，加入热水100毫升中，待溶解后放凉备用。于上工前及下工后涂擦手足部位。

方三：密陀僧研成细末，用植物油调涂手足部位，每晚

涂一次。

方四：大蒜60克捣成糊状，雄黄20克，加温开水1000毫升稀释后，搅匀外搽。

方五：石榴皮，地榆、蛇床子，蒲公英各30克，煎水外洗患处。

方六：韭菜、马齿苋、野薄荷，捣泥外擦。

方七：牛蒡子叶煎汤洗患处。

方八：黄柏、苦参、地肤子，明矾各10克，艾叶3克，煎水浸泡患部。

91. 急性会厌炎

急性会厌炎是咽喉急性炎症。突然出现咽喉疼痛，灼热干燥，吞咽时疼痛更甚，呼吸急促，咽喉有阻塞感。并发高热（39℃以上），清涕，咳嗽等症。严重时汤水难入，语言含糊，音哑，咽喉焮红肿胀充血，会厌充血水肿，气道口明显狭窄。或伴有颌下淋巴结肿大触痛，便秘等症状。

急性会厌炎属于祖国医学“紧喉风”、“急喉风”、“锁喉”、“喉痹”等范畴。病势急骤。多因劳累、体虚或嗜酒过度，胃火炽盛，痰涎火毒积聚，煎熬津液为痰，上攻气道，以致咽喉焮红阻塞，水浆难下，呼吸窘迫。《医学心悟》曰：“醇酒膏粱，风火炽热，火动生痰，肿痛暴发，甚至风痰壅结，汤水不入，声音不出，此外至之火，名曰紧喉风”。

急性会厌炎治宜清泄透解肺胃郁热，散邪利咽，祛痰开窍。

方一：生石膏30克，知母10克，黄芩10克，黄连10克，连翘10克，丹皮10克，赤芍10克，大青叶10克，天竺黄12克，竹茹12克，甘草6克。水煎服，日一剂。此系成人剂量，小孩酌减。

方二：生大黄15克（后下），玄明粉10克（另冲），山栀15克，银花15克，薄荷10克，蝉蜕6克，桔梗12克，杏仁10克，茵陈30克，滑石30克，甘草10克，玄参30克。水煎服。小儿剂量酌减。

注：如患者便秘，服药后一泻症减。如患者无便秘症状，服药后可有轻泻，不需处理。泻则症减。

92. 声带息肉

声带息肉是常见的喉部疾病，息肉小者如米粒，大者如黄豆，质柔软。可通过咽喉镜检查确诊。症状有声音嘶哑，咽痛，讲话费力，咳嗽痰多等。

声带息肉属于祖国医学“喉暗”范畴。系肾阴亏虚，肺火内盛，导致肺阴暗耗，气道燥涩，金失养而成。治宜益气养阴，清热散结。

方一：天名精10克，石龙芮10克，龙葵10克，龙须草10克，白英10克。水煎服。

加减：气虚者加党参、黄芪；脾阳虚者加制附片、干姜；肾阴虚者加枸杞、生地、熟地；气阴两虚者加山药、党参、枸杞；痰热内阻者加黄连、半夏、全瓜蒌。

方中天名精“主瘀血，主痹，利小便，除胸中结热，散血，治乳蛾喉咙肿痛，咽喉肿塞”。龙葵“主清热散血，压丹石毒，去虚热肿”。白英除湿祛风，凉血解毒。三药同用，清热散结，疗咽喉肿塞。石龙芮补阴润燥，逐诸风，下瘀血，消结核。龙须草主瘀结热气，利小便，补内虚不足。全方共奏养阴清热散结之功。

方二：桂枝、茯苓、丹皮、桃仁各等分研末，制成蜜丸，每次服10克，每日3次，空腹吞服。连服半月至一月。本方有活血祛痰、消散症块之功。桂枝通血脉，消瘀血，丹皮、桃仁破血祛瘀，消症散结。症块之成，大多由于血瘀，痰湿阻滞。茯苓祛痰利水，使水去痰行，共奏祛痰消症之效。日人浅田宗伯认为“此方主瘀血所致之症瘕（血栓血块等），凡因瘀血所生之诸疾皆可活用之”。今人以桂枝茯苓丸主治宫颈

息肉，子宫肌瘤，卵巢囊肿等，皆获良效。

方三：乌梅150克，去核焙焦存性，僵蚕50克（米拌炒微黄），人指甲15克（用皂水洗净，晒干，再和滑石粉入锅内同炒至指甲黄色鼓起为度，取出筛去滑石粉，放凉，碾粉用），象牙屑30克。上药共研细末，炼蜜为丸，每丸重10克。每次服1丸，一日三次。

93. 声带结节

声带结节多见于演员、教师、营业员等。声带结节发生的部位多在声带的前三分之一与中三分之一的交界处，呈灰白色或红色大小不等粟米状或绿豆状组织增生（对称性，质较硬）。患者自觉咽喉干痛，说话声音嘶哑。

本病多由过度使用声带所致。抽烟、喝酒、上呼吸道感染、急性创伤（如大声喊叫等），均可诱发本病。

声带结节可经五官科检查确诊。

中医认为，肺主气，其脉从气管上行通于会厌、声带，患者因职业关系，高声歌唱，或高声讲话，耗伤肺阴而生热，热邪上蒸于咽喉，故干痛；热蒸于会厌，故声带充血，气血凝滞则成结节，因声带充血而影响开合，故声音嘶哑，治宜养阴清热，活血软坚。

方一：昆布30克，海藻30克，海浮石30克，海蛤壳15克，桔梗10克。水煎服。

加减：咽痛音哑较重者加薄荷、蝉衣、射干。

方二：桃仁10克，红花10克，当归10克，白芍10克，桔梗15克，甘草12克，生地12克，玄参12克，沙参15克，麦冬15克，石斛12克，通大海6克，蝉蜕6克。水煎服。

注：本方治上呼吸道感染引起之失音、扁桃腺炎等均有良效。

方三：海螵蛸15克，山慈菇15克，陈皮10克，白芥子12克，海藻30克。水煎服。

94. 鼻 出 血

鼻出血是一种症状。鼻腔的血管丰富而表浅，当鼻外伤、挖鼻、用力擤鼻涕时使鼻粘膜及鼻窦的血管扩张、充血，或粘膜糜烂引起出血。鼻粘膜干燥、鼻部肿瘤或异物等均可导致鼻出血。除此之外，某些全身性疾病也可引起鼻出血，如心脏病、高血压、动脉硬化、血小板减少性紫癜、再生障碍性贫血、血友病、白血病、维生素K缺乏、流感、麻疹、传染性肝炎、小儿高热、妇女月经不调、代偿性月经（“倒经”）等，均可引起鼻出血。严重者血出如涌，血色鲜红。

中医认为鼻出血（鼻衄）可分①肝火上升，灼伤鼻窍；②胃火亢盛，熏灼阳络；③阴虚火旺，迫血上溢三类。其共性乃火升血溢。张景岳说：“……动血之由，惟火与气耳。”因此，中医治疗鼻出血，多以滋阴清火、祛瘀止血为法。

方一：生石膏60克，茅根60克，知母15克，麦冬15克，生地30克，淮牛膝12克，藕节12克，侧柏叶12克，茜草根12克，生大黄10克。水煎服。

本方寓清火于滋阴之中，加大黄祛瘀止血，血止而不留瘀。对长期鼻衄患者，能起祛瘀生新，导血循经的作用。

方二：生地30克，阿胶10克，蒲黄15克。（阿胶用火烊化后加入蒲黄，待冒青烟即可）煎水分服。

方三：酸枣仁20克(先煎)，知母12克，龟板胶10克，川芎10克，茯苓10克，五味子10克，炙甘草6克。水煎服。

方四：本人头发一撮，用火烧焦研细，让患者从鼻孔吸入。

95. 鼻 息 肉

鼻息肉是鼻腔的赘生物，系鼻腔或鼻窦粘膜的变应性疾病，或慢性炎症长期刺激的结果。

鼻息肉的自觉症状：鼻塞不通，不闻香臭，常流腥臭脓涕。检查可见鼻腔顶部悬挂葡萄样赘生物，表面光滑，呈淡红色，触之柔软。可经五官科检查确诊。

中医认为鼻息肉的病因系肺失清肃，脾经湿浊熏蒸鼻窍，凝聚日久而成。治宜祛痰消肿，芳香通窍。

方一：陈皮12克，法夏12克，茯苓12克，莱菔子12克，枳壳12克，白芷12克，辛夷12克，车前子12克，菖蒲6克。水煎服。同时外用石榴皮12克，苍术12克，白术12克，煎水熏鼻。

方二：紫花地丁30克，蒲公英30克，白果20克，桔梗10克，知母10克，苍耳子10克，薄荷10克，辛夷10克，甘草10克，白芷10克，黄芩10克，赤芍10克，生姜10克。水煎服。

方三：苍术20克，白芷20克，乌梅15克，五味子15克。

用法：蒸气吸入法。先用厚纸做成一个漏斗样物，然后将上药煎煮，煮沸后将纸漏斗的大口罩在煎药器的上口，漏斗小口靠近鼻孔部，闭口用鼻呼吸，使蒸气从鼻腔吸入，每次熏半小时，每日熏1—2次，连续熏1—2个月。

注意：药液过热时距鼻远些，以免烫伤，蒸气不大时距

鼻近些，或加温后再用。

患者每熏用此方后，自觉鼻腔舒适，通气改善。但须坚持熏30余剂方能收效。每次熏的时间要长一些。对较大的鼻息肉，疗效较差。

96. 牙 周 病

牙周病是发生在牙齿周围支持组织（如牙龈、牙周膜、牙槽骨、牙骨质）的一种慢性疾病。临床特征：

1. 牙龈流脓：牙龈松软，红肿疼痛，充血，牙周袋流脓。
2. 牙齿松动：多数牙齿明显松动并发生移位，咀嚼力差。
3. 牙槽骨吸收：X线照片可见牙槽骨有不同程度的吸收。

牙周病的病因至今尚未阐明。一般认为牙龈的慢性炎症、营养障碍、内分泌紊乱、糖尿病、植物神经功能失调、关节炎、高血压等疾病，均可诱发牙周病。

牙周病可分为局限性和弥漫性两种。局限性牙周病是发生于个别牙齿，两牙之间因食物嵌塞而发生慢性龈炎，逐渐形成牙周袋及牙槽骨吸收而发展成牙周病。这种牙周病，去除局部刺激因素即能取得较好疗效。弥漫性牙周病发生于全口牙齿或多数牙齿，常有全身因素或其他全身症状。

牙周病属于祖国医学“牙宣”、“牙疳”等范畴。祖国医学书籍虽无牙周病的病名，但不乏此病症状的描述，并认为其病因多与肾虚有关。《外科大成》云：“肾经虚者，则血点滴而出，齿亦悠悠然而痛，口不臭，而齿动而齿落。”《景岳全

书》云：“肾衰则齿豁，精固则齿坚。”中医认为，牙周病的病因是多方面的，但首当责之于肾虚。

中医还认为，牙周病常因饮食不节，嗜食膏粱厚味，或外感风邪，运化失调，脾胃中蕴郁化热，上熏口齿，循阳明胃经及大肠经脉而入牙龈，故出现牙龈红肿疼痛，易出血，牙周溢脓等一系列症状。

牙周病治宜滋肾固本，健脾清胃，辅以平肝。

方一：生石膏30克，生熟地各15克，知母10克，麦冬10克，牛膝10克，黄芩10克，丹皮10克，升麻10克。水煎服。另服二至丸10克。本方适用于肾阴不足、胃火炽盛牙龈胀痛腐臭之牙周病患者。服用本方待症状减轻后再服六味地黄丸巩固疗效。

方二：生地30克，金樱子30克，山药30克，泽泻10克，丹皮10克，知母10克，黄柏10克，淮牛膝30克，白菊花10克，生石决明30克。水煎服。另服二至丸10克(分吞)。本方适用于肝阳上亢(高血压)之牙周病患者。服用本方后症状减轻时再服杞菊地黄丸以巩固疗效。

方三：党参30克，白术12克，茯苓12克，山药15克，陈皮10克，黄芪30克，生地15克，熟地15克，淮牛膝15克，旱莲草15克，仙鹤草30克，蒲公英30克。水煎服。本方适用于纳差、腰酸之脾肾两虚的牙周病患者。服用本方后症状减轻时再服六味地黄丸、四君子丸以巩固疗效。

方四：黄连6克，竹叶6克，生地30克，连翘15克，丹皮10克，升麻10克，大黄10克，当归10克，生石膏30克。水煎服。本方适用于大便秘结、口臭之牙周病患者。

方五：骨碎补5克(一日量)，泡开水当茶饮，长期服用。

牙周病的保健方法：

1.每次饭后，要刷牙。在刷牙之前，把洗净的食指和拇指伸进口腔，捏住牙龈朝上的方向挤压，把积存在牙周袋中的残留食物和脓汁挤压出来。

2.用小牙刷，顺牙齿上下的方向刷牙（不要左右刷）。

3.用盐开水漱口。

4.经过上述三道保健工序后，再用食指、拇指轻轻按摩牙龈，从上到下或从下到上一个一个地按摩。按摩可改善病变组织的血液循环，有利于炎症的迅速吸收。

5.再作上下叩牙10—15次，以运动牙根部。

牙周病的预防：

加强口腔卫生，每次饭后即刷牙，而且要做到上下刷，里外刷，前后刷，牙沟缝都要刷净。定期作口腔保健检查，争取早期发现牙周病，作早期治疗。

97. 下颌关节功能紊乱症

下颌关节功能紊乱症是一个包括关节本身及其周围肌群的综合征，是口腔科常见疾病。其发病原因尚未明确。

下颌关节功能紊乱症的主要症状为下颌关节区不适，疼痛，张口酸痛、受限，症状加重后，则发生关节区的弹响声。弹响与疼痛成反比，即疼痛明显时，没有弹响声。而弹响声大时，则疼痛减轻或消失。由于张口障碍，不能咀嚼较硬的食物。以上这些症状时好时坏，严重时并可有反射痛，影响患者的正常生活。

本症的发病可能与下列因素有关：情绪焦虑，精神紧张，神经衰弱，或关节发育不对称，单侧咀嚼，进餐时用力

过猛，突然咬碎坚硬的食物，张口过大过久，夜间入睡磨牙。或遭受意外损伤，寒冷侵袭，致使咀嚼肌痉挛，关节韧带扭伤，关节囊和关节盘各附着组织松弛，髁状突和关节凹之间的正常结构紊乱。

下颌关节功能紊乱症属中医痹证范畴。中医认为该关节周围筋脉受外邪侵袭，脉络阻滞，开合失司，关节不利，以致“不通则痛”。治宜祛风散寒，除湿通络。

方一：当归20克，独活12克，羌活12克，秦艽15克，生地10克，防风12克，川芎12克，白芍30克，桑寄生30克，葛根15克。水煎服。本方适用于虚寒痹痛的下颌关节功能紊乱症患者。

方二：玄参30克，葛根30克，麦冬30克，当归12克，银花12克，山豆根6克，海桐皮6克，甘草10克。水煎服。本方适用于阴虚火旺的下颌关节功能紊乱症患者。

方三：蒲公英30克，银花15克，野菊花12克，紫花地丁20克，桑枝15克，白芷12克，藁本15克，葛根30克。水煎服。本方适用于风热痹痛的下颌关节功能紊乱症的患者。

方四：桃仁10克，红花10克，当归10克，没药10克，秦艽12克，蒲公英30克，羌活10克。水煎服。本方适用于血瘀痹痛的下颌关节功能紊乱症的患者。

推拿疗法

方法1. 患者仰卧，医生以两手拇指、食指掌侧分置两侧上关、下关穴位处，施以指按法，再以拇指掌侧分置上关处，自上关向上推动至头维穴后，再向下推动至颊车穴止，反复操作1—3分钟。

向上或向下推动时，两侧用力应均匀而缓慢。治疗时患者有酸胀感，治疗后局部有温热感及舒适感。

方法2. 患者仰卧，医生以两手拇指掌侧置于两耳下方听会穴处，沿下颌外缘经颊车至大迎穴推动3—5次后，在颊车穴按揉2—3分钟。在推动时，手法宜轻柔，按揉时用力应稍重。治疗时有酸胀麻感，治疗后有面部与下颌温热及轻松感。

98. 口腔扁平苔癣

口腔扁平苔癣是皮肤和口腔粘膜的一种非感染性疾患。口腔损害可侵害颊、舌、唇、龈及腭部。口腔粘膜与皮肤也可同时发病。口腔粘膜病变比皮肤病变更为顽固，特点是在口腔粘膜上出现角化的白色线网状条纹，条纹周围充血发红，并可出现糜烂、溃疡。本病病程长，易复发。病因至今不明。

口腔扁平苔癣属祖国医学阴虚内热、脾虚湿热范畴。中医认为，口腔为心、脾之外窍，又为经络循行交会之处，每一经脉又归属不同脏腑，故口腔疾病与全身脏腑、经络有关。口腔扁平苔癣因脾胃不运，湿热内蕴，肾阴不足，虚火上炎所致。治宜清热祛湿，健脾养阴。

一、阴虚内热：症见低热，手足心热，耳鸣眼花，记忆力减退，心烦，口干咽燥，大便干燥，舌红苔黄。病损多成网状、斑块及花纹，偶有糜烂或轻度充血。

方药：山慈菇15克，地骨皮15克，生地15克，野菊花15克，茯苓15克，山药15克，升麻10克，砂仁3克，水煎服。

二、脾虚湿热：症见身倦体沉，纳差呕恶，胃脘胀满，大便不爽，渴不欲饮，口水多而稀，舌淡胖，苔白腻。口腔损害以糜烂为主，怕吃刺激性食物，有分泌物，重者可有

血样渗出液。

方药：土茯苓15克，神曲15克，鱼腥草15克，连翘15克，陈皮10克，半夏10克，炒白术10克，泽泻10克，升麻10克。水煎服。

加减：分泌物增多，糜烂面较大者加蚤休30克，生石膏30克，苡仁30克，杏仁10克，砂仁3克。

此外，青蒿治疗口腔扁平苔癣有效。可将青蒿研细，加等量炼蜜为丸，每丸9克，每日服4—6丸，连服1—3个月。

青蒿醚（成药）每片25毫克，每日服100毫克，对口腔扁平苔癣普通型及糜烂型均有一定疗效。

青蒿毒性低，在体内吸收快，分布广，排泄快，代谢迅速，每日服青蒿丸6丸，不会发生副作用。

99. 干槽症

干槽症是口腔科常见病症之一，多于拔牙后2—3天内出现疼痛。疼痛均剧烈向下颌或耳颞部放射。可见拔牙窝内充满腐败污物或拔牙窝空虚而骨面暴露，牙槽壁触痛，对冷热敏感，龈缘轻度红肿，邻牙常有叩痛。患者常伴有自汗、倦怠无力，语言低微，四肢微冷，腹胀痛喜按，食欲不振，大便溏泻或干燥，唇淡面白，心烦不寐，舌淡苔白，脉沉细。

干槽症是现代医学病名。中医认为本病病因多为平素气血虚弱，加之拔牙时间过长，耗伤气血，以致创面不能收敛。治宜补益气血，使创面得到滋养，加速愈合。

方药：黄芪30克，党参30克，白术12克，茯苓15克，熟地15克，阿胶12克，白芍12克，当归12克，鸡血藤30克，柴胡10克，炙甘草6克。水煎服。

加减：大便溏泻者去当归，加干姜6克，小茴香6克，补骨脂10克；头闷胸满，脾胃湿热，舌苔黄厚腻者去黄芪、党参、熟地，加滑石、苡仁各30克，藿香12克；胁痛者加香附、郁金各10克。

100. 复发性口腔溃疡

复发性口腔溃疡，是一种常见的口腔粘膜疾病，其病因和发病规律尚未完全明确。但多数学者认为与神经紧张，内分泌障碍，胃肠功能紊乱，维生素缺乏，变态反应，病毒，局部刺激等因素有关。

复发性口腔溃疡属于祖国医学“口疮”、“口疳”范畴。中医认为本病的发生，外因以热毒、火毒为主；内因多为情志内伤，饮食不节，房室劳倦所致。《景岳全书》认为“口疮连年不愈者，此虚火也”。《寿世保元》中也有“口疮白，脾脏冷”的记载。

本病根据口腔粘膜病变部位，以及其他临床表现，一般可分为以下几型：

（一）外感时毒型：粘膜溃疡多发于外感后1—2天，伴有外感症候。初起口腔粘膜局部充血、红肿、微痛，舌尖或唇内出现粟粒样小红点或小疱疹，12小时内疱疹溃破，溃疡呈圆形，表浅，周界清楚，充血，微痛。

方药：藿香12克，木香10克，佩兰10克，茯苓12克，神曲12克，枳壳12克，葛根15克，白术10克，代赭石20克，旋覆花10克。水煎服。

耳针穴位：神门、口、舌、交感穴。

（二）肝火型：粘膜溃疡以舌尖舌缘为多见，多者3、4

处，色红赤，呈圆形或椭圆形，略凹陷，周围明显充血，烧灼痛，常伴有头痛眩晕，口苦咽干，烦躁易怒，胁痛，失眠多梦，便秘尿赤等证。

方药：柴胡12克，龙胆草10克，生地30克，当归10克，神曲15克，白术12克，泽泻15克，水煎服。

耳针穴位：神门、口、舌、心、肝、小肠穴。

（三）肝郁脾虚型：粘膜溃疡以唇、舌缘和口腔底部为多见。充血轻，色淡红，数量多达4、5处。溃疡面积大，呈圆形或椭圆形，周围明显水肿，疼痛，接触食物痛甚。纳差，胸胁胀满痛，大便不调等证。

方药：茯苓15克，连翘15克，神曲15克，白术12克，泽泻12克，升麻10克，陈皮10克，柴胡10克。水煎服。

耳针穴位：神门、口、舌、肝、脾、胃、大肠穴。

（四）心肾阴虚型：粘膜溃疡以舌、唇、颊和齿龈等部位多见。色鲜红，数量多为3、5处，形状不一，大小不等，周界清楚，溃疡面较深且凹陷，表面有灰黄色纤维膜复盖，灼痛，心悸心烦，失眠多梦，健忘，眩晕耳鸣，腰膝酸痛，咽干口燥，男子遗精，女子经少或崩漏。

方药：生地30克，地骨皮15克，野菊花15克，连翘12克，山药15克，砂仁3克，升麻10克，寄生30克。水煎服。

耳针穴位：神门、口、舌、心、肾、交感、肾上腺。妇女可选加内分泌、卵巢、子宫等穴。

（五）脾胃虚寒型：溃疡色白，周围不红肿，数量少，时发时愈，舌淡苔白腻，四肢不温，大便稀溏，脉沉弱。

方药：党参30克，干姜10克，白术12克，茯苓15克，水煎服。

加减：溃疡久不愈合者加苍术、黄芪，便溏者加白扁

豆、炒山药，肢冷腹痛者加制附片。

耳针穴位：口、舌、心、脾、胃。

(六) 中气不足型：疡面周围不红肿或微红肿，数量少，时轻时重，每遇劳倦而加重。伴气短神疲，舌淡苔白，脉弱。

方药：黄芪30克，升麻6克，柴胡6克，当归10克，白术10克，石斛10克，玄参15克，肉桂6克，陈皮10克，党参30克。水煎服。

加减：疡面发红者加栀子、丹皮；疡面不红者加茯苓。

耳针穴位：神门、交感、心、口、舌。

(七) 肾阳虚型：疡面色白，周围不红，数量少，久治不愈，苔白腻，腰脊酸痛，大便溏，小便清长，下肢不温，脉沉弱。

方药：制附片30克（先熬），肉桂3克，熟地20克，山萸12克，山药30克，丹皮10克，茯苓12克，泽泻10克。水煎服。

加减：溃疡久不愈合者加苍术、石菖蒲；浮阳上越者附片减至10克。

耳针穴位：神门、肾、口、舌。

除了以上辨证分型治疗外，下列方药可供选用：

方一：淮山药20克，冰糖30克，共置容器内加适量温水，武火煮沸后，再用文火煮半小时，煎好倒出药液后，照上法加水重煎一次，两次药液混匀后，分两次服完（此为一日量）。

方二：黄芪30克，制附片10克（先煎30分钟），白术10克，苡仁30克，土茯苓30克，甘草10克。水煎服。本方适用于阳气虚弱，口疮日久不愈的患者。

加減：舌苔黃膩者去附片、白朮，加黃柏、蒼朮；舌質紅、苔少者去附片、白朮，加生地、麥冬。

治療期間忌烟酒及辛辣食物。

方三：茵陳蒿30克，泡開水250毫升，病輕者每日漱口數次，重者代茶飲。

方四：淡竹葉12克，生石膏30克，生大黃10克。水煎服。

加減：兼風熱者加銀花、連翹、板藍根；兼濕熱者加苡仁、茵陳；熱甚傷津者加生地、石斛、玄參、芦根、麥冬。

方五：柴胡15克，當歸20克，白芍20克，生地15克，淡竹葉10克，茯苓12克，丹皮10克，梔子10克。水煎服。本方用于月經性口瘡（即復發性口腔潰瘍伴月經不調者）。

方六：太子參3克，麥冬3克，生甘草3克，玄參3克，銀花3克。泡開水當茶飲，每日一劑。

方七：人中白10克，龍胆草6克，淡竹葉10克，生地10克，元參10克，蒲公英30克，柴胡6克，連翹12克，生石膏（先熬）30克，夜交藤30克，合歡皮15克。水煎服。

本方以人中白為主，取其“降相火，消瘀血”（《本草綱目》）之作用也。

方八：黨參30克，肉桂3克，黃連3克，五味子10克，元參10克，知母10克，白芍10克，細辛3克，補骨脂10克，淮牛膝30克，甘草3克。水煎服。

本方運用了双向調節的方法，寒熱并用，陰陽互濟，引火歸原，療效較好。

方九：萊菔子10克，白芥子10克，地肤子10克，用文火炒至微黃，共研細末，用食醋加溫後調成膏狀，把藥膏敷貼在兩足心涌泉穴，紗布包紮，每日換一次。

本方适用于小儿口疮。

方十：生地30克，木通10克，黄芩10克，栀子10克，大黄10克，连翘12克，天花粉10克，甘草梢10克。水煎服。

方十一：煨人中白、白芷粉各100克，冰片15克。先用干毛刷将人中白灰尘刷净后，置于瓦上用火煨透（勿使焦），然后将煨人中白与冰片共研成细末，过120孔筛，与白芷粉调和均匀，装入玻璃瓶密封备用。

用时，取药面少许放于口腔溃疡面上，每日2—3次。

方十二：生脉注射液4毫升，加50%葡萄糖液20—40毫升静脉注射，每日一次，每10天为一疗程，每疗程间隔3—5天。一般治疗3—5个疗程即可。

生脉注射液，由人参、麦冬、五味子三味药组成，这三味药都含有生物活性的多糖体，称为免疫型中草药，能增强机体的免疫功能，提高机体的抗病力。据报道，多糖类植物如人参根多糖有增强网状内皮系统机能的作用，可使吞噬功能增强。

复发性口腔溃疡是一种免疫反应性疾病，这种病之所以反复发作经久不愈，说明机体细胞内的环状腺嘌呤核苷酸和鸟嘌呤核苷酸两种物质的比值失调，如果这种失调得不到纠正，其症状就得不到彻底修复，而生脉注射液之所以能治愈复发性口腔溃疡，可能是调节了上面两种物质的比值，使之达到了相对的平衡。

口疮的复发问题，是一个不易解决的问题，因其发病因素复杂。耿鉴庭老中医主张，针对脏器的不同失衡情况，选用下列药物进行调治。

益脾阴：黄精。

补脾去湿热：玉竹。

散脾火：藿香（少量即可）。

健脾：山药，白术。

滋肾水：玄参。

益肾阳引热下行：肉苁蓉（兼润肠）。

清胃益肾：石斛。

清补脾肺生津：人参叶。

柔肝生津：绿萼梅花。

清心：灯心、莲子心、竹叶心。

补心营：丹参。

和血：当归。

补气生肌：黄芪（气实禁用）。

去上焦热，生肉复肌：蔷薇花瓣。

肃清上焦火邪兼益脾：柿霜。

大便干：麻仁。

根据以上经验，可用：黄精30克，山药60克，石斛30克，黄芪60克，莲心10克，玄参30克，绿萼梅花15克，柿霜10克，共研细末，炼蜜为丸，长期服用，每次服10克，每日服三次，对减少口疮复发，大有裨益。

或长期服用零余子（山药藤上的珠芽，俗称山药豆、山药果），对减少口疮复发也有帮助。

[G e n e r a l I n f o r m a t i o n]

书名=百病良方 第三集

作者=贾河先编著

页数= 1 7 3

S S 号= 1 0 4 6 1 3 2 9

出版日期= 1 9 8 6 年 1 2 月第 1 版